



MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE



République de Côte d'Ivoire
Union - Discipline - Travail

UNITÉ PÉDAGOGIQUE

INFECTION A VIH

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



L1
TC

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE**

2025- 2026



Yemman

SOMMAIRE

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES.....	5
LISTE DES TABLEAUX.....	6
LISTE DES FIGURES.....	7
AVANT-PROPOS.....	8
CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES IST.....	9
1. DEFINITION.....	9
2. NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES IST.....	10
3. STRATEGIES DE CONTROLE DES IST.....	11
4. APPROCHES DE PRISE EN CHARGE DES IST.....	11
5. ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE.....	12
6. COMPLICATIONS DES IST.....	25
7. CONCEPT DOUBLE PROTECTION.....	25
CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR L'INFECTION A VIH.....	28
1. HISTORIQUE DE L'INFECTION A VIH.....	28
2. EPIDEMIOLOGIE.....	29
3. IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE.....	35
CHAPITRE 3 : ETIOPATHOGENIE-HISTOIRE NATURELLE- CLASSIFICATION.....	38
1. ETIOPATHOGENIE DE L'INFECTION A VIH.....	38
2. HISTOIRE NATURELLE.....	44
3. EVALUATION CLINIQUE ET CLASSIFICATIONS.....	46
CHAPITRE 4 : SERVICES DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH.....	53
I. PRINCIPES DU CHANGEMENT DE L'ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH.....	53
1. OBJECTIF GENERAL.....	53
2. OBJECTIFS SPECIFIQUES.....	53
3. METHODES DIAGNOSTIC DU VIH.....	53
4. STRATEGIES ET ALGORITHMES.....	56
5. CRITERES DE CHOIX TEST ET ALGORITHME.....	56
6. PRINCIPE DU CHANGEMENT D'ALGORITHME.....	57
7. RECOMMANDATIONS DE L'OMS POUR UN DIAGNOSTIC VIH FIABLE.....	57
8. ETAPES D'ELABORATION DE L'ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH A 3 TESTS.....	58
9. EVALUATION DU NOUVEL ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH EN COTE D'IVOIRE.....	58
II. NOUVELLES DIRECTIVES NATIONALES DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH.....	60
1. UTILISATION D'UN ALGORITHME SEQUENTIEL A 3 TESTS RAPIDES POUR LE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH.....	60
2. LA REFERENCE DES CLIENTS VERS LES SERVICES DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE.....	63
III. PROCEDURES DE REALISATION DES TESTS RAPIDES DU NOUVEL ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH.....	64
1. TESTS RAPIDES UTILISES DANS LES ALGORITHMES A 03 TESTS.....	64
2. PHASES DU DEPISTAGE PAR LES TESTS RAPIDES.....	66

3. PROCEDURES DE REALISATION DES TESTS RAPIDES.....	67
4. INTERPRETATION DES RESULTATS DES TESTS RAPIDES.....	70
IV. CAS PARTICULIER DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE CHEZ L'ENFANT : DBS.....	70
1. OUTILS DIAGNOSTIQUES.....	70
2. STRATEGIE DE DIAGNOSTIC DE L'ENFANT.....	71
3. STATUT FINAL DE L'ENFANT.....	73
4. PROCEDURES DE PRELEVEMENTS ET DE REALISATION DU DBS POUR LA PCR.....	83
5. PROCEDURES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES SERVICES DE DEPISTAGE DU VIH.....	84
6. CONSEIL AU POSTE DE DEPISTAGE.....	86
7. DIFFERENTS TYPES DE SERVICES DE DEPISTAGE.....	86
8. COUNSELING DU VIH.....	91
CHAPITRE 5 : STRATEGIES DE PREVENTION DE L'INFECTION A VIH/SIDA.....	91
1. PREVENTION DE LA TRANSMISSION SEXUELLE.....	92
2. PREVENTION DE LA TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE DU VIH.....	92
3. PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE-ENFANT.....	92
MODULE 1 : OEV. GENERALITES SUR LE VIH ET LE SIDA.....	97
I. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES.....	97
1. Au niveau mondial et régional (Afrique subsaharienne) selon ONUSIDA 2022.....	97
2. Au niveau national (Selon les estimations du SPECTRUM 2023).....	97
II. MODES DE TRANSMISSION.....	98
III. FACTEURS DE RISQUES ET IMPACT DU VIH ET DU sida (1/6).....	99
1. Facteurs de risques liés à la sexualité, aux modes de vie comportementaux et aux activités socio-économiques et culturels.....	99
2. Facteurs aggravant l'impact de la maladie.....	100
MODULE 2 : GENERALITES SUR LES OEV ET LEURS FAMILLES EN LIEN AVEC LE VIH.....	101
I. DEFINITION DES CONCEPTS ET DES TERMES CLÉS.....	101
II. CONCEPT OEV EN LIEN AVEC LE VIH ET LE sida EN CÔTE D'IVOIRE.....	101
III. PROBLEMES RENCONTRES PAR LES OEV, LES ADOLESCENT.E S ET LES JEUNES ADULTES.....	102
IV. PORTES D'ENTREE POUR L'IDENTIFICATION DES OEV.....	102
V. APPROCHE DE LA PROGRAMMATION VIH CENTREE SUR LA FAMILLE.....	103
Introduction.....	103
VI. GESTION DES CAS DANS L'APPROCHE FAMILLE.....	104
MODULE 3 : SOUTIEN AUX SOINS DE SANTE DES OEV.....	107
I. MANIFESTATIONS CLINIQUES PERMETTANT DE SOUPCONNER L'INFECTION LIÉE AU VIH CHEZ L'OEV L'ADOLESCENT.E ET LE JEUNE ADULTE (1/5).....	107
II. CONDUITE À TENIR DEVANT LES AFFECTIONS COURANTES LIÉES AU VIH CHEZ L'OEV L'ADOLESCENT.E ET LE JEUNE ADULTE.....	108
III. NOTIONS DE BASE SUR LE TRAITEMENT ARV DE L'INFECTION À VIH.....	112
IV. OBSERVANCE ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT.E ET DU JEUNE ADULTE VIVANT AVEC LE VIH.....	113
V. PREVENTION PRIMAIRE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES.....	115
MODULE 4 : SOUTIEN A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET A.....	

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION	117
CHAPITRE 2 : ACTIONS ESSENTIELLES EN NUTRITION (AEN)	119
CHAPITRE 3 : ALIMENTATION DE L'OEUVRE, DE L'ADOLESCENT.E ET DU JEUNE ADULTE AFFECTES OU INFECTES PAR LE VIH	124
CHAPITRE 4 : SUIVI ET PROMOTION DE LA CROISSANCE	125
CHAPITRE 5 : MALNUTRITION	130
CHAPITRE 6 : STRATEGIES POUR LUTTER CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE	134
MODULE 5 : DES MODULES DROITS HUMAINS RELATIFS AUX PVVIH	135
I. STIGMATISATION ET DISCRIMINATION	135
1. DEFINITIONS	135
2. TYPES	135
3. SOURCES	136
4. DISCRIMINATION	136
5. MANIFESTATIONS	136
6. LES CONSEQUENCES	137
7. SOLUTIONS	137
8. RELATION STIGMATISATION, DISCRIMINATION ET DROIT DE L'HOMME	138
II. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)	138
1. DEFINITIONS DES NOTIONS CLÉS	138
2. LES TYPES DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE	139
3. LES FACTEURS FAVORISANTS LES VBG	140
4. LES CONSEQUENCES DES VBG SUR LES PERSONNES SURVIVANTES/ VICTIMES	140
III. INTRODUCTION AUX VIOLENCES DOMESTIQUES	140
1. DEFINITION DES VIOLENCES DOMESTIQUES	140
2. LES FORMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES	140
3. LES CAUSES DES VIOLENCES DOMESTIQUES	140
4. LES CONSEQUENCES DES VIOLENCES DOMESTIQUES	140
5. DIFFERENCE ENTRE LA VBG ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE	140
IV. LA LOI N°430-2014 DU 14 JUILLET 2014 PORTANT REGIME DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE REPRESSION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	140
1. LES PRINCIPES DE LA PREVENTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA	140
2. LA PROTECTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA	140
3. LA REPRESSION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA	140
ANNEXES	145

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES

AES	Accident par Exposition au Sang
AD-VIH	Autotest de Dépistage VIH
ARV	Antirétroviraux
CD	Conseil et Dépistage
CDC	Center for Disease Control and Prevention
CDIC	Conseil et Dépistage à l'Initiative du Client
CDIP	Conseil et à Dépistage l'Initiative du Prestataire
CDV	Conseil et Dépistage Volontaire
CD4	Lymphocyte T4
CPN	Consultation Prénatale
CHR	Centre Hospitalier Régional
CHU	Centre Hospitalier Universitaire
CS	Centre de Santé
DBS	Dried Blood Spot
DFRS	Direction de la Formation et de la Recherche en Santé
DIIS	Direction de l'Informatique et de l'Information Sanitaire
DITRAME	Projet sur la Transmission Mère-Enfant
EIS	Enquêtes sur les Indicateurs du Sida
ESPC	Etablissement Sanitaire de Premier Contact
FS	Formation Sanitaire
HG	Hôpital Général
HRSA	Health Resources Service and Administration
HSB	Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
ICAP	International Care of AIDS Program
IO	Infections Opportunistes
INFAS	Institut National Formation des Agents de la Santé
IST	Infections Sexuellement Transmissibles
NPSP-CI	Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONG	Organisations Non Gouvernementales
ONUSIDA	Programme conjoint des Nations Unies contre le Sida
PMA	Paquet Minimum d'Activités
PEPFAR	President's Emergency Plan For Aids Relief
PCR ADN	Réaction de Polymérisation de la Chaîne de l'Acide Désoxy Nucléide
PNLS	Programme National de Lutte contre le Sida
PNLT	Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PTME	Prévention de la Transmission Mère-Enfant
PVVIH	Personnes Vivant avec le VIH
RETROCI	Projet Rétrovirus Côte d'Ivoire
SDV	Service de Dépistage du VIH
SFPS	Santé Familiale et Prévention du Sida
TDRD	Test de Dépistage Rapides de Diagnostic
TS	Travailleur du Sexe
UDI	Utilisateur de Drogues injectables
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
USAID	United States Agency For International Development
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : IST d'origine bactérienne	10
Tableau II : IST d'origine parasitaire et mycosique	10
Tableau III : IST d'origine virale	10
Tableau IV : Avantages et limites des approches de prise en charge des IST	12
Tableau V : Evaluation des facteurs de risque de cervicite	17
Tableau VI : Facteurs de risque de la TME du VIH	31
Tableau VII : Déterminants de la propagation du VIH	32
Tableau VIII : Vue d'ensemble de l'épidémie de Sida 2022	34
Tableau IX : Evolution de l'infection à VIH chez l'enfant	46
Tableau X : Indice de Karnofsky	47
Tableau XI : Classification clinique (OMS)	48
Tableau XII : Classification immunologique du déficit associé au VIH (OMS 2005)	50
Tableau XIII : Classification CDC 1993	51
Tableau XIV : Classification immunologique CDC1994	52
Tableau XV : Classification clinique et immunologique du malade	52

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Syndrome d'écoulement urétral chez l'homme	15
Figure 2 : Syndrome d'écoulement vaginal	17
Figure 3 : Syndrome d'ulcération génitale	19
Figure 4 : Nombre de PVVIH estimée par district 2023	35
Figure 5 : Impact du VIH/sida sur les ménages en milieu urbain en Côte d'Ivoire (traduit de la version anglaise)	36
Figure 6 : Schéma de la structure d'un virus	39
Figure 7 : Structure du VIH-1 d'après « Traité de virologie médicale », J.M.Huraux, éditions Estem, France, 2003	40
Figure 8 : Organisation génomique du VIH	41
Figure 9 : Cycle de réplication du VIH	43
Figure 10 : Schéma de l'histoire naturelle de l'infection à VIH	45
Figure 11 : Liaison antigène-anticorps	55
Figure 12 : Algorithme en vigueur au laboratoire	61
Figure 13 : Kit de dépistage VIH Détermine	64
Figure 14 : Kit Stat- pak	65
Figure 15 : Kit de Bioline HIV/Syphilis Duo	66
Figure 16 : Algorithme pour le diagnostic pédiatrique du VIH	72
Figure 17 : Représentation des liens entre l'OEV et le VIH	102
Figure 18 : Etapes de la gestion des cas dans les programmes OEV	105

AVANT-PROPOS

Des progrès importants ont été accomplis dans le pays dans le cadre du passage à l'échelle de l'offre de services de prévention, de soins et traitement de l'infection à VIH notamment dans la formation des professionnels de la santé afin de contenir la riposte de cette infection.

La formation des professionnels de santé constitue une étape importante dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH. A cet effet, les infirmiers et sages femmes étant à tous les niveaux de la pyramide des soins, leur contribution est d'autant plus importante que celle des médecins. Ainsi, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a défini des tâches de soins et traitement de l'infection à VIH à cette catégorie de professionnels de santé à travers la note circulaire de délégation de tâches du 3 septembre 2015. Dès lors, il y a eu une série de sessions de formation à l'endroit des infirmiers et sages femmes dans les centres de santé sur toute l'étendue du territoire national.

Ces formations qui devraient permettre de disposer du personnel paramédical qualifié compétent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ont nécessité de très importants moyens logistiques et financiers.

L'INIFAS qui a pour mission la formation initiale de ces infirmiers et sages femmes s'engage à accompagner le Ministère en introduisant dans les curricula de formations à base, des cours sur la prise en charge de l'infection à VIH/Sida.

Ce manuel constitue une unité de valeur pour le niveau de Licence 1. Il contient les chapitres qui sont :

- Généralités sur les IST-VIH/Sida ;
- Généralités sur l'infection à VIH ;
- Etiopathogénie-histoire naturelle- classification ;
- Services de dépistage de l'infection à VIH ;
- Stratégies de prévention de l'infection à VIH/Sida ;

La révision de 2024 vise à prendre en compte les directives nationales de 2024 mises à jour sur la base des recommandations OMS 2021-2023 avec l'appui financier de PEPFAR à travers CDC et l'appui technique de I-TECH CIV.

La Direction de l'INIFAS tient à remercier et à témoigner toute sa reconnaissance à toutes ces institutions qui lui ont apporté et continuent de lui offrir leur expertise technique et expérience programmatique.

LE DIRECTEUR DE L'INIFAS

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES IST

INTRODUCTION

Les infections sexuellement transmissibles (IST) appelées autrefois maladies sexuellement transmissibles (MST) sont des infections transmises entre deux partenaires au cours de différents formes de rapports sexuels qui comportent un contact génital ou oro-génital avec un autre partenaire ou ses fluides génitaux. Elles figurent parmi les cinq mois de consultation dans nos structures sanitaires et la deuxième cause de morbidité chez les femmes en âge de procréer.

Les IST sont des facteurs favorisant de la transmission de l'infection à VIH/sida d'où l'importance de leur prise en charge. Il importe de reconnaître les symptômes et de prescrire un traitement syndromique accessible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Objectif général

A la fin du chapitre l'étudiant doit être capable d'assurer la prise en charge correcte des cas d'IST.

Objectifs spécifiques

A la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

1. Décrire les différentes approches de prise en charge des IST
2. Assurer la prise en charge des cas d'IST selon l'approche syndromique
3. Assurer la prise en charge correcte des partenaires des clients IST
4. Expliquer le concept de « double protection » aux clients IST.

Plan du cours

1. Définition
2. Niveaux de prise en charge des IST
3. Stratégies de contrôle des IST
4. Approches de prise en charge des IST
5. Etapes de la prise en charge syndromique
6. Concept double protection

1. DEFINITION

Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont des affections contagieuses dues à des microorganismes multiples et variés, liées entre elles par un même mode de transmission : les rapports sexuels. Les germes responsables sont d'origine bactérienne, parasitaire, mycosique et virale.

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux germes en cause :

Tableau I : IST d'origine bactérienne

Nom de la Bactérie	Nom de la maladie
Chlamydia trachomatis type DK	Chlamydie
Chlamydia trachomatis type L1, L2, L3	Maladie de Nicolas Favre ou lymphogranulome vénérien
Gardnerellavaginalis	Vaginose ou agent de la malodeur vaginale
Haemophilusducreyi	Chancre mou
Calymmatobacteriumgranulomatis	Donovanose
Mycoplasma hominis ; Ureaplasma urealyticum	Mycoplasmosse
Neisseria gonorrhoeae	Gonococcie
Treponema pallidum pallidum	Syphilis

Tableau II : IST d'origine parasitaire et mycosique

Nom du parasite ou du champignon	Nom de la maladie
Sarcoptes scabiei hominis	Gale
Phthirus pubis	Phthiriose
Trichomonas vaginalis	Trichomonose
Candida albicans	Candidose

Tableau III : IST d'origine virale

Nom du virus	Nom de la maladie
Herpès simplex virus type II	Herpès génital
Papillomavirus humains	Condylomes acuminés ou végétations vénériennes ou crêtes de coq
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH1/VIH2)	Infection à VIH / sida
Virus des Hépatites B et C	Hépatites B et C

Remarque :

Le terme « d'Infections du Tractus Génital » ou « ITG » désigne toutes les infections des organes génitaux, à savoir les « Infections Sexuellement Transmissibles (IST) » et celles qui ne sont pas toujours transmises par voie sexuelle.

2. NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES IST

La lutte contre les IST est mise en œuvre dans toutes les structures de santé (des secteurs public, privé, militaire, entreprises) des milieux urbain et rural au regard des trois niveaux d'intervention IST identifiés dans la pyramide sanitaire.

Le niveau IST 2 correspond aux structures qui disposent d'un laboratoire équipé, tenu par un biologiste ou un biotechnologiste compétent, pour microscopie et tests rapides IST/VIH. La prise en charge est alors adaptée aux germes retrouvés.

Le niveau IST 3 : C'est le dernier niveau de référence en Côte d'Ivoire. Il est celui des spécialistes que sont : les Dermato-vénérologues, les Gynéco obstétriciens, les Pédiatres, les Ophtalmologues, les Chirurgiens et le Laboratoire de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. La prise en charge est alors adaptée après test de sensibilité in vitro des germes retrouvés.

3. STRATEGIES DE CONTROLE DES IST

Il existe deux stratégies prioritaires pour le contrôle des IST : la prévention et le traitement précoce et efficace des cas d'IST.

La prévention

Elle vise la réduction des risques d'infection (ou de contagiosité), du nombre des partenaires et des contacts sexuels à risque. Elle est primaire et secondaire.

La prévention primaire comporte le changement de comportement (réduction du nombre de partenaires) et l'utilisation des préservatifs (amélioration de la disponibilité des préservatifs).

La prévention secondaire est la prise en charge précoce des cas d'IST. Elle permet d'éviter les complications des IST et la transmission du VIH/sida. Elle est donc une prévention primaire du VIH/sida.

Traitement précoce et efficace des cas d'IST

Elle vise non seulement à diminuer la durée de la contagiosité mais aussi à limiter le nombre de nouveaux cas.

La prise en charge précoce et efficace a pour but d'interrompre la chaîne de transmission des IST et d'empêcher le développement des formes évoluées, des complications et des séquelles. Cependant elle n'est possible que pour les IST curables.

Autres stratégies

La prise en charge des partenaires.

Les interventions ciblées auprès des groupes vulnérables (OEV, populations carcérales, les migrants...) et des groupes-noyaux « core groups » (TS, HSH, UDI)

4. APPROCHES DE PRISE EN CHARGE DES IST

L'on définit 3 approches de prise en charge des IST. Ce sont :

- Approche clinique qui vise à identifier une maladie à partir de l'interrogatoire et de l'examen physique. Elle est basée sur les signes cliniques des IST et l'expérience du clinicien.
- Approche étiologique qui est basée sur les données de l'interrogatoire, de l'examen physique et des tests de laboratoires. L'approche étiologique constitue la stratégie idéale pour prendre en charge les clients IST. Pour réaliser cette stratégie, il est nécessaire d'avoir à sa disposition un laboratoire adéquat capable d'effectuer des examens précis. Les manifestations cliniques des différentes IST peuvent être similaires, ce qui nécessite le recours au laboratoire pour les différencier.
- Approche syndromique qui est basée sur l'identification de groupes de signes et de symptômes appelés syndromes, faciles à reconnaître à partir des données de l'interrogatoire et de l'examen physique.

- Végétations Vénériennes ou condylomes ou crête de coq
- Conjonctivite du nouveau-né

Chacune de ces approches a des avantages et des limites qui sont résumés dans le tableau comparatif ci-dessous.

Tableau IV : Avantages et limites des approches de prise en charge des IST

APPROCHES	AVANTAGES	LIMITES
CLINIQUE	-Soulagement rapide - Applicable partout -Moins onéreuse à court terme -Indépendance du laboratoire	-Erreur de diagnostic et de traitement -Favorise les résistances -Ignore les infections mixtes - Ignore les formes asymptomatiques - Difficulté de l'annonce aux partenaires
ETIOLOGIQUE	-Précision diagnostique -Traitement spécifique - Prend en compte les infections mixtes -Dépiste les formes asymptomatiques -Adaptation du traitement aux profils des résistances	-Nécessite un laboratoire -Tests peu accessibles -Coût parfois élevé -Traitement différé
SYNDROMIQUE	-Prend en compte les infections multiples -Prise en charge immédiate -Efficacité précoce -Simplicité -Applicable partout -Coût réduit à long terme	-Traitement par excès -Clients asymptomatiques non pris en compte - Difficulté de l'annonce aux Partenaires

5. ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE SYNDROMIQUE

Comme pour tout motif de consultation médicale, elle nécessite 7 étapes :

1. Accueil et Interrogatoire
2. Examen physique
3. Diagnostic syndromique
4. Traitement
5. Entretien /conseil (Le counseling)

- ✓ Ecouter attentivement le client
- ✓ Ne pas juger le client
- ✓ Utiliser un vocabulaire accessible
- ✓ Etre disponible
- ✓ Eviter d'interrompre le client de façon intempestive
- ✓ Etre courtois

• Recueil d'informations :

Questions générales

- ✓ Recueillir les Noms et Prénoms, le sexe, l'âge, l'adresse, le statut matrimonial, la profession du client. etc.
- ✓ Motif(s) de la consultation
- ✓ Déterminer les symptômes ou les plaintes qui ont motivé la consultation, leur durée, les traitements antérieurs et l'évolution.
- ✓ Les antécédents et mode de vie

Evaluation des risques :

▪ Mode de vie

Oblige le prestataire de santé à aborder les questions intimes, notamment celles concernant les pratiques sexuelles du client avec ses ou son partenaire (s) sexuel (fellation, rapport par voie anale...).

Parfois de rechercher l'orientation sexuel ou du travail du sexe du client(e).

La consommation du tabac, de l'alcool, de la drogue et des aphrodisiaques (comprimé, autres substances...) doit être recherchée. Si consommation de drogue, rechercher des informations liées à la dépendance et la voie d'administration (AES pour les formes injectables).

▪ Antécédents

Il faut passer en revue tous les antécédents des clients (médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétricaux).

Ils permettent d'identifier les clients les plus exposés aux IST à travers des questions faciles dont le but est de mesurer les risques de chaque client de contracter l'infection à VIH/SIDA.

Outre les données générales, sur la profession du partenaire, la notion de voyage, de consommation de drogue et d'abus d'alcool.

L'histoire sexuelle et le comportement du client : Nombre de partenaires, type de partenaires, partenaires sexuels récents, partenaires infectés par une IST, utilisation ou non de préservatifs.

Le comportement sexuel, éventuellement à risque, du(es) partenaire(s).

L'évaluation des risques peut aider à éduquer et à conseiller les clients en fonction de leurs problèmes.

Elle peut également aider à prendre les décisions thérapeutiques.

Les questions destinées à mesurer les risques du client, doivent être adaptées à la réalité locale. Il faut poser des questions faciles avec tact et sans insister.

- ✓ Rechercher des pertes ou d'éventuelles lésions (ulcérations, végétations, vésicules, tuméfaction).
- Examen de l'abdomen :
 - ✓ Rechercher une éventuelle douleur, une défense ou la présence d'une masse abdominale.
- Examen du vagin et du col :
 - ✓ Rechercher des leucorrhées, des lésions (ulcérations, excroissances), d'autres anomalies avec un spéculum
 - ✓ Rechercher une douleur de la sphère génitale haute pouvant évoquer une maladie inflammatoire pelvienne par le toucher vaginal combiné au palper abdominal (Examen bi-manuel) en appréciant le col, l'utérus et les ovaires.
- Examen de la cavité buccale :
 - ✓ Rechercher une ulcération, une candidose buccale, des macules, des plaques ou des nodules évoquant une maladie de Kaposi et de végétations.
- Examen de la peau : rechercher des ulcérations, des lésions de syphilis secondaire et des lésions de maladie de Kaposi.

Chez l'homme

- Examen du pénis :
 - ✓ Rechercher la présence d'éruptions et d'ulcérations
 - ✓ Chez le client non circoncis, dérouler le prépuce et examiner le gland, le sillon préputial, le frein et le méat urétral.
 - ✓ S'il n'y a pas d'écoulement urétral évident, masser l'urètre pour voir s'il n'y en a pas
- Examen du scrotum et des testicules :
 - ✓ Palper pour essayer de déceler d'éventuelles anomalies des testicules, de l'épididyme ou du cordon spermatique.
- Examen du pubis :
 - ✓ Rechercher la présence de morpion (*Phthirus inguinalis*), de végétations ou d'ulcération
- Examen de l'anus :
 - ✓ Rechercher des lésions ulcéreuses, des végétations et des écoulements
- Examen de la cavité buccale :
 - ✓ Rechercher une ulcération, une candidose buccale, des macules, des nodules évoquant une maladie de Kaposi et des végétations.
- Examen des aires ganglionnaires surtout de la région inguinale
 - ✓ Rechercher des adénopathies localisées ou généralisées.
- Examen de la peau :
 - ✓ Rechercher des éruptions, des ulcérations, des lésions de syphilis secondaire, des lésions de maladie de Kaposi des cicatrices de zona.

5.3. 3^{ème} étape : diagnostic

Plusieurs germes pathogènes nécessitant un traitement différent provoquent cependant des symptômes comparables. Le diagnostic syndromique est basé sur l'association du motif de consultation et de signes observés à l'examen physique. Dans le cadre de la lutte contre les IST en Côte d'Ivoire 7 syndromes IST ont été identifiés :

- Syndromes d'écoulement urétral et /ou anorectal masculin
- Syndromes d'écoulement vaginal et /ou anorectal chez la femme
- Syndromes de douleurs abdominales basses chez la femme
- Syndromes de douleurs testiculaires

- Syndromes d'ulcérations génitales et/ou bubon
- Syndromes de végétations vénériennes ou condylome
- Conjonctivite du nouveau-né

5.3.1 Syndrome d'écoulement urétral chez l'homme

Il s'agit de plaintes exprimées par le client se manifestant par une sécrétion anormale provenant du méat urétral accompagnée ou non de prurit, de dysurie, de picotements ou de brûlures mictionnelles. C'est le syndrome IST le plus fréquent chez l'homme. L'aspect de l'écoulement urétral est variable. L'abondance va de l'écoulement franc aux petites tâches sur le linge, voire seulement une goutte au niveau du méat urétral observée le matin lors de la première miction. Caractéristiques de l'écoulement urétral chez l'homme : Purulent (blanchâtre, ou jaune verdâtre) ou séreux (transparent). Abondant ou peu abondant. S'accompagne souvent de brûlures mictionnelles et de picotements du méat urétral.

Causes de l'écoulement urétral

Les causes fréquentes

- Gonococcie (*Neisseria gonorrhoeae*)
- Chlamydiose (*Chlamydia trachomatis*)
- Infections à Mycoplasmes (*Mycoplasma hominis*)

La cause moins fréquente

Trichomonoses (*Trichomonas vaginalis*)

Stratégie recommandée en présence d'un écoulement urétral chez l'homme

Le traitement recommandé en présence d'un écoulement urétral est celui qui associe le traitement de la gonococcie, de la chlamydiose et celui de la mycoplasmosé. Les clients présentant un écoulement urétral doivent être traités en même temps, dès la première consultation pour : La gonococcie La chlamydiose La mycoplasmosé En cas de persistance de symptômes, les clients doivent être traités pour la trichomonose.



Figure 1 : Syndrome d'écoulement urétral chez l'homme

5.3.2 Syndrome d'écoulement vaginal

Le syndrome d'écoulement vaginal et/ou brûlures ou prurit vaginal

5.3.2.1 Ecoulement vaginal physiologique

Tout écoulement vaginal n'est pas toujours pathologique. Il peut en effet être physiologique : il est alors sans odeur, de moyenne abondance, sans signe fonctionnel. L'écoulement vaginal physiologique est observé dans les circonstances suivantes :

- Ovulation
- Règles
- Grossesse
- Accouchement

5.3.2.2 Ecoulement vaginal anormal

Il s'agit d'une modification de la quantité, de la consistance, de la couleur ou de l'odeur des pertes vaginales. Les pertes dues à une infection peuvent s'accompagner d'irritation, de prurit vulvaire, de dysurie, de douleurs pelviennes ou de dyspareunie. La présence d'écoulement vaginal anormal est la manifestation d'une vaginite et/ou d'une cervicite.

5.3.2.3 Causes de l'écoulement vaginal

Les vaginites peuvent être causées par :

- Candida albicans,
- Gardnerella vaginalis
- Trichomonas vaginalis.

Ces germes, plus fréquents et moins pathogènes ne sont pas nécessairement transmis sexuellement.

Les cervicites peuvent être causées par :

- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis
- Mycoplasmes

Ces germes moins fréquents et plus pathogènes sont exclusivement transmis sexuellement.

La prise en charge correcte des cervicites est très importante du point de vue de la santé publique car non ou mal traitées, elles peuvent entraîner des séquelles graves. Il n'est pas toujours facile de faire le diagnostic de la cervicite.

La présence de sécrétions muco-purulentes au niveau du col est très évocatrice d'une cervicite, mais exige un examen au spéculum.

C'est pourquoi l'OMS recommande d'avoir recours à l'évaluation du risque pour différencier une vaginite d'une cervicite en dehors d'études sur la prévalence des cervicites.

L'évaluation se fait sur la base de facteurs de risque comme l'âge, l'état matrimonial, le comportement sexuel et la présence de symptômes IST chez le partenaire (Tableau V).

Si le score est inférieur à 2, il s'agit d'une vaginite

Si le score est égal ou supérieur à 2, il s'agit d'une cervicite.

Tableau V : Evaluation des facteurs de risque de cervicite

Facteur de risque évalué	Réponse	Score
Douleurs pelviennes/Dyspareunie	oui	2
Notion d'un partenaire infecté par une IST (présence d'un écoulement urétral ou d'une ulcération génitale au cours du dernier mois) ?	oui	2
Age inférieur à 25 ans ?	oui	1
Notion de plus d'un partenaire sexuel les trois derniers mois ?	oui	1
Célibataire ?	oui	1

5.3.2.4 Stratégie recommandée en cas d'écoulement vaginal

Le traitement de la cervicite comprend les traitements de la :

- Gonococcie
- Chlamydie
- Mycoplasme
- Trichomonase
- Vaginobactérienne
- Candidose

Le traitement de la vaginite seule associe le traitement de la :

- Trichomonase,
- Vaginose bactérienne
- Candidose

Le traitement de l'écoulement vaginal associe au traitement médicamenteux les mesures d'hygiène suivantes :

- Arrêt des injections vaginales ;
- Abandon des savons et antiseptiques acides ;
- Ne pas utiliser de sous-vêtements synthétiques...

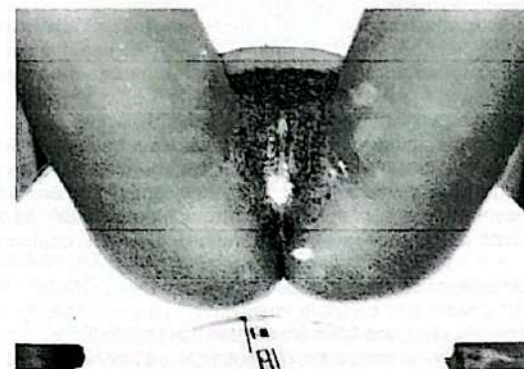


Figure 2 : Syndrome d'écoulement vaginal

5.3.3 Syndrome de douleur testiculaire

C'est une douleur du testicule avec ou sans gonflement du scrotum. A l'examen, il est souvent d'une atteinte unilatérale : le scrotum est tuméfié et sensible à la palpation. N.B. : devant une douleur testiculaire très intense unilatérale de survenue brutale, sans notion de traumatisme chez un adulte jeune, il faut penser à une torsion testiculaire, ce qui est une urgence chirurgicale.

5.3.3.1 Germes en cause

Les germes en cause les plus fréquents de la douleur testiculaire sont :

- Le *Neisseria gonorrhoeae*
- Le *Chlamydia trachomatis*.

5.3.3.2 Stratégie recommandée devant une douleur testiculaire

Le client présentant une douleur testiculaire doit être traité simultanément pour :

- la gonococcie
- la chlamydiose

Le schéma thérapeutique recommandé est celui indiqué dans le guide national de traitement N.B. : Référer systématiquement si vous êtes au niveau IST 1.

5.3.4 Douleur abdominale basse chez la femme et Maladie Inflammatoire Pelvienne (MIP)

5.3.4.1 Symptômes de la MIP

Les symptômes suggérant une MIP comprennent :

- Douleurs abdominales basses
- Douleur pendant les rapports sexuels en cas de pénétration profonde
- Pertes vaginales
- Saignements utérins anormaux excessifs
- Miction douloureuse
- Douleurs associées aux menstruations
- Fièvre
- Nausées et/ou vomissements occasionnels

5.3.4.2 Caractéristiques cliniques

Les douleurs abdominales basses constituent une manifestation courante de la MIP, donc elles doivent toujours être prises en compte sérieusement. Cependant, les douleurs abdominales basses sont également extrêmement fréquentes chez les femmes, mais toutes les femmes souffrant de douleurs abdominales basses ne sont pas atteintes de MIP.

NB : Le symptôme de douleurs abdominales basses peut également indiquer d'autres états graves tels qu'une grossesse extra-utérine, l'appendicite, un abcès pelvien ou une complication de la grossesse, telle qu'un avortement incomplet, un avortement incomplet septique et une septicémie puerpérale. En tant que professionnel de la santé, il est important de pouvoir différencier la MIP des autres causes de douleurs abdominales basses.

La MIP est difficile à diagnostiquer car les symptômes et signes cliniques sont variés. Cependant, la MIP devient très probable lorsqu'un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus sont observés chez une femme avec une sensibilité des annexes, des preuves d'infection du système génital inférieur, une sensibilité de l'utérus ou une sensibilité à la mobilisation du col de l'utérus.

La « sensibilité des annexes » signifie la sensibilité des structures secondaires (ovaires, trompes de Fallope, etc.) de l'utérus lors de l'examen bi-manuel. Il s'agit d'une observation

importante car elle peut indiquer une MIP, une grossesse extra-utérine ou une appendicite.

La sensibilité à la mobilisation du col de l'utérus correspond à la sensation désagréable ou la réponse provoquée lors de l'examen pelvien avec une mobilisation du col de l'utérus par la main gantée du praticien, indiquant généralement des processus inflammatoires dans les organes pelviens ou des organes adjacents pouvant être déplacés pendant cet examen. Elle est également désignée comme le « signe du chandelier ».

5.3.4.3 Complications de la MIP

Environ un quart des femmes ayant eu un seul épisode de MIP symptomatique connaîtront des séquelles, telles qu'une grossesse extra-utérine, des douleurs pelviennes chroniques ou la stérilité. Les taux de stérilité tubaire augmentent avec chaque épisode récurrent de MIP (environ 8 % après un épisode, 20 % après deux épisodes, 40 % après trois épisodes).

5.3.5 Syndrome d'Ulcération Génitale (UG)

Les causes connues les plus courantes sont : Virus de l'herpès simplex type 2 (HSV2), *Haemophilus ducreyi* (chancres mous), *Treponema pallidum* (syphilis).

Les autres causes des ulcères génitaux comprennent : Une certaine variété de *Chlamydia trachomatis*, qui provoque le lymphogranulome vénérien (LGV) *Klebsiella granulomatis*, qui provoque le granulome inguinal (également connu sous le nom de *Donovanosis*).

L'infection à candida, qui peut entraîner une irritation chronique et l'apparition d'ulcères irrités. La gale et les infections provoquées par *Staphylococcus aureus* ou d'autres bactéries. Les hommes avec un prépuce serré (phimosis) peuvent développer des déchirures du prépuce après les relations sexuelles. Ces déchirures peuvent s'infecter et ressembler à des ulcères infectés.

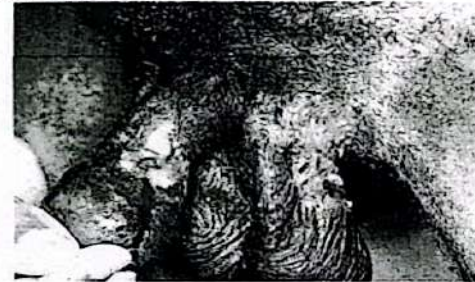


Figure 3 : Syndrome d'ulcération génitale

5.4. 4^{ème} étape : Traitement des IST selon l'approche syndromique

5.4.1. Différents kits IST

5.4.1.1 Ecoulement urétral et ou anorectal chez l'homme (niveau IST1) : Prescrire

Kit URET P composé de :

- Ceftriaxone 500 mg inj : 1 injection en IM dans une fesse,
- Azithromycine 500mg cp : 2cp en une prise orale

Revoir le client le 10^{ème} jour

Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaire(s)

Si Persistance malgré bonne observance, traiter le client pour gardnerellose, trichomonose, chlamydirose et mycoplasmosse

URET-S : kit URET-S, composé de :

- Métronidazole, 500 mg cp : 4 cp en prise unique orale
 - Azithromycine 500mg cp : 2cp/j en une prise orale pdt 3 jours
- Revoir le client le 24ème jour

5.4.1.2 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la Femme non enceinte (niveau IST1)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, trichomonose, gardnerellose) et cervicite et ou ano rectite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasmosse).

Kit CERV composé de : Ceftriaxone 500 mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Métronidazole 500 mg cp : 4 cp, en prise unique par VO • Azithromycine 500mg cp : 2cp/j en une prise unique pdt 3 jours par VO • Econazole 150 mg ovule : 1 ovule /j le soir au coucher, pdt 6 jours, Revoir la cliente le 10ème jour et le 24ème jour Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaires (candidose, trichomonose, gardnerellose).

Prescrire kit LEUCO- P composé de : • Métronidazole, 500 mg cp, 4 cp en prise unique par voie orale • Econazole 150 mg ovule : 1 ovule /j le soir au coucher, pdt 6 jours, Revoir la cliente le 10ème jour Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaires

5.4.1.3 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la femme enceinte (niveau IST1) (1)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, gardnerellose et trichomonose) et cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasme) : Prescrire.

kit CERVIGE composé de : • Ceftriaxone 500mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg cp : 1cp /j pdt 3 jours à partir du 2ème jour par voie orale • Econazole ovule 150mg : 1 ov/j le soir pdt 6 jours à partir du 1 er jour • Métronidazole cp 500 mg : 4cp en prise unique par voie orale Revoir la cliente le 10 eme jour

LEUCO S

Traiter la cliente pour cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasmosse) Prescrire kit LEUCO S composé de : • Ceftriaxone, 500 mg Inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg Cp : 2cp/J en une prise unique pdt 3 jours par voie orale Revoir la cliente le 24ième jour Expliquer la nécessité de traiter les partenaires

5.4.1.4 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la femme enceinte (niveau IST1) (2)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, gardnerellose et trichomonose) et cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasme) :

Prescrire kit CERVIGE composé de : • Ceftriaxone 500mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg cp : 1cp /j pdt 3 jours à partir du 2ème jour par voie orale • Econazole ovule 150mg : 1 ov/j le soir pdt 6 jours à partir du 1 er jour • Métronidazole cp 500 mg : 4cp en prise unique par voie orale Revoir la cliente le 10 eme jour

LEUCOGE-P

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, trichomonose, gardnerellose) Prescrire kit LEUCOGE-P composé de : • Métronidazole 500 mg cp, 4 cp en prise unique par voie orale • Econazole ovule 150 mg, 1 ov/j, le soir au coucher, pendant 6 jours, Ajouter une ordonnance de Butoconazole crème : une application 2x/j pdt 21 jrs Revoir la cliente le 10ème jour

LEUCOGE-S : Traiter la cliente pour cervicite (gonococcie, chlamydirose, mycoplasmosse) Prescrire kit LEUCOGE S composé de : • Ceftriaxone 500 mg inj : 1 amp IM dans une fesse • Azithromycine 500 mg Cp, 1cp /j pdt 3 j par voie orale Revoir la cliente 2 jours après la fin du traitement

5.4.1.5 Ulcération génitale et/ou anorectale et/ou bubon (Niveau IST 2)

ULGEN : Traiter le / la client(e) pour chancre mou, chancre syphilitique et herpès génital Prescrire Kit ULGEN composé de : • Ceftriaxone, 500 mg, 1 amp en IM unique dans une fesse • Benzathine Benzylpénicilline, 2,4 M UI, 1 amp en IM unique dans l'autre fesse Désinfection locale par Eosine aqueuse 2% matin et soir (non inclus dans le kit). Expliquer la nécessité de traiter les partenaires Revoir le (la) client (e) le 10ème jour

5.4.1.6 Douleur abdominale basse chez la femme non enceinte (Niveau IST 1)

SALPIN : Prescrire anti-spasmodique :

- N- buthylhyoscine comp (Buscopan), 2 cp où
- Tiémomium (viscéralgine simple) 1 amp IM et
- Référer la cliente au niveau IST1 avec compétence médicale ou au niveau IST2

5.5. 5ème étape Entretien/conseil

5.5.1 Définition

L'entretien/conseil qui constitue la cinquième étape de la prise en charge syndromique des IST est défini comme une communication interpersonnelle confidentielle entre un client (seul ou en couple) de et le prestataire de santé. Il a pour but d'aider le client ou le couple à prendre ses propres décisions.

5.5.2 Techniques

Cet entretien/conseil suit les mêmes principes de communication interpersonnelle que dans le cas du counseling du VIH :

- Avoir les compétences d'un bon conseiller
- Maîtriser les techniques de communication

Elles aident à établir un bon rapport avec le client/couple. Il existe deux types de techniques de communication :

- Techniques de communication verbale
- Techniques de communication non verbale

- Aborder des thèmes appropriés lors de l'entretien/conseil :

- Les voies de transmission
- Les symptômes possibles
- Les complications possibles
- Les liens entre les IST et le VIH
- Les moyens de prévention
- Le traitement
- L'annonce aux partenaires sexuels
- Le suivi

Si Persistance malgré bonne observance, traiter le client pour gardnerellose, trichomonose, chlamydie et mycoplasme

URET-S : kit URET-S, composé de :

- Métronidazole, 500 mg cp : 4 cp en prise unique orale
 - Azithromycine 500mg cp : 2cp/j en une prise orale pdt 3 jours
- Revoir le client le 24ème jour

5.4.1.2 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la Femme non enceinte (niveau IST1)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, trichomonose, gardnerellose) et cervicite et ou ano rectite (gonococcie, chlamydie, mycoplasme).

Kit CERV composé de : • Ceftriaxone 500 mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Métronidazole 500 mg cp : 4 cp, en prise unique par VO • Azithromycine 500mg cp : 2cp/j en une prise unique pdt 3 jours par VO • Econazole 150 mg ovule : 1 ovule /j le soir au coucher, pdt 6 jours, Revoir la cliente le 10ème jour et le 24ème jour Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaires (candidose, trichomonose, gardnerellose).

Prescrire kit LEUCO- P composé de : • Métronidazole, 500 mg cp, 4 cp en prise unique par voie orale • Econazole 150 mg ovule : 1 ovule /j le soir au coucher, pdt 6 jours, Revoir la cliente le 10ème jour Expliquer la nécessité de traiter le(s) partenaires

5.4.1.3 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la femme enceinte (niveau IST1) (1)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, gardnerellose et trichomonose) et cervicite (gonococcie, chlamydie, mycoplasme) : Prescrire.

kit CERVIGE composé de : • Ceftriaxone 500mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg cp : 1cp /j pdt 3 jours à partir du 2ème jour par voie orale • Econazole ovule 150mg : 1 ov/j le soir pdt 6 jours à partir du 1 er jour • Métronidazole cp 500 mg : 4cp en prise unique par voie orale Revoir la cliente le 10 eme jour

LEUCO S

Traiter la cliente pour cervicite (gonococcie, chlamydie, mycoplasme) Prescrire kit LEUCO S composé de : • Ceftriaxone, 500 mg Inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg Cp : 2cp/J en une prise unique pdt 3 jours par voie orale Revoir la cliente le 24ième jour Expliquer la nécessité de traiter les partenaires

5.4.1.4 Ecoulement vaginal et ou anorectal chez la femme enceinte (niveau IST1) (2)

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, gardnerellose et trichomonose) et cervicite (gonococcie, chlamydie, mycoplasme) :

Prescrire kit CERVIGE composé de : • Ceftriaxone 500mg inj : 1 injection en IM dans une fesse • Azithromycine 500mg cp : 1cp /j pdt 3 jours à partir du 2ème jour par voie orale • Econazole ovule 150mg : 1 ov/j le soir pdt 6 jours à partir du 1 er jour • Métronidazole cp 500 mg : 4cp en prise unique par voie orale Revoir la cliente le 10 eme jour

LEUCOGE-P

Traiter la cliente pour infection vaginale (candidose, trichomonose, gardnerellose) Prescrire kit LEUCOGE-P composé de : • Métronidazole 500 mg cp, 4 cp en prise unique par voie orale • Econazole ovule 150 mg, 1 ov/j, le soir au coucher, pendant 6 jours, Ajouter une ordonnance de Butoconazole crème : une application 2x/j pdt 21 jrs Revoir la cliente le 10ème jour

LEUCOGE-S : Traiter la cliente pour cervicite (gonococcie, chlamydie, mycoplasme) Prescrire kit LEUCOGE S composé de : • Ceftriaxone 500 mg inj : 1 amp IM dans une fesse • Azithromycine 500 mg Cp, 1cp /j pdt 3 j par voie orale Revoir la cliente 2 jours après la fin du traitement

5.4.1.5 Ulcération génitale et/ou anorectale et/ou bubon (Niveau IST 2)

ULGEN : Traiter le / la client(e) pour chancre mou, chancre syphilitique et herpès génital Prescrire Kit ULGEN composé de : • Ceftriaxone, 500 mg, 1 amp en IM unique dans une fesse • BenzathineBenzylpénicilline, 2,4 M UI, 1 amp en IM unique dans l'autre fesse Désinfection locale par Eosine aqueuse 2% matin et soir (non inclus dans le kit). Expliquer la nécessité de traiter les partenaires Revoir le (la) client (e) le 10ème jour

5.4.1.6 Douleur abdominale basse chez la femme non enceinte (Niveau IST 1)

SALPIN : Prescrire anti-spasmodique :

- N- buthylhyoscinecomp (Buscopan), 2 cp où
- Tiémomium (viscéralgine simple) 1 amp IM et
- Référer la cliente au niveau IST1 avec compétence médicale ou au niveau IST2

5.5. 5ème étape Entretien/conseil

5.5.1 Définition

L'entretien/conseil qui constitue la cinquième étape de la prise en charge syndromique des IST est défini comme une communication interpersonnelle confidentielle entre un client (seul ou en couple) de et le prestataire de santé. Il a pour but d'aider le client ou le couple à prendre ses propres décisions.

5.5.2 Techniques

Cet entretien/conseil suit les mêmes principes de communication interpersonnelle que dans le cas du counseling du VIH :

- Avoir les compétences d'un bon conseiller
- Maîtriser les techniques de communication

Elles aident à établir un bon rapport avec le client/couple. Il existe deux types de techniques de communication :

- Techniques de communication verbale
- Techniques de communication non verbale
- Aborder des thèmes appropriés lors de l'entretien/conseil :
 - Les voies de transmission
 - Les symptômes possibles
 - Les complications possibles
 - Les liens entre les IST et le VIH
 - Les moyens de prévention
 - Le traitement
 - L'annonce aux partenaires sexuels
 - Le suivi

Etapes du counseling

Pour assurer une bonne compréhension, le prestataire de soins doit utiliser du matériel de CCC pour illustrer les informations. Les différentes étapes du counseling sont :

- Informer le client/couple sur l'IST dont il souffre et ses conséquences
- Expliquer les modes de transmission de l'IST
- Décrire les complications possibles en l'absence de traitement.
- Expliquer le traitement : médicaments à prendre, durée du traitement, effets secondaires possibles...etc.
- Encourager le client /couple à adhérer au traitement : le traitement est mieux suivi, donc plus efficace, si le client/couple comprend sa maladie et la raison pour laquelle il doit adhérer au traitement.

5.6. 6^{ème} étape : Prise en charge des partenaires

5.6.1 Importance de la prise en charge des partenaires

Les partenaires sexuels des clients IST sont probablement infectés et nécessitent une prise en charge. Cette prise en charge impose une annonce de l'IST au(x) partenaire(s) sexuel(s).

5.6.2 Définition de l'annonce

L'annonce au(x) partenaire(s) sexuel(s) est l'ensemble des activités de santé publique qui visent à informer les partenaires sexuels des client(e)s IST ou infectés par le VIH, à leur offrir des services et à les conseiller au sujet des risques qu'ils encourent.

L'annonce vise à interrompre la chaîne de transmission des IST, en permettant de :

- Prévenir la réinfection du client ;
- Prévenir les infections secondaires à partir des partenaires du client ;
- Prévenir les complications chez les partenaires du client ;
- Eduquer et conseiller les partenaires à risque IST /VIH/sida ;
- Détecter des cas d'IST asymptomatiques.

5.6.3 Principes de l'annonce

Le choix libre : L'annonce doit être volontaire, non coercitive.

La confidentialité : le client ne doit jamais être forcé de révéler des informations concernant ses partenaires. L'identité de ces partenaires ne doit pas être divulguée à qui que ce soit hors de l'équipe sanitaire. En parlant au partenaire, le prestataire de santé doit maintenir la confidentialité du client initial.

L'accessibilité : La disponibilité des soins pour le(s) partenaire(s) doit être aussi complète que possible pour assurer l'accueil, le diagnostic, le traitement et le counseling.

L'assurance de la qualité des services : Un partenaire qui se rend à la clinique devrait être traité pour exactement la même IST que le client initial. L'interrogatoire, l'éducation et le traitement du partenaire devraient être les mêmes pour le partenaire initial.

Ne pas nuire : L'annonce devrait être sensible aux considérations sexo-spécifiques, en gardant à l'esprit le fait que les implications seront différentes pour le client et le partenaire en fonction de leur sexe. Cette nouvelle est souvent angoissante pour beaucoup de clients. Elle peut même causer des dégâts émotionnels de grande envergure aux personnes concernées.

L'annonce aux partenaires est obligatoire devant tout cas d'IST.

Dans le cas de conjonctivite du nouveau-né la mère et son partenaire doivent être traités pour gonococcie et chlamydie.

La vaginite est moins fréquemment causée par une IST, l'annonce aux partenaires n'est donc pas prioritaire.

A quels partenaires faire l'annonce ?

Si possible, tous les partenaires sexuels que le client a eus depuis un certain temps (généralement on conseille de faire l'annonce à tous les partenaires que le client a eus dans les trois derniers mois)

Dans certains cas, il est impossible de faire l'annonce à certains partenaires (ex : travailleurs de sexe, migrants, routiers, ...)

5.6.4. Stratégies de l'annonce (invitation)

Il y a deux façons d'entrer en contact avec les partenaires sexuels. Chacune peut être examinée et adaptée à un cadre particulier :

- Annonce aux partenaires par le client.
- Annonce aux partenaires par le personnel de santé.

5.6.5 Annonce aux partenaires par le client

Le client infecté est encouragé à informer ses partenaires sexuels de leur possible exposition à l'infection. Le client peut :

- Informer personnellement son ou ses partenaires ;
- Accompagner son ou ses partenaires à un établissement de soins de santé ;
- Simplement lui remettre une « carte de relance » remise par le prestataire de santé.

Le prestataire doit :

- Expliquer au client pourquoi l'annonce aux partenaires est importante ;
- Rappeler au client comment éviter de se réinfecter ;
- Aider le client à déterminer comment communiquer avec son ou ses partenaires ;
- Utiliser des cartes de relance.

5.6.6 Annonce aux partenaires par le prestataire

Le personnel de santé recherche et informe les partenaires sexuels, avec l'accord et la coopération du client infecté.

La réussite de cette méthode dépend de deux éléments :

La compétence du prestataire

La volonté du client à donner des informations correctes et fiables sur son ou ses partenaires.

Les contraintes d'une telle approche sont :

- Nécessité d'un personnel formé ;
 - Nécessité des ressources économiques considérables ;
 - Possibilité de perception par le client comme une menace à la confidentialité.
- La faisabilité de cette méthode ainsi que son avantage économique devraient être examinés avec soin avant sa mise en œuvre.

5.6.7 Prise en charge médicale du (des) partenaire (s)

A son arrivée dans l'établissement de soins le partenaire devient un client.

La prise en charge du partenaire comporte les étapes suivantes :

Accueil, interrogatoire et examen (mais l'examen n'est pas indispensable)

Traitement pour d'autres symptômes IST éventuellement détectés.

Entretien/conseil

L'approche à la prise en charge du partenaire doit comporter les aspects suivants :

- Traiter tous les partenaires sexuels du client ;
- Traiter tous les partenaires pour la même IST ;
- Traiter tous les partenaires sexuels, en l'absence de signes ou de symptômes d'une IST (pour la même IST que le client initial).

Prise en charge du partenaire au sein du service ?

La prise en charge du partenaire au sein du service se fait selon trois cas de figure :

- Le partenaire est amené par le client contact :

La tâche de l'agent est facilitée dans la mesure où le client contact a sûrement évoqué la question avec son partenaire. Il s'agira de passer en revue les étapes suivantes :

- Salutations d'usage,
- Transition rapide entre le cas contact et le partenaire invité dans la structure,
- Risques encourus par le partenaire et qui justifient son invitation dans la structure sanitaire pour l'amener à accepter le traitement.
- Lui appliquer l'algorithme approprié.
- Le partenaire se présente dans la structure avec une carte de relance remise par le client initial :
 - Il faut se référer aux éléments de prise en charge du client initial.
 - Introduire le problème de façon adroite, sans accuser personne et expliquer la nécessité pour le partenaire de suivre le traitement.
 - On n'oubliera pas de rechercher d'autres partenaires éventuels (beaucoup de prudence pour ménager les susceptibilités surtout pour les mariés)
- Le partenaire est contacté par l'agent de santé :
 - Expliquer le motif du contact,
 - Puis suivre la même démarche que dans le cas du client contact.

Les partenaires sexuels des clients IST sont probablement infectés et nécessitent une prise en charge. Cette prise en charge impose une annonce de l'IST au partenaire.

5.7. 7^{ème} étape : Enregistrement des cas /notification

Renseigner les outils de collecte de données appropriés.

5.7.1 Définition

L'enregistrement des cas est la conservation des données obtenues par l'inscription dans un registre des personnes qui ont été traitées pour IST au sein d'une structure de santé afin que ces données soient collectées sur des supports et transmises aux autorités sanitaires pour traitement. Cet enregistrement se fait lors des consultations et des examens de laboratoire. Il faut enregistrer autant de fois que le client se présente.

La notification des cas est le processus par lequel les prestataires de santé ou les laboratoires signalent les cas de maladies aux autorités sanitaires.

La surveillance est la collecte, la compilation, l'analyse permanente des données, et la communication des résultats aux personnes qui en ont besoin pour poursuivre les actions entreprises.

5.7.2 Enregistrement des cas

Pourquoi l'enregistrement des cas d'IST ?

L'enregistrement et la notification des cas :

Permettent à chaque structure de santé de calculer les indicateurs relatifs aux IST.

Permet à la structure de santé d'évaluer ses besoins en ressources (médicaments, réactifs, matériel d'examen, équipement, personnel, etc.) pour assurer la prise en charge des cas d'IST.

Permet d'évaluer l'impact des stratégies de lutte contre les IST.

Quoi enregistrer ?

Cas : chaque cas d'IST doit être enregistré en tant que cas

Episode : une personne peut avoir un ou plusieurs épisodes d'IST

Cas index : client (e) IST traité (e) dans la structure de santé à partir duquel (de laquelle) on retrouve un (e) ou plusieurs partenaires ;

Contact : client (e) IST identifié (e) et traité(e) dans la structure de santé à partir d'un cas index connu.

6. COMPLICATIONS DES IST

Chez la femme non enceinte :

- Maladie Inflammatoire Pelvienne (MIP) ou Syndrome Inflammatoire Pelvien (SIP) [mal au bas ventre même pendant les rapports sexuels]
- Pelvipéritonite (infection)
- Imperméabilité tubaire (trompe bouchée)
- Infertilité/ stérilité
- Cancer du col utérin (dû au papillomavirus)
- paralysie

Chez la femme enceinte

- Grossesse extra-utérine (GEU) [en dehors de l'utérus]
- Avortement précoce ou tardif
- Mort in utero (mort du fœtus dans l'utérus)
- Retard de croissance du fœtus in utero
- Rupture prématurée des membranes
- Chorioamniotite (infection du liquide amniotique)
- Accouchement prématuré

Chez l'homme

- Orchi-épididymite (infection des testicules)
- Prostatite (infection de la prostate)
- Lymphangite (infection des ganglions)
- Septicémie (infection généralisée)
- Rétrécissement de l'urètre (canal urinaire)
- Infertilité / Stérilité
- Cancer
- paralysie

Chez le nouveau-né

- Conjonctivite
- Syphilis congénitale
- Septicémie

7. CONCEPT DOUBLE PROTECTION

7.1. Définition de la double protection

La double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/VIH/Sida

7.2 Approches pour assurer la double protection

Pour aboutir à la double protection, l'individu peut utiliser différentes approches. L'approche la plus certaine est l'abstinence totale, mais comme elle est souvent inacceptable par la majorité des individus de tout âge, d'autres approches sont possibles.

L'utilisation d'une seule méthode (préservatif)

L'approche par l'utilisation d'une seule méthode consiste à amener les clients à porter le préservatif (masculin ou féminin) lors de tout rapport sexuel. Un préservatif bien utilisé selon les normes est efficace dans la protection contre la grossesse non désirée et les IST/VIH/Sida.

L'utilisation combinée de deux méthodes

L'approche par l'utilisation combinée de deux méthodes consiste à encourager l'utilisation du préservatif en plus d'une autre méthode de contraception. Cette autre méthode peut être hormonale, chirurgicale ou mécanique.

La fidélité réciproque dans un couple monogame ou polygame associée à une méthode contraceptive efficace

Pour se protéger contre les infections y compris le VIH, il est préconisé dans cette approche de n'avoir des rapports sexuels que dans un contexte de fidélité réciproque que le couple soit monogame ou polygame. L'homme ou la(les) femme(s) ne doivent avoir des rapports sexuels que dans un cadre très intime et fermé. Personne ne doit sortir de ce cadre. Si possible il est recommandé que les membres voulant constituer un tel couple partagent des informations sur leur statut sérologique pour ce qui concerne le VIH. Le bilan pour rechercher les autres infections en vue d'un traitement préalable est aussi conseillé.

En plus de ces précautions il faudrait utiliser une méthode contraceptive efficace pour se protéger contre les grossesses non désirées.

7.3. Avantages et limites de la double protection

7.3.1. Avantages

La double protection a beaucoup plus d'avantages que les différentes méthodes prises de façon individuelle. En général, la double protection :

Améliore la santé des individus et des familles

Diminue les dépenses liées aux maladies et aux grossesses non désirées

Implique les deux partenaires surtout l'homme dans la prise de décision

Renforce les relations au sein du couple

Améliore l'harmonie dans la famille.

7.3.2. Limites

Elle a quelques limites même si elles sont mineures par rapport aux avantages. Les principales sont :

La difficulté de l'adhésion de tous les membres du couple

La non disponibilité des moyens à tout moment

L'apprentissage de l'utilisation des méthodes

La possibilité des effets secondaires des méthodes utilisées

7.4. Indications de la double protection

La double protection est une méthode nécessaire pour toutes les personnes sexuellement actives en dehors des désirs de maternité. Elle s'applique :

A l'homme à partir de l'adolescence

A la femme, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, le programme de protection vise les IST/VIH/sida étant donné que la possibilité de grossesse est écartée.

Le célibataire

Les situations de migration ou de promiscuité liées à un conflit ou un événement naturel (volcan...)

L'éloignement du domicile

Le travail de sexe ()

Les risques de rapports occasionnels

7.5. Stratégies de la double protection

Il existe quatre stratégies pour vulgariser la double protection :

- Renforcement de la capacité du personnel à prendre en charge le double risque (formation)
- Organisation des causeries de groupe (IEC/CCC, groupe d'auto-support)
- Intégration des activités d'IST/VIH/Sida aux autres activités de santé
- Promotion de l'utilisation des préservatifs (masculins, féminin)

La double protection n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une question de couple. Pour y parvenir il faut :

- Analyser sa propre situation, ses relations sexuelles et celles de son ou de sa partenaire
- Discuter de ces problèmes de relations sexuelles avec son ou sa partenaire (ses partenaires)
- Amener le ou la partenaire (les partenaires) à prendre conscience de la réalité des IST/VIH/Sida
- Expliquer l'importance de la double protection
- Être d'accord que la double protection peut nous protéger ainsi que nos partenaires
- Apprendre l'utilisation du préservatif (les deux membres du couple)
- Persuader le ou la partenaire (les partenaires) de l'utilité du préservatif
- Appliquer la fidélité mutuelle
- Obtenir l'engagement du partenaire (des partenaires)
- S'assurer que l'un ou l'autre n'a pas une IST.

CONCLUSION

Il existe 3 approches de prise en charge des IST avec des avantages et des limites pour chacune. Cependant l'approche syndromique est celle recommandée. Cette prise en charge se déroule en 7 étapes que sont : Accueil et Interrogatoire, Examen physique ; Diagnostic, Traitement, Entretien /conseil, Notification au(x) partenaire(s) et Enregistrement /notification.

Le concept de la double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger à la fois contre les grossesses non désirées et les IST/VIH.

CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR L'INFECTION A VIH

INTRODUCTION

La riposte au sida a donné de formidables résultats mais l'écart entre les progrès obtenus à ce jour et l'objectif de « mettre fin à l'épidémie de sida » demeure beaucoup important. Dans de nombreux pays, un nombre considérable de personnes, sont laissées pour compte. Comprendre les étapes de l'évolution historique de l'infection à VIH dans le monde et en Côte d'Ivoire, son épidémiologie et son impact socio-économique permettra au clinicien de mieux appréhender les aspects de la prise en charge de cette infection. Ce chapitre aborde la chronologie des différents événements survenus depuis l'avènement de cette pandémie, l'épidémiologie et ainsi que l'impact socio-économique de cette infection.

Objectif général

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de décrire les notions essentielles sur le VIH /SIDA.

Objectifs spécifiques

A la fin de la formation, le participant sera en mesure de :

1. Enumérer les grandes étapes de l'histoire de l'infection à VIH dans le monde et en Côte d'Ivoire
2. Citer les modes de transmission du virus
3. Enumérer les facteurs à risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant
4. Citer les déterminants de non transmission de l'infection à VIH
5. Citer les déterminants de propagation de l'infection à VIH
6. Décrire l'ampleur de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire
7. Décrire l'impact du VIH/sida sur la société et les secteurs d'activités.

Plan du chapitre

- Historique de l'infection à VIH
- Epidémiologie
- Impact socio-économique

1. HISTORIQUE DE L'INFECTION A VIH

1.1. Dans le monde

- 1981 : Diagnostic des premiers cas aux USA
- 1983 : Isolement du VIH-1 par les équipes de L. Montagnier et de R. Gallo
- 1985 : Développement du premier test sérologique
- 1986 : Découverte du VIH-2
- 1987 : Mise au point de l'AZT (Zidovudine)
- 1996 : Création de l'ONUSIDA
- 2001 : Réunion spéciale du Conseil de Sécurité sur le VIH/sida avec la création du Fonds Mondial des Nations-Unies (UNGASS)
- 2004 : Mobilisation mondiale des ressources (Fonds Mondial, PEPFAR, Banque Mondiale...)
- 2014 : Initiative 90-90-90 de l'ONUSIDA

1.2. Historique en Côte d'Ivoire

Principales étapes de la réponse nationale à l'infection à VIH en Côte d'Ivoire :

- 1985 : Diagnostic du premier cas de SIDA

- 1987 : Engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers la création du Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS)
- 1990 : Premières études sur la Transmission Mère Enfant (TME)
- 1994-1998 : Essais cliniques sur régime court d'AZT en PTME : RETROCI (CDC/DITRAME (ANRS)
 - Mise en place d'un fond de solidarité nationale pour les ARV
- 1999 : Résultats sur l'utilisation du cotrimoxazole (ANRS; CDC/RETROCI)
- 2001 : Création du Ministère de la Lutte contre le sida
 - Création du Programme National de Prise en Charge médicale des personnes vivant avec le VIH (PNPEC)
 - Gratuité de la prise en charge pédiatrique et de la PTME (ARV, bilan initial et de suivi)
- 2004 : Décentralisation et déconcentration des activités de prise en charge avec le lancement de la première phase du projet HAART
- 2008 : Adoption de la Gratuité de la PEC ARV/ Bilan biologique du suivi en Côte d'Ivoire
- 2012 : Lancement du plan d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire
- 2014 : Promulgation de la loi N° 430-2014 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH et le sida
- 2017 : Note circulaire de l'approche « tester et traiter tous » comme nouvelle stratégie de prise en charge des PVVIH (1^{er} février 2017).

2. EPIDEMIOLOGIE

2.1. Définition VIH / SIDA

Le VIH (Virus de l'immunodéficience Humaine) est un virus qui appartient à la famille des rétrovirus du genre Lentivirus. C'est un virus qui s'attaque au système immunitaire et entraîne une maladie chronique progressive laissant les personnes affectées vulnérables aux infections et aux cancers opportunistes.

Lorsque le corps n'arrive plus à lutter contre les infections, la maladie prend le nom de SIDA, un acronyme de « Syndrome d'immunodéficience acquise ». Il s'écoule en moyenne plus de 10 ans avant que l'infection par le VIH initiale ne mène au SIDA.

Le virus du VIH se réplique c'est-à-dire reproduit des copies de lui-même. Il existe deux (2) types de VIH connus dans le monde : le VIH-1 et le VIH-2 qui se transmettent de la même manière.

L'acronyme SIDA est le sigle du syndrome d'immunodéficience acquise :

Syndrome : ensemble de symptômes, de plusieurs signes.

- **Immunité** : capacité de l'organisme à se défendre.
- **Déficitaire** : affaiblissement du système immunitaire.
- **Acquis** : cette déficience n'est ni innée ni héréditaire.

Le sida constitue le stade avancé de l'infection à VIH, au cours duquel la personne infectée présente des infections ou affections opportunistes et un bilan biologique perturbé.

Cette infection est causée par un virus de la famille des rétrovirus appelé le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dont il en existe deux types : le VIH 1 et VIH-2.

2.2. Répartition géographique des types de VIH

Le VIH 1, de loin le plus répandu, est présent dans le monde entier. Le VIH2, plus rare, est essentiellement localisé en Afrique de l'ouest.

2.3. Caractéristiques physico-chimiques du virus

Les rétrovirus se caractérisent au plan physico-chimique par :

a- leur sensibilité à :

- Alcool à 70° pendant 15 minutes.
- Eau de Javel à 12° chlorométrique diluée à 1/10 pendant 10 minutes.
- Soluté de Dakin pendant au moins 5 minutes.
- Chaleur à 56° pendant au moins 5 minutes.

b- leur résistance dans le milieu extérieur :

- Eau à 37° pendant 11 à 15 jours
- Sang en dessiccation 3-7 jours

2.4. Liquides biologiques à risque élevé de transmission du VIH

- Sang
- Sperme
- Liquide séminal
- Sécrétions vaginales
- Lait maternel
- Autres (LCR, liquide amniotique, etc....)

2.5. Modes de transmission

Trois modes de transmission sont connus :

- Sexuelle (90%)
- Sanguine (3%)
- Mère - enfant (7%)

2.5.1. Transmission par voie sexuelle

Les facteurs de risques sont :

- les microtraumatismes lors des rapports sexuels,
- les rapports sexuels non protégés pendant les menstrues,
- les rapports sexuels non protégés avec partenaires multiples,
- le premier rapport sexuel chez la jeune fille,
- les viols et violences sexuelles,
- la prostitution,
- Le stade avancé de la maladie,
- les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ulcéraives ou non.

Ce risque est variable selon le germe incriminé (Trichomonas, Chlamydia, Gonocoque...) ; la fréquence des contacts avec prostituées ; la présence d'ulcérations génitales chez l'homme et l'absence de circoncision.

2.5.2. Transmission par voie sanguine

Les facteurs de risque de la transmission par voie sanguine sont les suivants :

- Transfusion avec du sang non testé
- Toxicomanie avec échange de seringues

Certaines pratiques : excision, circoncision, percées d'oreilles, tatouages avec le même matériel souillé.

- Accident d'exposition au sang (AES)

2.5.3. Transmission mère-enfant

2.5.3.1. Définition

La transmission mère-enfant (TME) ou transmission verticale du VIH est le passage du virus de la mère infectée par le VIH à son enfant. En absence de traitement, le risque de TME est de 15 à 45%.

2.5.3.2. Périodes et risques de la transmission mère-enfant du VIH

La transmission du VIH de la mère à l'enfant peut se produire pendant la grossesse, au cours de l'accouchement ou de l'allaitement.

Pendant la grossesse, 5 à 10 % des bébés nés de mère infectée sont contaminés après passage du virus à travers le placenta. Pendant le travail et l'accouchement, 10 à 20% des nouveau-nés sont contaminés lors du passage de la filière pelvi-génitale.

Le virus peut être transmis à l'enfant par le lait maternel. Le risque de transmission varie alors de 25 à 35% en cas d'allaitement jusqu'à 6 mois, jusqu'à 30 à 45% en cas d'allaitement jusqu'à 18 ou 24 mois.

Au total, dans une population d'enfants non allaités et sans traitement ARV, le taux de transmission est de 15-30%, mais en cas d'allaitement prolongé, le taux de transmission passe à 30 à 45%.

2.5.3.3. Facteurs de risque de la TME

De nombreux facteurs influencent la TME du VIH. Ils sont viraux, maternels, obstétricaux, fœtaux et liés à l'allaitement.

Le plus important de ces facteurs est la charge virale maternelle (quantité de virus contenue dans le sang maternel).

Certains facteurs entraînent une baisse de la protection offerte par le placenta au fœtus (qui devrait, dans des circonstances normales, empêcher le VIH de traverser).

La transmission au cours de l'accouchement peut se produire lorsque le nouveau-né inhale du sang maternel ou des sécrétions cervicales contenant du virus.

Le tableau-ci-après présente les différents facteurs de risque de transmission mère-enfant du VIH.

Tableau VI : Facteurs de risque de la TME du VIH

	FACTEURS PROUVES	FACTEURS POSSIBLES
Viral	Charge virale élevée Sida avéré Certains génotypes et phénotypes viraux VIH 1	Résistance virale (théoriquement possible)
Maternel	Déficit immunitaire (CD4 bas) Primo-infection pendant la grossesse ou l'allaitement SIDA Chorioamniotite	Déficit en vitamine A; carence nutritionnelle. Anémie IST Contact sexuel non protégé Toxicomanie : utilisation de drogues par voie intra veineuse
Obstétrical	Accouchement par voie basse (comparé à césarienne programmée) Rupture des membranes de plus de 4 heures Travail prolongé 1 ^{er} enfant de naissance multiple (avec accouchement par voie basse)	Gestes traumatiques et invasifs : forceps, amniocentèse, épisiotomie, versions par manœuvre externe, ou interne Hémorragie intrapartum
Fœtal et Nouveau-né	Prématurité < 37 SA	Soins du cordon Gestes traumatiques ; circoncision, etc
Allaitement	Allaitement prolongé Pathologie des seins (Mastites et abcès du sein, Mamelons fissurés, craquelés ...)	Allaitement mixte Plaies buccales

Source : De Cock KM et al. 2000

2.5.3.4. Influence de la grossesse sur l'infection à VIH

La plupart des études montrent que la grossesse n'a pas d'effets négatifs sur l'infection à VIH. Cependant, on observe des modifications immunologiques et physiologiques, notamment une baisse de l'immunité cellulaire.

La grossesse a donc un effet aggravant sur l'infection à VIH en majorant l'immunodéficience surtout chez les patientes en phase avancée de la maladie. Ces patientes risquent de développer beaucoup plus de maladies opportunistes, bien que probablement, la grossesse ne soit pas la cause de leur développement.

Les femmes dans une phase avancée de la maladie devraient éviter toute grossesse, moins qu'elles ne soient traitées efficacement par les ARV.

Chez les femmes présentant une immunodépression modérée, notamment celles qui sont cliniquement asymptomatiques, aucun rôle péjoratif immédiat de la grossesse n'a été mis en évidence.

2.5.3.5. Influence de l'infection à VIH sur la grossesse

L'infection à VIH présente des conséquences sur le déroulement de la grossesse. Au-delà de la transmission materno-fœtale du VIH, une femme enceinte séropositive est exposée aux risques suivants :

- au premier trimestre, il y a un risque accru de mort in-utero et d'avortement. Source (Brocklehurst, 1998)
- au deuxième et troisième trimestre, un accouchement prématuré et un retard de croissance intra-utérin peuvent survenir.

2.6. Déterminants de non transmission

Certains actes de la vie courante n'entraînent pas la transmission de l'infection à VIH :

- Salutations et baisers simples
- Utilisation de mêmes ustensiles de cuisine
- Utilisation de même couvert
- Utilisation de mêmes toilettes, douches, bureau, et couchette.
- Sueur, respiration, toux
- Piqûres d'insectes : mouches, moustiques
- Natation dans la même piscine
- Utilisation des mêmes moyens de transport

2.7. Déterminants de la propagation du VIH

Les déterminants regroupent les comportements et les situations à risque favorisant l'expansion de l'infection dans la population :

Tableau VII : Déterminants de la propagation du VIH

Populations plus exposées Au risque de transmission du VIH	Facteurs de vulnérabilité et de risque
Femme	• Pauvreté • Analphabétisme • Lévirat, sororat • Incapacité à négocier le préservatif • Anatomie de la femme • Subordination

Femmes enceintes	• Difficultés d'accès aux services (CPN, accouchement, PTME) • Vulnérabilité sociale • Connaissance tardive du statut sérologique • Faiblesse de la participation du conjoint
Enfants nés de mère séropositive	• La transmission mère-enfant du VIH représente 95% des cas de contamination chez l'enfant • Insuffisance dans le suivi des grossesses des femmes enceintes (taux de couverture de CPN 4 de 44,65% (RASS 2021) • Faible taux d'accouchement assisté de 75,73% (RASS 2021) • Insuffisance du dépistage précoce (43,6%, rapport VIH 2015)
Travailleuses de Sexe	• Prévalence élevée de 10,20% environ 4 fois la moyenne nationale • Disparités dans l'exercice de l'activité (légal, clandestin) et disparités dans l'accès à la prévention et aux soins. • Faible niveau d'instruction et absence de protection sociale, juridique. • Stigmatisation et violences sociales et sexuelles. • Faible connaissance du statut sérologique. • Faibles connaissances sur les IST/VIH et l'intérêt du préservatif. • Fréquence élevée des rapports sexuels non protégés, dans un contexte de prévalence élevée des IST. • Faibles capacités de négociation des rapports protégés aboutissant à une utilisation irrégulière du préservatif.
Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH)	• La prévalence est de 10,70% (Spectrum 2022) • Marginalisation sociale. • Faible accès aux services de prévention et de prise en charge. • Faible connaissance du statut sérologique. • Multi partenariat sexuel, rapports sexuels non protégés, faible utilisation du préservatif, faible conscience du risque du VIH et VHB.
Usagers de Drogues	• Prévalence élevée de 6,60%, environ 3 fois la moyenne nationale, comprenant des sous-groupes particulièrement atteints (HSH-UD, femmes-UD) • Prévalence importante de la tuberculose (environ 10 fois la moyenne nationale) • Marginalisation sociale • Discrimination et stigmatisation dans les lieux des soins. • Méconnaissance de la population des UDI. • Faible accès aux services • Faible connaissance du statut sérologique VIH/VHB et le VHC. • Pas d'accès aux services de réduction des risques. (RdR) • Prise de risques sexuels avec l'usage de drogues • Prise de risques du VIH et des hépatites virales VHB/VHC.
Populations carcérales	• Prévalence élevée de 7,9% (Étude INSP, 2013). • Promiscuité, absence d'accès aux services de prévention et de soins. • Risques sexuels entre hommes. • Insuffisance d'accès aux messages préventifs et au préservatif. • Faible conscience du risque du VIH

Adolescentes et jeunes filles de 15 à 24 ans	L'insuffisance des connaissances exactes sur le VIH/sida, notamment chez les filles, le comportement à risque caractérisé par (i) Rapports sexuels précoces, rapports sexuels non protégés, partenaires multiples, (ii) l'écart d'âge élevé entre les filles et leurs partenaires sexuels, (iii) la multiplicité des partenaires sexuels, (iv) l'insuffisance dans l'utilisation des préservatifs, (v) la pratique du travail du sexe, L'exposition croissante aux violences sexuelles
Partenaire(s) sexuel(le)s d'une PVVIH	Exposition continue au risque de transmission du VIH
Personne en uniforme (corps habillés)	- Mythe de l'uniforme : le port de l'uniforme donne le sentiment d'invulnérabilité. - Missions loin des foyers conjugaux - Esprit de groupe
Migrants	- Déplacements fréquents et prolongés hors du foyer conjugal - Faible utilisation des préservatifs chez les routiers, les saisonniers, et les personnes en mission.

2.8. Ampleur de la maladie

2.8.1. Estimations mondiales

Tableau VIII : Vue d'ensemble de l'épidémie de Sida 2022

Nombre de personne vivants avec le VIH dans le monde	Total	39.000.000
	Adultes	37.700.000
	Femmes	20.670.000
	Hommes	16.930.000
Personne nouvellement infectées par le VIH	Enfants (inf. à 15 ans)	1.400.000
	Total	1.300.000
	Femme et jeune fille	598.000
	Enfants	130.000
Décès liés au sida	Total	630.000

2.8.2. Estimation de l'ampleur de l'épidémie du VIH/SIDA en Côte d'Ivoire

2.8.2.1. Situation de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire ((Spectrum 2023)

- Nombre total de personnes vivant avec le VIH : 407 595 (Spectrum 2023)
 - Nombre total d'hommes adultes infectés par le VIH : 137 190
 - Nombre total de femmes adultes infectées par le VIH : 270 405
 - Nombre total d'adultes infectés par le VIH : 345 120
 - Nombre total d'enfants infectés par le VIH : 20981
- Nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH : 8 978
 - Nombre d'adultes nouvellement infectés par le VIH : 5 416
 - Nombre de femmes nouvellement infectées par le VIH : 3 176
 - Nouvelles infections chez les jeunes et adolescents à intégrer
 - Nombre d'hommes nouvellement infectés par le VIH : 2 239
 - Nombre d'enfants nouvellement infectés par le VIH (0-4 ans) : 1 639
- Nombre total de décès dus au sida : 9 952
 - Nombre d'adultes 15 ans et plus : décédés du fait du sida : 8 877
 - Nombre de femmes décédées du fait du sida : 4 261
 - Nombre d'hommes décédés du fait du sida : 4 616
 - Nombre d'enfants décédés du fait du sida : 1 075

2.8.2.2 Prévalence du VIH en Côte d'Ivoire

Selon le Spectrum 2023, la prévalence du VIH chez les personnes âgées de 15 – 49 ans est de 1,82 % en Côte d'Ivoire.

Avec une population de plus de 33% de jeunes, la Côte d'Ivoire se caractérise par une épidémie du VIH à caractère mixte avec des prévalences élevées au sein des populations clés.

Les femmes (2,56,3%) sont plus touchées que les hommes (1,08%).. la prévalence chez les jeunes filles de 20 à 24 ans est de 1,26% et de 0,43% chez le jeune homme.

- Population 2022 : 30 163 658 hbts
- Epidémie mixte
- PVVIH estimées : 407 595 en fin 2022 dont 20 981 enfants et 386 614 adultes
- PVVIH estimées femmes : 270 405 (66%) contre PVVIH estimées PVVIH hommes : 137 190 (34 %)

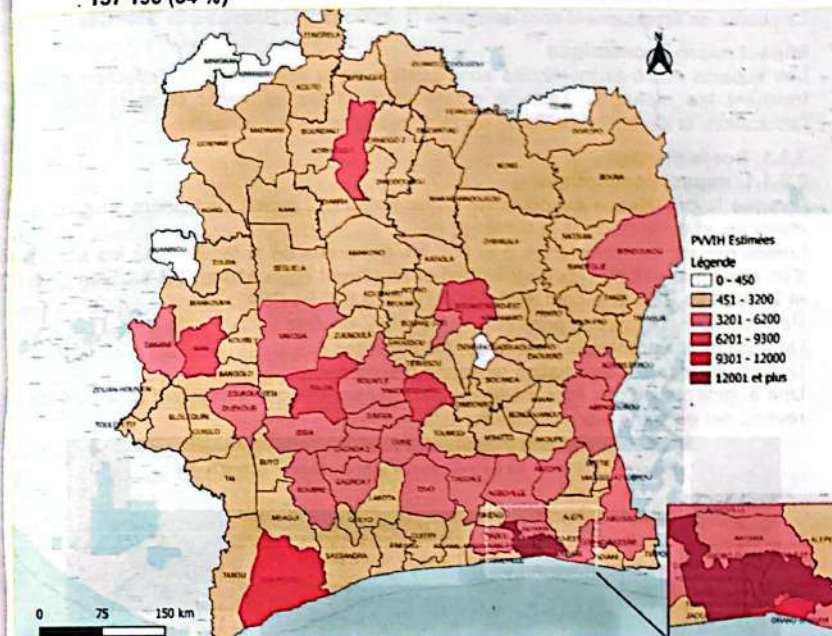


Figure 4 : Nombre de PVVIH estimée par district 2023

- Abidjan représente 36% soit 148 591
- 48 districts sanitaires représentent 80% des PVVIH estimées

Au niveau des populations clés la prévalence : HSH 10,70% ; TS 10,20%, UD 6,60% ; Transgenre 24,20% ; PC ...% (Spectrum 2023)

3. IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE

3.1. Impact démographique

3.1.1. Morbidité et mortalité

Les décès du VIH sont réduits de (-) 70% de 2010-2022 et de (-) 23% de 2019-2022 (profil épidémiologique du PNLS 2023).

3.1.2. Espérance de vie

L'espérance de vie de la population est de 56,8 selon le recensement de la population 2021. Mais aujourd'hui plus la personne atteinte du VIH commence le traitement prescrite, plus son espérance de vie s'allonge.

3.1.3. Impact sur les groupes vulnérables

Les femmes sont plus atteintes que les hommes 2,56% Vs 1,08% en 2022.

Près de la moitié des sujets infectés par le VIH le sont avant 25 ans.

Impact macro-économique

L'impact macro-économique est fonction de la prévalence de l'infection à VIH et touche le financement des programmes de santé et le Produit Intérieur Brut (PIB). Plus la prévalence croît plus le PIB diminue.

L'infection à VIH a entraîné un accroissement des coûts de financement des programmes de prévention et de traitement.

Les coûts de financement sont estimés à 54 millions \$ U.S/an pour la Côte d'Ivoire.

Impact micro-économique

Les impacts micro-économiques sont fonction de la prévalence de l'infection à VIH et touchent les ménages, l'activité économique et les différents secteurs notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, les entreprises et les corps habillés.

3.3.1. Sur le ménage

3.3.1.1. Impact économique

Lorsque la prévalence est comprise entre 1 et 4%, l'impact se ressent au niveau des ménages et du secteur de la santé.

Lorsqu'elle est comprise entre 5 et 9%, les dépenses de la famille pour les soins à vie d'un patient atteint du sida augmentent et se situent entre 416 et 546 \$ US/an (208 000 et 273 000 frs CFA si le coût du dollar est égal à 500 frs CFA).

Pour une prévalence comprise entre 10 et 20%, on note :

Un impact catastrophique du sida sur les ménages

Une chute de la consommation moyenne des ménages

Une augmentation des frais médicaux des ménages et qui consacrent 25 à 50% de leur revenu net en soins aux malades du sida.

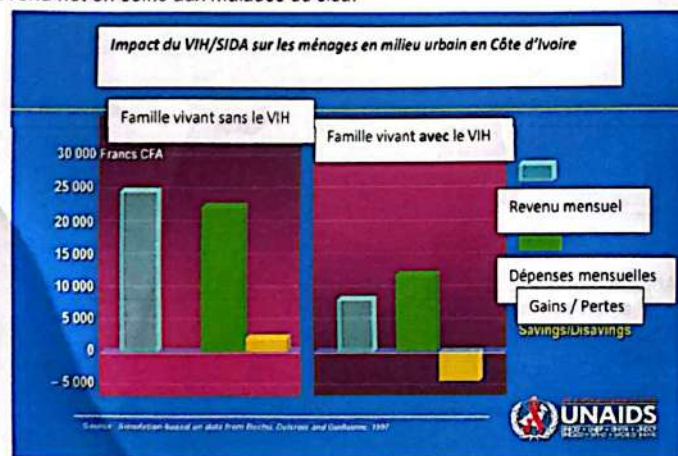


Figure 5 : Impact du VIH/sida sur les ménages en milieu urbain en Côte d'Ivoire (traduit de la version anglaise)

3.3.1.2. Impact social

Il va conduire à la désintégration de la famille par :

- Insécurité alimentaire
- Dissolution des familles par le fait du divorce
- Enfants séparés et répartis entre différents parents après le décès des parents
- Augmentation du nombre des femmes chefs de famille
- Impact psychosocial sur les familles prenant soins des patients
- Nouveaux nés séropositifs, les orphelins et enfants vulnérables
- Veuvage en cas de décès d'un membre du couple

3.3.2. Impact sectoriel

3.3.2.1. Impact sur l'éducation

Il se traduit par une baisse du taux de scolarisation et une augmentation du taux de mortalité et de morbidité des enseignants.

3.3.2.2. Impact sur le secteur de la santé

Il est observé une augmentation des besoins en soins de santé. Le taux d'occupation des lits par les malades du sida au SMIT est supérieur à 80 %.

Il est aussi observé une augmentation de la morbidité et de la mortalité du personnel de santé, une réduction en qualité et en quantité de personnels de la santé (mise à la retraite, décès d'agents qualifiés), une surcharge de travail du fait de la morbidité, de la mortalité et de la réémergence des maladies liées au VIH/sida (tuberculose).

3.3.2.3. Impact sur l'agriculture

Dans les 10 pays africains les plus atteints, la force de travail sera diminuée de 10 à 20% en 2020. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont inclus dans ces 10 pays :

- En Côte d'Ivoire la force de travail en agriculture a baissé de 5,6% en 2000 et cette baisse sera de 11, 4% en 2020 en l'absence d'intervention.
- Au Cameroun cette baisse a été de 2,9% en 2000 et sera de 10,7% en 2020

3.3.2.4. Impact sur les Entreprises

Les coûts les plus importants pour les entreprises affectées par le VIH/sida sont liés aux facteurs suivants :

- Augmentation de l'absentéisme
- Baisse de la productivité
- Surcoût en termes de formation qui s'explique par la nécessité de remplacer le personnel qualifié malade ou décédé
- Accroissement des charges salariales.
- Accroissement des dépenses de santé.
- Frais de funérailles.

CONCLUSION

- Impact important du VIH/sida sur les différents secteurs de développement.
- Cet impact doit être pris en compte dans les stratégies de contrôle de la maladie.
- Adoption par la Côte d'Ivoire de l'approche multisectorielle pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau.

CHAPITRE 3 : ETIOPATHOGENIE-HISTOIRE NATURELLE- CLASSIFICATION

INTRODUCTION

L'étude de l'étiopathogénie et de l'histoire naturelle de l'infection à VIH permet de mieux comprendre l'évolution, les manifestations cliniques et la classification.

Objectif général

A la fin du chapitre l'étudiant devra être capable d'expliquer l'étiopathogénie, l'histoire naturelle du VIH/Sida et classer les patients.

Objectifs spécifiques

A la fin du chapitre, l'étudiant sera en mesure de :

1. Expliquer l'action du VIH sur les cellules du système immunitaire.
2. Décrire les différentes phases de l'évolution de l'infection à VIH
3. Décrire les particularités évolutives du VIH chez l'enfant
4. Classer les clients infectés par le VIH selon les données cliniques et immunologiques

Plan du cours

1. Etiopathologie
2. Histoire naturelle
3. Classification

1. ETIOPATHOGENIE DE L'INFECTION A VIH

1.1 Agent pathogène

1.1.1 Rappel

Un virus est une particule infectieuse de très petite taille (20 à 300nm) contrairement aux autres microorganismes (bactéries, parasites et champignons).

Il est composé de trois parties dont deux éléments constants et un élément non constant. L'ensemble des deux éléments constants forme la nucléocapside. Il s'agit de :

- Un génome constitué à la différence des bactéries d'un seul type d'acide nucléique ARN (acide ribonucléique) ou ADN (acide désoxyribonucléique) ;
- Une capside : c'est une membrane protéique qui protège le génome.

L'élément non constant est l'enveloppe externe de nature lipido-protéique.

Un virus enveloppé est plus fragile aux éléments physico-chimiques que celui qui n'a pas d'enveloppe.

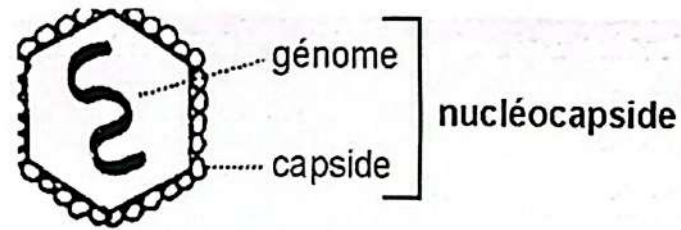
Ne possédant aucun système de métabolisme (synthèse, dégradation), le virus est obligé de vivre à l'intérieur d'une cellule vivante. On dit que c'est un parasite obligatoire de la cellule hôte. Il détournera alors à son profit la machinerie cellulaire de l'hôte.

Sa multiplication a lieu à l'intérieur de la cellule hôte d'où il va puiser tous les éléments qui lui sont nécessaires. La réplication (multiplication) se fait à partir de son génome et aboutit à la production de plusieurs milliers de copies du virus en un temps variable.

Lorsque le nouveau virus sort de la cellule, il a tous ses constituants (nucléocapside et ou enveloppe). Quand il pénètre dans une nouvelle cellule, le virus se débarrasse de son enveloppe puis de sa capside. L'acide nucléique se retrouve alors libre dans le cytoplasme de la cellule hôte et va s'exprimer. Le cycle reprend de nouveau.

Le virus est antigénique (ses constituants protéiques sont reconnus comme étrangers par l'organisme qui les abrite et constituent donc des antigènes) et immunogène (génère une réaction immunitaire), ce qui va entraîner chez l'organisme infecté la production d'anticorps dirigés contre les structures protéiques virales.

Les troubles qui se développent chez la personne infectée sont la conséquence de la multiplication du virus dans les cellules.



un virus nu

Figure 6 : Schéma de la structure d'un virus

1.1.2 Taxonomie

Il s'agit d'un virus de la famille des rétrovirus appelé le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Les rétrovirus sont des virus à ARN qui sont caractérisés par la présence d'une enzyme appelée la transcriptase inverse (reverse transcriptase) qui transforme l'ARN viral en ADN pour se multiplier. Ces rétrovirus comprennent 3 sous-groupes :

- Oncovirus : HTLV responsable de cancer
- Lentivirus : VIH maladie à évolution lente
- Spumavirus : non pathogène chez l'homme.

Les lentivirus comprennent deux types de virus qui sont le VIH 1 et le VIH 2 :

- **VIH 1** à trois groupes

- **M** : Main ou Major, avec 9 sous types A, B, C, D, F, G, H, J et K et des formes recombinantes circulantes

- **O** : Outlier, au Cameroun et au Gabon

- **N** : non M, non O, au Cameroun

- **VIH 2** : n'a qu'un seul groupe avec 7 sous types de A à G

Le VIH infecte les cellules clés du système immunitaire entraînant un déficit profond de l'immunité

(Structure figure 2)

Le VIH est un Rétrovirus caractérisé par :

- Sa taille de 90 à 120 nm
- Une enveloppe avec des glycoprotéines de surface dont la gp120 et la gp41 (VIH1)
- Une capside ou core
- Deux brins d'ARN monocaténaire
- Des enzymes (reverse transcriptase, intégrase, protéase)

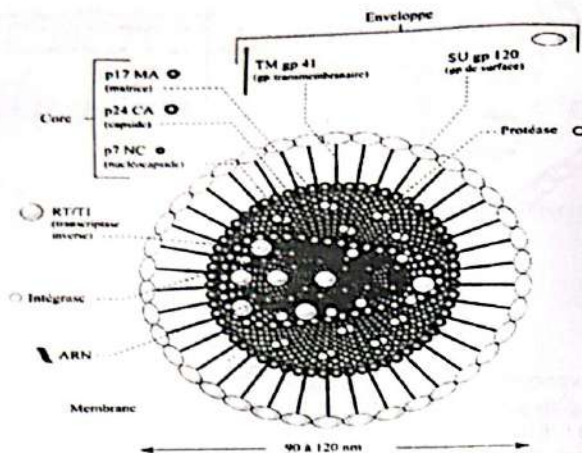


Figure 7 : Structure du VIH-1 d'après « Traité de virologie médicale », J.M.Hurax, éditions Estem, France, 2003

1.1.3 Propriétés physico chimiques du VIH

A l'extérieur de l'organisme le virus est très fragile, pour le détruire il suffit d'utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Chauffage du matériel contaminé à 121°C pendant au moins 20 minutes dans un autoclave et à ébullition continue pendant au moins 30 minutes ;
- Solution chlorée (eau de javel) diluée à 0,5% pendant 10 minutes ;
- L'éthanol à 70° (alcool médical) pendant 15 minutes ;
- Le glutaraldéhyde à 1% pendant au moins 10 mn ;
- Le formol à 0,5% pendant 30 à 60 mn.

1.1.4 Génome

Le génome du VIH-1 a une longueur d'environ 9200 bases. Il est constitué de trois régions principales appelées « gag » (group antigenspecific), « pol » (polymerasegene) « env ». (enveloppe gène) et de gènes accessoires (vif, vpr, tat, rev, nef, vpu). Les gènes de structure codent pour la nucléocapside, les enzymes virales, et les protéines de surface.

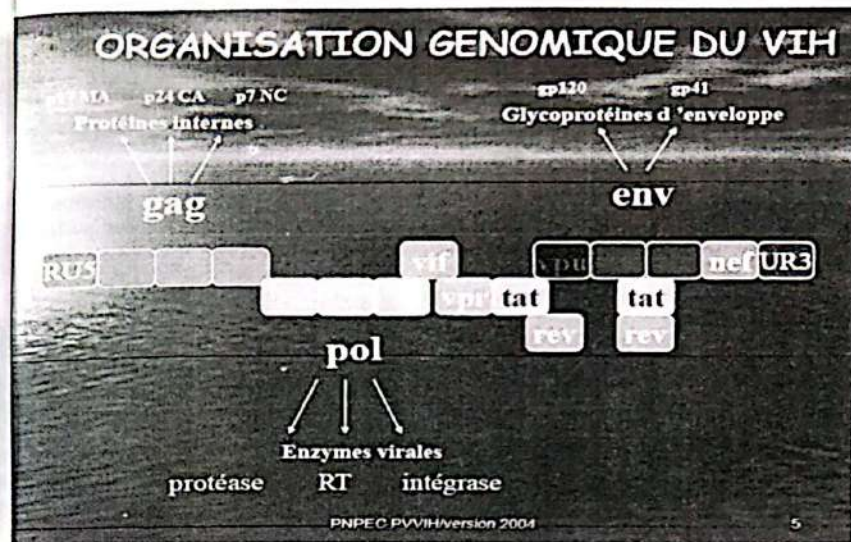


Figure 8 : Organisation génomique du VIH

Ce sont des cellules de l'immunité qui possèdent à leur surface le récepteur CD4:

- Lymphocytes T4
- Monocytes / macrophages
- Autres cellules (microgliales, folliculaires dendritiques, Langerhans)

1.1.5 Cycle de réplication

La réplication virale a pour conséquence le transfert du matériel génétique du VIH dans celui des cellules cibles. Ses différentes étapes sont :

• Reconnaissance des cellules cibles

Les glycoprotéines de l'enveloppe du VIH reconnaissent et se fixent sur les récepteurs CD4 et les corécepteurs CCR5 (pour les monocytes/macrophages) ou CXCR4 (pour les lymphocytes T4).

• Pénétration du virus

Après adsorption sur les cellules cibles un changement morphologique va entraîner la fusion de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale permettant la pénétration du VIH dans le cytoplasme de la cellule cible.

• Rétrotranscription

C'est la transformation de l'ARN viral en ADN proviral grâce à la transcriptase inverse ou reverse transcriptase.

• Intégration

L'intégrase virale permet l'intégration de cet ADN proviral dans le matériel génétique de la cellule cible transformant ainsi le virus en provirus.

• Production des particules virales

L'ADN pro viral est transcrit en ARN messager dont la traduction au niveau des ribosomes permet d'obtenir des protéines virales. Ces dernières subissent un clivage par la protéase virale pour donner des protéines virales. Celles-ci s'assemblent avec les enzymes et l'ARN viral pour donner après bourgeonnement sur la membrane cellulaire de nouvelles particules.

• Libération de virions

Les particules virales matures produites ou virions sont libérées après destruction de la cellule cible et sont capables d'infecter d'autres cellules exprimant à leur surface le récepteur CD4 et l'un des corecepteurs (CCR5 ou CXCR4).

Cycle schématique de réplication du VIH

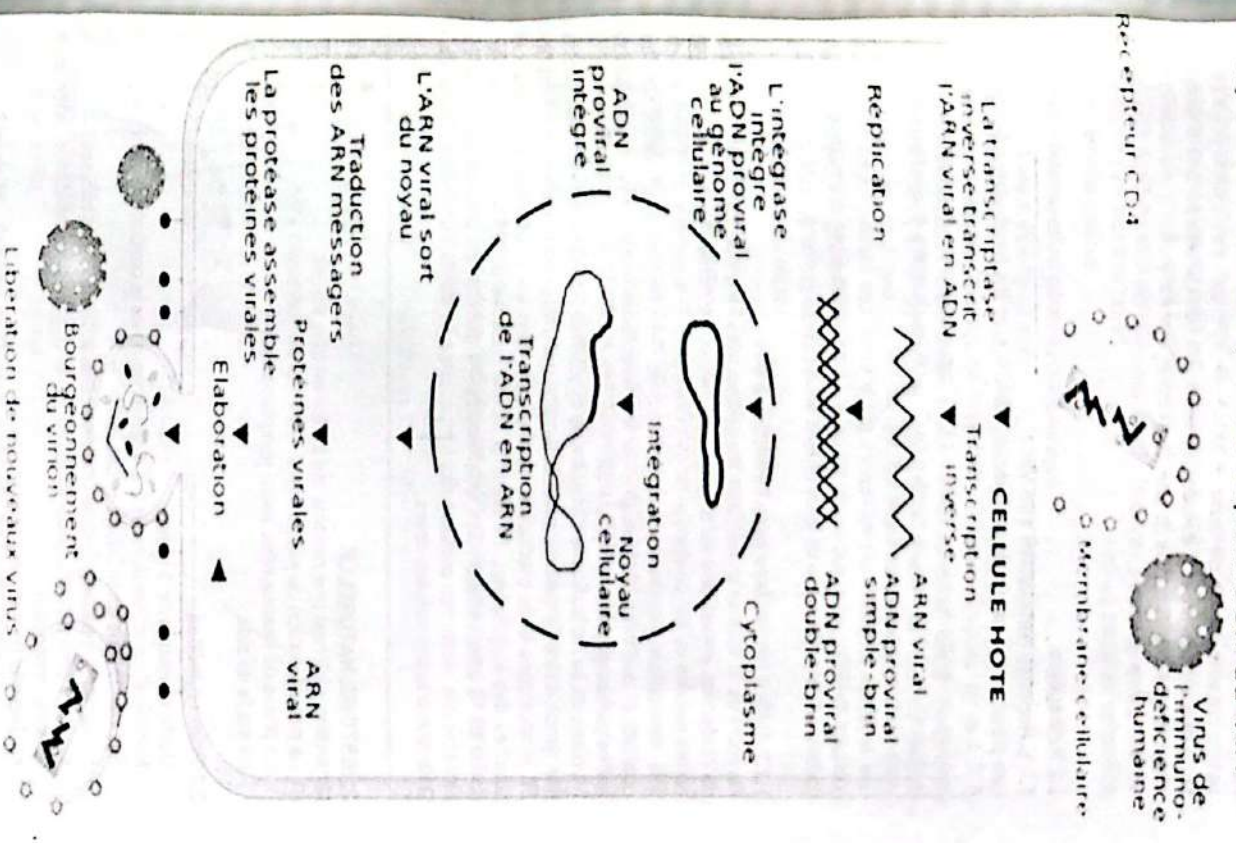


Figure 9 : Cycle de réplication du VIH

Remarques

Les principales étapes du cycle réplcatif du VIH sont des cibles potentielles des molécules antirétrovirales. La réplication du VIH est caractérisée par une cinétique rapide et par des erreurs de copies (le taux d'erreurs *in vivo* est évalué à une substitution pour 10 000 bases par cycle réplcatif). Cette variabilité du VIH explique l'existence des différentes variantes du virus.

1.2 Pathogénie

1.2.1. Réponse immunitaire anti-VIH

Les principaux éléments de la réponse anti-VIH sont les lymphocytes T8 cytotoxiques (CTL) et les anticorps. Les CTL détruisent les lymphocytes T4 et les macrophages infectés par le VIH qui les ont activés. Les CTL produisent des cytokines qui empêchent la réplication du VIH. Ainsi le nombre de CTL est inversement proportionnel à la charge virale plasmatique chez les sujets non traités.

Les anticorps anti-VIH sont inefficaces sur le virus. Les macrophages et leurs dérivés (cellules dendritiques et autres) du fait de leur localisation dans des nodules lymphoïdes constituent des réservoirs de virus (même sous ARV7).

1.2.2. Déficit immunitaire dans l'infection à VIH

Au cours de la réponse immunitaire, les lymphocytes T4 ont un rôle amplificateur (helper) de la réponse immunitaire qu'elle soit humorale ou cellulaire par contact direct avec les autres cellules ou par production de cytokines (IL-2, IFN-gamma, etc.). Le VIH entraîne une destruction progressive des lymphocytes T4 conduisant au déficit immunitaire qualitatif et quantitatif. Cela augmente la susceptibilité aux infections opportunistes et autres pathologies associées au sida.

Au cours de sa réplication le VIH entraîne directement ou indirectement une destruction des lymphocytes T4 matures (dont la fonction est d'augmenter l'action des lymphocytes T8 cytotoxiques et la production d'anticorps), mais aussi une déplétion des cellules souches des lymphocytes T4 (dans la moelle osseuse et le thymus) conduisant à un déficit de la compensation des lymphocytes T4 détruits. La persistance de la virémie entraîne une réinfection continue des lymphocytes T4 suivie d'une réplication virale et de l'infection d'autres cellules cibles.

2. HISTOIRE NATURELLE

L'infection à VIH est une maladie qui évolue en trois stades :

- La primo infection ou phase aiguë
- La phase de latence et/ou pauci symptomatique
- Le stade de sida

2.1 Primo infection

- Durée moyenne de 3 mois
- Multiplication active du virus 2 à 4 semaines après le contact infectant
- Symptomatique dans 20% des cas
 - Syndrome pseudo-grippal (malaise général, fièvre, algies diffuses)
 - Syndrome mononucléosidique (éruptions cutanées morbilliformes, adénopathies, splénomégalie)
 - Tableau de méningo-encéphalite

Disparition spontanée des manifestations cliniques en quelques jours (8 à 15 jours)

➤ Biologie

- Hémogramme : augmentation du pourcentage des lymphocytes, présence de lymphocytes atypiques et de monocytes hyper basophiles (> 10%)
- Sérologie VIH négative mais la séroconversion (apparition des anticorps anti-VIH) survient 1 à 3 mois après la contamination
- Charge virale souvent élevée
- Antigène p24 peut être positif
- Culture virale positive

2.2 Phase de latence et/ou pauci-symptomatique

- Durée : 3 ans à plus de 10 ans
- 2 formes cliniques :
 - Asymptomatique
 - Symptomatique : candidose buccale, zona, folliculite, fièvre, condylomes, Lymphadénopathie généralisée persistante symétrique indolore évoluant depuis plus de 3 mois
- Biologie
 - Sérologie VIH positive
 - Taux CD4 > 350/mm³ ou >20%
 - Charge virale peu élevée

2.3 Stade Sida

- Forme clinique terminale
- Symptômes
 - Amaigrissement : perte de poids ≥ 10%
 - Fièvre modérée persistante, continue ou intermittente > 1 mois
 - Diarrhée chronique continue, intermittente > 1 mois
 - Infections opportunistes (IOs8)
 - Proliférations malignes
- Biologie
 - Sérologie VIH positive
 - Taux CD4 < 200/mm³ (plus de 5 ans) ou <15% (enfant de moins de 5ans)
 - Charge virale très élevée.

Evolution de l'infection au cours du temps (Ref. 1)

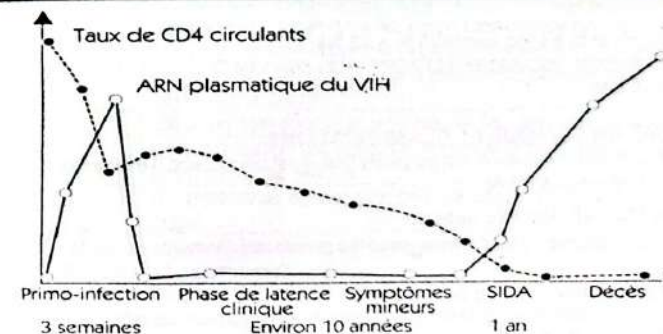


Figure 10 : Schéma de l'histoire naturelle de l'infection à VIH

2.4. Cas de l'enfant

Le mode d'évolution est superposable à celui de l'adulte avec les 3 stades d'évolution en dehors de la transmission mère-enfant qui représente 95% des cas.

2.4.1. Contamination mère-enfant

2.4.1.1. Evolution

Le passage à la phase sida est beaucoup plus rapide selon deux modes évolutifs :

- Evolution précocement sévère
- Evolution lentement progressive

Tableau IX : Evolution de l'infection à VIH chez l'enfant

	Précocement sévère	Lentement progressive
Contamination	In utero	Per partum, allaitement
Apparition du sida	3 à 15 mois	2 ans à plus de 10 ans
Signes cliniques	• Adénopathies • Splénomégalie • Candidose • Retard de croissance • IOs graves à répétitions • Encéphalopathie 70-80 %	• Retard statural et pubertaire • Infection bactérienne • Pneumopathie • Parotidite chronique
Survie moyenne	Moins de 10% à 5 ans	95% à 5ans

Selon l'OMS l'évolution de l'infection à VIH des enfants infectés en période périnatale est classée en 3 catégories :

2.4.1.2. Progressseurs rapides (25%-30%)

Ces enfants acquièrent l'infection in utero ou au cours de la période périnatale précocement et le décès survient avant l'âge d'un an.

2.4.1.3. Enfants développant précocement des symptômes (50 % à 60%)

Ce sont les enfants chez qui survient une dégradation rapide de l'état clinique et le décès entre 3 et 5 ans d'âge.

2.4.1.4. Survivants à long terme (5 % à 25 %)

Ce sont les enfants qui acquièrent l'infection au cours de l'allaitement. Ils vivent au-delà de l'âge de 8 ans.

3. EVALUATION CLINIQUE ET CLASSIFICATIONS

Les manifestations cliniques étant polymorphes, il est nécessaire d'évaluer le client et de déterminer son stade évolutif.

3.1. Evaluation clinique du patient

L'évaluation clinique du client se base sur les principaux éléments suivants :

3.1.1 Interrogatoire

Il s'agit d'un entretien avec le client pour recueillir les informations relatives à :

- Identification du client
- Recherche les caractéristiques sociodémographiques
- Motif de consultation
- Demande le motif de la visite
- Histoire de l'évolution de la maladie

Demande au malade de vous raconter l'histoire de sa maladie (évolution des symptômes)

- Antécédents de la maladie

Recherche les antécédents de la maladie

3.1.2 Signes généraux

Il s'agit de la prise des constantes et l'appréciation de l'état général. Ces signes généraux permettent d'apprécier l'indice de Karnofsky.

Prend les constantes

- Poids
- Température
- Tension artérielle
- Poids
- Périmètre brachial
- pli cutané

Recherche de signes d'altération de l'état général :

- Amaigrissement,
- Anorexie (totale, sélective)
- Asthénie (physique, psychique, sexuelle)
- Apprécie l'indice de Karnofsky

C'est une gradation de l'état du malade selon qu'il n'éprouve aucun symptôme de la maladie ou de façon mineure et la dépendance totale du malade incapable d'effectuer seul le moindre geste et avoir donc besoin de l'assistance d'un tiers de façon occasionnelle ou permanente :

Tableau X : Indice de Karnofsky

Degré d'activité	Activités
100%	Normal, aucune évidence de maladie
90%	Capable d'assurer une activité normale, signes mineurs de maladie
80%	Capable exécuter une activité normale mais avec effort ; quelques signes apparents de la maladie
70%	Peut assurer ses soins, mais incapable d'exécuter une activité normale ou de faire un travail actif
60%	Dépendance occasionnelle, exige l'assistance occasionnelle mais est capable d'assurer la plupart de ses propres besoins
50%	Dépendance totale, exige une assistance considérable et un soin médical fréquent
40%	Exige un soin spécial et une assistance, statut de handicap
30%	L'hospitalisation est indiquée, même si la mort n'est pas tout de suite, handicap sévère
20%	Hospitalisation nécessaire, très malade, traitement positif actif exigé.
10%	Le processus fatal progresse rapidement ; moribond

3.1.3 Examen appareil par appareil

Commence de préférence par l'appareil le plus concerné par la pathologie soupçonnée lors de l'interrogatoire

3.2. Classifications

Il existe plusieurs classifications, celle de l'OMS (1990) révisée en 2005 et celle du CDC (1993) pour l'adulte et (1994) pour l'enfant.

3.2.1 Classification OMS

➤ Classification clinique

Tableau XI : Classification clinique (OMS)

Stade clinique	Adultes et adolescents OMS - Version révisée 2006	Classification Enfants OMS – 2004
Stade clinique 1 :	- Patient asymptomatique - Adénopathies persistantes généralisées	- Patient asymptomatique - Lymphadénopathie persistante généralisée (PGL) - Hépatosplénomégalie
Stade clinique 2 :	- Perte de poids involontaire < 10 % du poids corporel - Dermite séborrhéique - Prunigo - Atteinte fongique des ongles - Ulcérations buccales récurrentes - Chéilite angulaire - Zona - Infections récidivantes des voies respiratoires supérieures	- Éruptions de papules prurigineuses - Dermite séborrhéique - Mycoses des ongles - Cheilite angulaire - Érythème gingival linéaire - Papilloma virus humain ou molluscum contagiosum étendus (> 5 % de la surface corporelle/faciale) - Ulcérations buccales récurrentes (> 2 épisodes/6 mois) - Parotidomégalie - Herpès zoster (> 1 épisode/12 mois) - Infection récurrente ou chronique des voies respiratoires supérieures (IVRS) : otite moyenne, otorrhée, sinusite (> 2 épisodes/6 mois)
Stade clinique 3 :	- Perte de poids involontaire ≥ 10 % du poids corporel - Diarrhée chronique inexpliquée > 1 mois - Fièvre prolongée (> 1 mois) inexpliquée (> 37,6 °C, intermittente ou constante) - Candidose buccale persistante - Leucoplasie chevelue buccale - Tuberculose pulmonaire en cours - Infection bactérienne sévère - Gingivite, périodontite ou stomatite ulcéreuse aiguës nécrosantes - Anémie < 8 g/100 mL, neutropénie < 500/mm ³ ou thrombocytopénie < 50 000/mm ³ inexpliquées	- Malnutrition modérée inexpliquée (score -2 SD ou score Z) - Ne répondant pas à une thérapie standard - Diarrhée persistante inexpliquée (> 14 jours) - Fièvre persistante inexpliquée (intermittente ou constante, > 38,5 °C de durée > 1 mois) - Candidose orale (en dehors de la période néonatale) - Leucoplasie chevelue de la langue - Tuberculose pulmonaire - Pneumonie sévère ou récurrente, présumée bactérienne (> 2 épisodes/12 mois) - Gingivite ulcéro-nécrotique/parodontite aiguës - Pneumopathie lymphoïde interstitielle (PIL)

Stade clinique	Adultes et adolescents OMS - Version révisée 2006	Classification Enfants OMS – 2004
		- Épisodes inexpliqués d'anémie (< 8 g/dl), neutropénie (< 1 000/mm ³) ou thrombocytopénie (< 30 000/mm ³) pendant > 1 mois. - Myocardopathie liée au VIH - Néphropathie liée au VIH
Stade clinique 4	- Syndrome cachectique lié au VIH - Pneumopathie à <i>Pneumocystis jiroveci</i> - Pneumonie bactérienne récurrente - Herpès cutané-muqueux > 1 mois, ou herpès viscéral quelle que soit la durée - Candidose de l'œsophage, de la trachée, des bronches ou des poumons - Tuberculose extra-pulmonaire - Maladie de Kaposi - Infection à CMV (rétinite, ou viscérale autre) - Toxoplasmose cérébrale - Encéphalopathie à VIH - Cryptococcose extra-pulmonaire - Mycobactériose atypique disséminée - Leucoencéphalopathie multifocale progressive - Cryptosporidiose chronique (avec diarrhée) - Isosporose chronique - Mycose endémique disséminée (histoplasmosse, coccidioidomycose) - Bactériémie à salmonelles non typhiques récurrente - Lymphome (cérébral ou à cellule B non hodgkien) ou autre tumeur solide associée au VIH - Carcinome invasif du col utérin - Leishmaniose viscérale - Néphropathie ou cardiopathie liée au VIH symptomatique	- Chez le nourrisson < 18 mois* positif pour les anticorps anti-VIH et symptomatique Deux ou plusieurs critères parmi : - Candidose orale/érythème buccal - Pneumonie sévère - Développement insuffisant - Sepsie * Un diagnostic présomptif du stade clinique 4 de la maladie chez des Nourissons < 18 mois positifs pour les anticorps anti-VIH, nécessite une confirmation par des tests virologiques de dépistage du VIH, au-tant que possible, ou par les tests anticorps après l'âge de 18 mois. - à tout âge : - Sévère amaigrissement ou malnutrition sévère inexpliquée (score -2 SD ou score Z) ne répondant pas à une thérapie standard - Pneumonie à <i>Pneumocystis jiroveci</i> - Infections bactériennes sévères récurrentes (> 2 épisodes/12 mois, à l'exception de la pneumonie) - Herpès orolabial ou cutané dû à HSV - Tuberculose extra-pulmonaire - Maladie de Kaposi - Candidose œsophagienne - Toxoplasmose du SNC - Méningite cryptococcique - Toute mycose endémique, disséminée

Stade clinique	Adultes et adolescents OMS - Version révisée 2006	Classification Enfants OMS - 2004
		- Cryptosporidiose ou isosporose (avec diarrhée > 1 mois) - Une infection à CMV d'autres organes que le foie, la rate, les ganglions lymphatiques (et apparition à > 1 mois) - Maladie mycobactérienne disséminée autre que la tuberculose - Candidose de la trachée, des bronches ou des poumons - Fistule vésico-rectale acquise - Lymphome cérébral ou lymphome B non Hodgkinien - Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) - Encéphalopathie à VIH

➤ Classification immunologique
Cette classification est présentée dans le tableau IX

Tableau XII : Classification immunologique du déficit associé au VIH (OMS 2005)

Immunodéficience associée au VIH	Taux de CD4 en fonction de l'âge (% ou nombre absolu/mm ³)			
	<11 mois (%)	12-35 mois (%)	36-59 mois (%)	>5 ans mm ³
Absence de déficit	>35	>30	>25	>500
Déficit modéré	30-35	25-30	20-25	350-499
Déficit avancé	25-30	20-25	15-20	200-349
Déficit sévère	<25	<20	<15	<200

3.2.2 Classification CDC

Cette classification combine les signes cliniques et le taux de lymphocytes CD4.

➤ Pour les adultes et adolescents > 13 ans (1993)

Catégorie A

- Asymptomatique
- Primo-infection
- Lymphadénopathie généralisée persistante

Catégorie B

- Candidose oro-pharyngée
- Candidose vaginale persistante, fréquente
- Dysplasie du col

- Fièvre ou diarrhée > un mois
- Leucoplasie chevelue de la langue
- Zona récurrent
- Purpura thrombocytopénique idiopathique
- Neuropathie périphérique

Catégorie C

- Candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire
- Candidose œsophagienne
- Cancer invasif du col
- Cryptococcose extra pulmonaire
- Cryptosporidiose intestinale > un mois
- Rétinite à CMV
- Toxoplasmose cérébrale
- Syndrome cachectique lié au VIH
- Leucoencéphalopathie multifocale progressive
- Isosporose intestinale chronique > un mois
- Sarcome de Kaposi
- Histoplasmosse disséminée
- Infection à *Mycobacterium tuberculosis*
- Infection à *Mycobacterium avium* ou *M. kansasii*
- Pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*
- Pneumopathie bactérienne récurrente
- Septicémie à *Salmonella* non typhi récurrente
- Lymphome cérébral primaire

Tableau XIII : Classification CDC 1993

Nombre de CD4/mm ³	A	B	C
>500 (>29%)	A1	B1	C1
200-499 (14-29%)	A2	B2	C2
<200 (<14%)	A3	B3	C3

➤ Pour les enfants < 13 ans (CDC 1994)

Définition clinique des cas :
la définition clinique et la classification clinique ont été faites à partir de celle du CDC (ci-dessous)

Catégorie N :

- Asymptomatique

Catégorie A : Symptômes mineurs :

- Lymphadénopathie
- Hépatosplénomégalie, dermatose, parotidite, infections ORL ou bronchiques récurrentes.

Catégorie B : Symptômes modérés :

- Infection bactérienne

- Pneumopathie interstitielle lymphoïde
- Thrombopénie, anémie, neutropénie
- Zona, candidose ou herpès buccal récidivant
- Néphropathie
- Cardiopathie
- Léiomyosarcome

Catégorie C : Symptômes sévères :

- Infection opportuniste
- Infection bactérienne sévère répétée
- Encéphalopathie
- Lymphome ou cancer
- Cachexie

Enfant de moins de 13 ans

Tableau XIV : Classification immunologique CDC1994

Catégories immunitaires	<12mois	1-5 ans	6-12 ans
Absence de déficit immunitaire	>1 500/mm ³ >25%	>1 000/mm ³ >25%	>500/mm ³ >25%
Déficit modéré	750-1 499/mm ³ 15 -24%	500-1 000/mm ³ 15 -24%	200-499/mm ³ 15 -24%
Déficit sévère	<750/mm ³ <15%	<500/mm ³ <15%	<200/mm ³ <15%

Tableau XV : Classification clinique et immunologique du malade

Catégories cliniques	N	A	B	C
Catégories immunologiques				
1. Sans déficit immunitaire	N1	A1	B1	C1
2. Déficit immunitaire modéré	N2	A2	B2	C2
3. Déficit immunitaire	N3	A3	B3	C3

CONCLUSION

- Les étapes de l'évolution de l'infection à VIH sont importantes à connaître
- La classification de la maladie aidera le clinicien à mieux prendre en charge son patient.

CHAPITRE 4 : SERVICES DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH

INTRODUCTION

Les personnes infectées par le VIH restent asymptomatiques pendant des périodes de durée variable et peuvent ne pas se savoir infectées. Des manifestations cliniques peuvent faire suspecter la maladie mais ces signes ne suffisent pas pour poser un diagnostic de l'infection à VIH chez une personne. Dans tous les cas, seul le diagnostic biologique permet de confirmer l'infection à VIH.

Les trois composantes de base des services de dépistage sont le conseil pré-test, le test et le conseil post test. Ces trois éléments en plus de la référence active constituent le paquet minimum des services de Dépistage du VIH.

Le management de la qualité est essentiel pour les services de dépistage garantissant un résultat correct et la sécurité au poste de travail.

Objectif général

A la fin de ce module, le participant sera à mesure d'offrir les services de dépistage du VIH de qualité au client.

Objectifs spécifiques

1. Principes du changement de l'algorithme de dépistage du VIH
2. Réaliser le dépistage par les tests rapides
3. Expliquer les stratégies de dépistage au niveau national
4. Assurer la réalisation d'un DBS
5. Assurer la qualité des services de dépistage
6. Conduire le conseil au poste de dépistage
- 7.

Plan du cours

1. Diagnostic biologique de l'infection à VIH
2. Stratégies de dépistage de l'infection à VIH
3. Procédures de prélèvements et de réalisation de tests rapides et PCR
4. Conseil au poste de dépistage

I. PRINCIPES DU CHANGEMENT DE L'ALGORITHME DE DÉPISTAGE DU VIH

1. OBJECTIF GENERAL

le participant doit être capable d'expliquer les principes du changement de l'algorithme de dépistage du VIH.

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Décrire les méthodes diagnostic du VIH
- Définir les notions de stratégies et d'algorithmes de dépistage du VIH
- Expliquer les principes du changement de l'algorithme

3. METHODES DIAGNOSTIC DU VIH

3.1 Diagnostic biologique de l'infection à VIH

- Diagnostic de l'infection à VIH comprend:
 - ✓ Un diagnostic direct
 - ✓ Un diagnostic indirect

3.2 Méthodes directes

- Mise en évidence
 - ✓ soit du virus entier

- ✓ soit de ses constituants
- Techniques
 - ✓ Isolement du virus
 - ✓ Détection de antigène p24 (isolée ou combinée)
 - ✓ Techniques de biologie moléculaire: qualitatives (PCR = Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaîne) ou quantitatives (CV=Charge Viral)

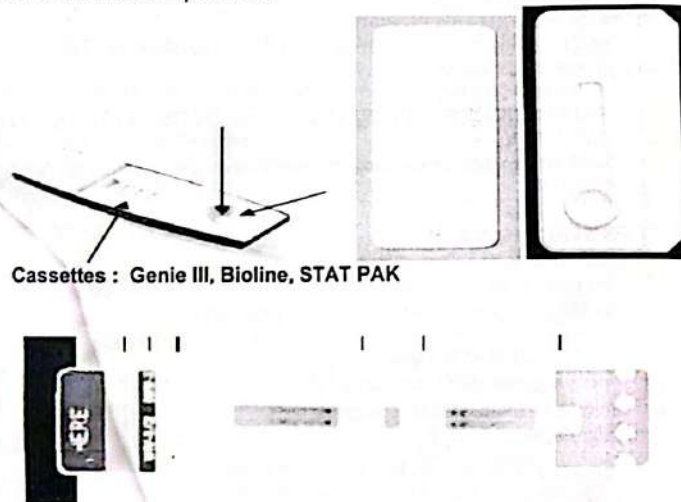
3.3 Méthodes indirectes

- Correspondent à la mise en évidence des anticorps anti-VIH circulants (Anticorps anti-VIH 1 et Anticorps anti-VIH 2)
- Techniques
 - Les tests de dépistage
 - ✓ les tests immunoenzymatiques ou enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
 - ✓ les tests rapides
 - Les tests complémentaires
 - ✓ Le Western Blot
 - ✓ Les tests immuno-analyse en ligne ou line immuno-assay (LIA)

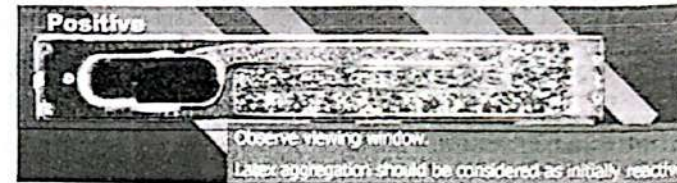
3.4 Définition des tests rapides

- ✓ Tests de dépistage repose sur la détection des Ac Anti VIH (anticorps anti VIH)
- ✓ Exécution rapide qui se fait dans un intervalle de temps de 5-30 minutes
- ✓ Simple car ne nécessite pas de matériel/équipement sophistiqué
- ✓ Exécution facile car implique une procédure simple/formation aisée.

3.5 Formats des tests rapides VIH



• Bandelettes : Determine



• Lame capillaire : Capillus

3.6 Principes des tests rapides

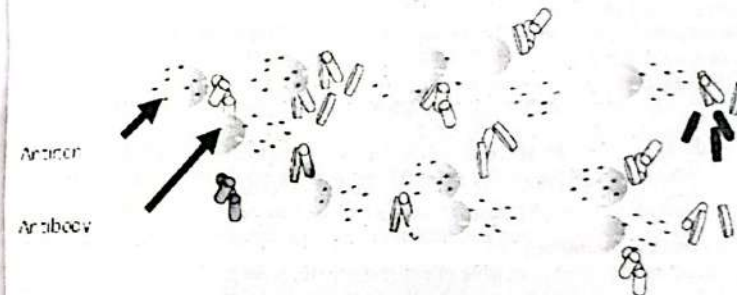


Figure 11 : Liaison antigène-anticorps

- ✓ Basés sur présence d'Ag VIH (antigène VIH) sur support
- ✓ Principe d'immuno-chromatographie ou de filtration sur membrane :
- ✓ Migration du sérum par capillarité en entraînant avec lui des réactifs déjà présents sur support du test
- ✓ Filtration par membrane puis rencontre des Ag (antigène VIH) déposés sur membrane
- ✓ Révélation de la réaction Ag-Ac (antigène VIH-anticorps antiVIH)) par colorimétrie
- ✓ Présence de contrôle interne
- ✓ Positivité implique la présence du trait de contrôle interne indispensable pour valider les réactions du test.

3.7 Avantages des tests rapides

- ✓ Réalisation par des prestataires non personnelles de laboratoire formés à cet effet ;
- ✓ Les tests offrent une plus grande satisfaction car les résultats peuvent être communiqués le même jour.
- ✓ Conservation à température ambiante
- ✓ Pas besoin d'équipement spécialisé
- ✓ Réalisable avec sang capillaire (ou fluide buccal)
- ✓ NB: Ne pas utiliser les TDR pour (re)faire un dépistage du VIH d'une personne sous TARV car risque de faux négatif

3.8 Inconvénients des tests rapides

- ✓ Faible sensibilité dans les phases précoces de l'infection
- ✓ Non conservation de test utilisé → absence de traçabilité quant à sa réalisation, sa validation et son interprétation
- ✓ Stabilité du résultat (résultat non stable au-delà du temps de lecture requis pour chaque test)

4. STRATEGIES ET ALGORITHMES

4.1 Définitions

Définition de la stratégie

- ✓ Une stratégie est une combinaison de tests en vue du dépistage de l'infection VIH
- ✓ Stratégie est fonction de l'objectif du dépistage.

Définition de l'algorithme

- Un algorithme est un arbre décisionnel ou une séquence d'utilisation de tests en vue d'un dépistage
- On distingue:
 - ✓ Algorithme de tests en parallèle: Echantillons testés simultanément par un ou plusieurs tests différents
 - ✓ Algorithme de tests en série: Echantillons testés par un premier test test sensible et Seuls les échantillons positifs sont soumis à 1 voire 2 autres tests

Définition de la Sensibilité :

- ✓ Proportion d'individus positifs effectivement détectés par le test
- ✓ Plus un test est sensible, plus il détecte la présence des anticorps anti VIH

Définition de la Spécificité :

- ✓ Proportion d'individus négatifs effectivement détectés par le test
- ✓ Plus un test est spécifique, plus il détecte l'absence des anticorps anti-VIH

Définition de la valeur prédictive positive (VPP)

- correspond à la probabilité qu'un sujet soit réellement malade lorsque le résultat de l'algorithme (la combinaison des tests) est positif.
- ✓ VPP 99% = sur 100 tests positifs, 99 correspondent à des patients vraiment malades (1 faux positif)

Définition de la valeur prédictive négative (VPN)

- correspond à la probabilité qu'un sujet soit vraiment non-malade lorsque le résultat de l'algorithme est Négatif.
- ✓ VPN 99% = sur 100 tests négatifs 99 correspondent à des patients vraiment non-malades (1 faux négatif)
- ✓ Les valeurs prédictives sont dépendantes à la fois de la sensibilité et de la spécificité de chacun des tests mais aussi de la prévalence de la maladie dans la population testée.

5. CRITERES DE CHOIX TEST ET ALGORITHME

5.1 Critères de choix Sensibilité (100%)

- ✓ Spécificité (> 98%)
- ✓ Objectifs du dépistage (sécurité transfusionnelle, surveillance épidémiologique, diagnostic)
- ✓ Détection et/ou discrimination des VIH-1 et VIH-2

- ✓ Simplicité, coût, conditions de stockage
- ✓ Prévalence

==> Aucun test ne remplit l'ensemble des critères
Nécessité de combiner 2 ou plusieurs tests VIH

6. PRINCIPE DU CHANGEMENT D'ALGORITHME

Contexte du changement d'algorithme de dépistage

- ✓ Avec une prévalence de 1.82% et un nombre de PVVIH estimé à 421 262 (Spectrum 2024), l'épidémie à VIH demeure un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire
- ✓ En vue de l'élimination du sida à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'objectif 95-95-95 de l'ONUSIDA, boussole de son PNS 2021-2026
- ✓ L'atteinte de cet objectif passe par le dépistage des personnes vivant avec le VIH
- ✓ A cet effet, un algorithme de dépistage a été adopté et utilise deux tests en série pour le dépistage du VIH au poste de dépistage et au laboratoire.
- ✓ Sur la base des recommandations 2019 de l'OMS, la CI a procédé à la Révision de l'algorithme de dépistage du VIH : passant d'un algorithme à deux tests à un algorithme à trois tests de diagnostic rapide du VIH

7. RECOMMANDATIONS DE L'OMS POUR UN DIAGNOSTIC VIH FIABLE

7.1 Recommandations l'OMS pour le dépistage VIH

Utilisation dans la stratégie de dépistage de tests sérologiques dont la qualité est assurée, préqualifiés par l'OMS:

- ✓ sensibilité $\geq 99\%$: moins de 1 'faux négatif' pour 100 vrais positifs.
- ✓ spécificité $\geq 98\%$: moins de 2 'faux positifs' pour 100 vrais négatifs.

Stratégie de dépistage doit avoir une valeur prédictive positive (VPP) $\geq 99\%$ dans tous les contextes d'utilisation.

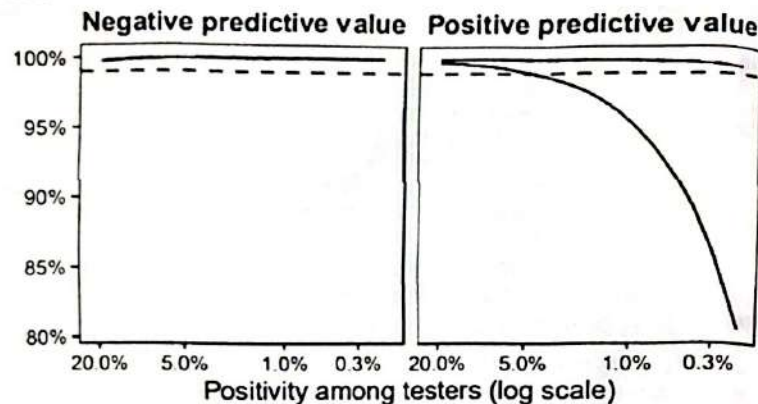
Toutes les personnes nouvellement diagnostiquées VIH positives doivent refaire le test avant de débuter un traitement ARV à vie (mesure d'assurance qualité du Dépistage).
Comblent les lacunes dans le dépistage de la syphilis chez la femme enceinte.

7.2 VPP et la VPN dépendent du taux de positivité/prévalence parmi les personnes testées

Prévalence	Pour 100,000 testés	Après 1 test	Après 2 tests	Après 3 tests
10%	10,000 HIV+ 90,000 HIV-	9900 vrai+ (99%) 1800 faux+ (2%) 85% VPP	9801 vrai+ 36 faux+ 99.6% VPP	9703 vrai+ 0.7 faux+ 99.9% VPP
5%	5000 HIV+ 95,000 HIV-	4950 vrai+ 1900 faux+ 72% VPP	4901 vrai+ 38 faux+ 99.2% VPP	4851 vrai+ 0.8 faux+ 99.9% VPP
1%	1000 HIV+ 99,000 HIV-	990 vrai+ 1980 faux+ 33% VPP	980 vrai+ 40 faux+ 96% VPP	970 vrai+ 0.8 faux+ 99.9% VPP
0.1%	100 HIV+ 99,900 HIV-	99 vrai+ 1998 faux+ 5% VPP	98 vrai+ 40 faux+ 70% VPP	97 vrai+ 0.8 faux+ 99.1% VPP

VPP : résultat pour 100 000 personnes testées à différentes prévalences
Hypothèse : 99% sensibilité, 98% spécificité, tests en série
Seule la stratégie à 3 tests maintient une VPP $\geq 99\%$ à des hautes et faibles prévalences

7.3 VPP et la VPN dépendent du taux de positivité/prévalence parmi les personnes testées



Lorsque le taux de positivité parmi les personnes testées diminue:
La VPN stratégies 2 et 3 tests restent élevées et stables,
La VPP stratégie 3 tests (bleue) reste $\geq 99\%$;
La VPP stratégie 2 tests (en rouge) diminue ;
Il est recommandé aux pays ayant un taux de VIH faible (<5% de prévalence nationale) d'utiliser 3 tests réactifs consécutifs pour un diagnostic du VIH fiable.

8. ETAPES D'ÉLABORATION DE L'ALGORITHME DE DÉPISTAGE DU VIH A 3 TESTS

8.1 Etapes du processus de révision de l'algorithme de dépistage du VIH

Le processus a suivi les étapes suivantes :

- Adoption des recommandations de l'OMS
- Evaluation du nouvel algorithme de dépistage du VIH en Côte d'Ivoire
- Phase pilote des algorithmes sélectionnés

9. EVALUATION DU NOUVEL ALGORITHME DE DÉPISTAGE DU VIH EN CÔTE D'IVOIRE

Objectif général : Adopter un algorithme séquentiel à trois tests rapides pour le dépistage de l'infection à VIH en Côte d'Ivoire.

Objectifs spécifiques :

Évaluer les performances techniques de TDR VIH en vue d'une homologation par l'AIRP ;
Élaborer des algorithmes pour le dépistage du VIH par des TDR ;
Évaluer les performances techniques et opérationnelles des algorithmes sélectionnés ;
Valider un algorithme de dépistage adapté au passage à échelle.

9.1 PHASE 1 : Evaluation des performances techniques de Tests de diagnostic rapides (TDR) en vue d'une homologation par l'AIRP .

9.1.1 Test évalués

	Tests VIH	Duo-tests VIH/Syphilis
01	Détermine HIV Early Detect	Standard Q HIV/Syphilis
02	Wondfo HIV	Bioline HIV/Syphilis
03	Standard Q HIV	
04	Uni Gold HIV	
05	Trinscreen HIV	
06	Das Labor Anti-HIV	
07	Détermine HIV	
08	Stat Pak	

9.1.2 Critères de choix

- ✓ Performances techniques des test (Sensibilité, Spécificité, VPN, VPP)
- ✓ Réactivité croisée VIH
- ✓ Présentation des tests
- ✓ Présence de lancette rétractable dans le kit
- ✓ Simplicité de réalisation
- ✓ Coût
- ✓ Conditions de stockage

9.1.3 Tests sélectionnés

	T1	T2	T3
Population générale	One Step WONDFO HIV1/2 Test	HIV 1/2 STAT-PAK	Uni-Gold HIV Ou TOYO Anti-HIV 1/2 Test
Femmes enceintes	Bioline HIV/Syphilis Duo	HIV 1/2 STAT-PAK	Uni-Gold HIV Ou TOYO Anti-HIV 1/2 Test
Retesting	One Step WONDFO HIV1/2 Test	HIV 1/2 STAT-PAK	Uni-Gold HIV Ou TOYO Anti-HIV 1/2 Test
Tests supplémentaires	TrinScreen HIV Ou Détermine HIV-1/2*	TOYO Anti-HIV 1/2 Test ou Uni-Gold HIV	
Laboratoire (Bilan initial)	Bioline HIV-1/2 3.0\$. En cas de résultat HIV 1-2 (ou Dual) faire le Geenius HIV 1/2 Confirmatory Assay\$		

* pour la CPN les tests supplémentaires T1 seront One Step WONDFO HIV1/2 Test et un autre TDR Syphilis.

9.2 PHASE 2 : Phase pilote

- Les algorithmes sélectionnés ont fait l'objet d'une phase pilote au cours de laquelle les acteurs ont apprécié :
 - ✓ caractéristiques opérationnelles
 - ✓ faisabilité
 - ✓ l'acceptabilité
- Les nouvelles directives de dépistage du VIH ont été adoptées suite à la validation des résultats de la phase pilote

RECAP

- Quels sont les avantages des TDR
- Qu'est-ce que la VPP
- Quel est le principe de base sur lequel repose le passage de l'algorithme de dépistage du VIH à 03 tests

II. NOUVELLES DIRECTIVES NATIONALES DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH

PLAN

- Dépistage de l'infection à VIH
- Re-testing des clients dépistés séropositifs au VIH avant la mise sous traitement ARV
- Référence des clients vers les services de prévention et de prise en charge.

1. UTILISATION D'UN ALGORITHME SEQUENTIEL A 3 TESTS RAPIDES POUR LE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH

1.1 DEPISTAGE DE LA POPULATION GENERALE A PARTIR DE 18 MOIS

□ Le dépistage du VIH est réalisé :

- dans les services cliniques,
- au laboratoire,
- dans les centres communautaires
- en stratégies avancées

□ Utilise l'algorithme de dépistage à trois TDR suivants :

- Premier test : Wondfo HIV
- Deuxième test : Stat Pak HIV
- Troisième test : Uni Gold HIV

ANNEXE 1 : ALGORITHME DE DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS DE PLUS DE 18 MOIS (DEPISTAGE ET RETESTING AU POSTE DE DEPISTAGE)



Figure 12 : Algorithme en vigueur au laboratoire

NB : En dehors de cet algorithme, tout test de dépistage du VIH (y compris l'auto-test VIH oral ou sanguin) est un test d'orientation diagnostique.

Si le résultat est réactif, le client doit bénéficier d'un dépistage avec l'algorithme à 03 tests.

1.2 DEPISTAGE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES/ALLAITANTES

- Toutes les femmes enceintes/allaitantes doivent bénéficier d'un dépistage du VIH, de la Syphilis et de l'Hépatite Virale B,
 - au moins une fois au cours de leur grossesse
 - le plus tôt possible (au cours du premier trimestre de la grossesse de préférence).
- Utilisation d'un algorithme de dépistage à 03 TDR dont le premier est un test duo VIH/Syphilis:
 - Premier test : Bioline HIV/Syphilis
 - Deuxième test : Stat Pak HIV
 - Troisième test : Uni Gold HIV
- Ajout d'un test de détection de l'Ag HBS pour le diagnostic de l'hépatite virale B.

ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH CHEZ LES FEMMES ENCEINTES/ALLAITANTES



1.3. DEPISTAGE DE CONTROLE DES CLIENTS SERONEGATIFS

- ✓ Un dépistage de contrôle doit être réalisé pour tout client testé négatif et soumis à une exposition continue de l'infection à VIH
- ✓ Réalisé dans :
 - les services cliniques,
 - les centres communautaires
 - En stratégies avancées
- ✓ Utilise l'algorithme à 03 tests suivant :
 - Premier test : Wondfo HIV
 - Deuxième test : Stat Pak HIV
 - Troisième test : Uni Gold HIV
- ✓ Le dépistage de contrôle est réalisé selon la périodicité suivante :

Type de population	Périodicité du dépistage de contrôle
Populations clés	Tous les 06 mois
Femmes enceintes	Dans le dernier trimestre de la grossesse ou en salle d'accouchement ou en suites de couche
Femmes allaitantes	A 14 semaines et à 09 mois après l'accouchement
Enfants exposés	1 mois après l'arrêt de l'allaitement pour l'enfant de plus de 18 mois
Conjoint séronégatif d'un couple sérodifférent	Une fois par an
Autres populations	1 mois après une exposition au VIH

1.4. RE-TESTING DES CLIENTS DEPISTES SEROPOSITIFS AU VIH AVANT LA MISE SOUS TRAITEMENT ARV

1.4.1 Re-testing des clients dépistés séropositifs au VIH

Tout client dépisté séropositif au VIH doit bénéficier d'un re-testing par un autre prestataire (différent de celui qui a réalisé le dépistage) avant sa mise sous traitement antirétroviral (TARV).

Le re-testing se fera dans les services cliniques, au laboratoire ou dans les centres communautaires réalisant la mise sous TARV.

Le re-testing réalisé dans les services cliniques ou dans les centres communautaires utilise le même algorithme à trois tests aussi bien pour la population générale que pour les femmes enceintes/allaitantes :

- ✓ Premier test : Wondfo HIV
- ✓ Deuxième test : Stat Pak HIV
- ✓ Troisième test : Uni Gold HIV

Le re-testing réalisé au laboratoire utilise l'algorithme à trois tests suivants, aussi bien pour la population générale que pour les femmes enceintes/allaitantes :

- ✓ Premier test : Wondfo HIV
- ✓ Deuxième test : Stat Pak HIV
- ✓ Troisième test : Bioline HIV

NB : Si le re-testing est réalisé dans les services cliniques ou dans les centres communautaires, le laboratoire effectuera uniquement le test de discrimination (Bioline HIV) dans le cadre du bilan initial

ALGORITHME DE RETESTING AU LABORATOIRE



2. LA REFERENCE DES CLIENTS VERS LES SERVICES DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE

2.1 Référence des clients

Les clients dépistés séronégatifs seront référés vers les services de prévention selon le tableau suivant :

	VIH	Syphilis	Ag HBS
Négatif	✓ Elaborer un plan de réduction des risques ✓ Distribuer des préservatifs dans le cadre de la prévention combinée aux populations cibles ✓ Mettre sous PrEP si client éligible	✓ Elaborer un plan de réduction des risques ✓ Distribuer des préservatifs dans le cadre de la prévention combinée aux populations cibles	✓ Proposer la vaccination contre l'hépatite B

- Les clients dépistés séropositifs seront référés vers les services de prise en charge selon le tableau suivant :

	VIH	Syphilis	Ag HBS
Positif	✓ Mettre le client sous TARV selon les directives nationales	✓ Pénicilline G benzathine 2,4 M unités : 01 injection IM/ semaine pendant 03 semaines (07 jours d'intervalle) ✓ Ou Erythromycine 500 mg x 4/j x 30 jours (en cas d'allergie à la Pén G)	✓ Assurer la prise en charge selon les directives nationales

III. PROCEDURES DE REALISATION DES TESTS RAPIDES DU NOUVEL ALGORITHME DE DEPISTAGE DU VIH

Objectif général

A la fin de la session, le prestataire doit être capable de réaliser le dépistage de l'infection à VIH par les tests rapides.

Objectifs spécifiques

- ✓ Citer les tests rapides utilisés dans l'algorithme de dépistage du VIH
- ✓ Décrire les 03 phases du dépistage par les tests rapides
- ✓ Décrire la procédure de réalisation des tests rapides de dépistage du VIH
- ✓ Interpréter les résultats de dépistage

Plan

- ✓ Tests rapides utilisés dans les algorithmes de dépistage à 03 tests
- ✓ Phases de dépistage par les tests rapides
- ✓ Procédures de réalisation des tests rapides
- ✓ Interprétation des résultats des tests rapides

1. TESTS RAPIDES UTILISES DANS LES ALGORITHMES A 03 TESTS

1.1 Kit de Wondfo HIV Test

25 Tests

Wondfo



Cassette Wondfo HIV



Fenêtre de résultat

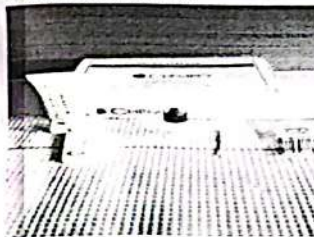
Puits de l'échantillon

Puits du tampon

Figure 13 : Kit de dépistage VIH Détermine

- 25 cassettes de Wondfo HIV test
- 1 déshydratant
- 1 flacon de tampon de migration
- 1 tube micro capillaire
- 1 lancette rétractable
- 1 tampon d'alcool

1.2 Kit de Stat Pak

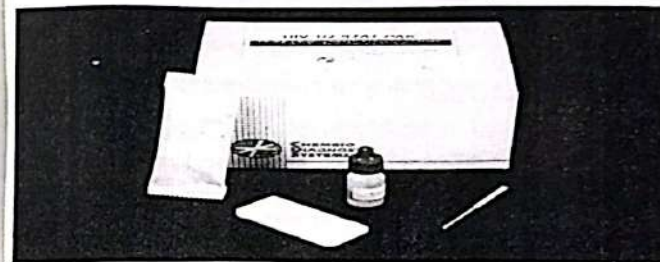
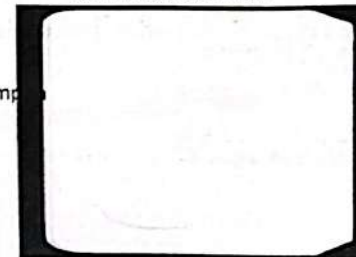


1- Cassette

2- Solution tampon

3- Tige de

Cassette: Stat Pak



Kit Stat- pak

Figure 14 : Kit Stat- pak

1.3 Kit de Uni-Gold HIV Test

Cassette de Uni-Gold



- 20 cassettes de test Unigold
- 1 flacon de diluant
- 20 boucles pipettes jetables
- 20 lancettes stériles
- 20 tampons d'alcool

1.4 Kit de Bioline HIV/Syphilis Duo



- 25 cassettes de test Bioline HIV/Syphilis Duo
- 1 flacon de diluant
- 20 tampons d'alcool

Cassette de Bioline HIV/Syphilis Duo

HIV / Syphilis



C S/F HIV

Les lettres « HIV », « SYP » et « C » sont imprimées sur le dispositif du test.

Elles correspondent aux positions des lignes de VIH, de syphilis et de contrôle dans la fenêtre de test.

Figure 15 : Kit de Bioline HIV/Syphilis Duo

2. PHASES DU DEPISTAGE PAR LES TESTS RAPIDES

2.1 Phase pré-analytique

- ✓ Nettoyer la paillasse ;
- ✓ Disposer le matériel sur le plan de travail ;
- ✓ Disposer les procédures opératoires des tests ;
- ✓ Vérifier la date de péremption des tests et la noter dans le registre ;
- ✓ Noter la date d'ouverture sur le kit ;
- ✓ Noter les numéros de lots dans le registre ;
- ✓ Mettre le code de dépistage du client dans le registre/fiche de dépistage ;
- ✓ Installer confortablement le client et le rassurer

2.2 Phase analytique

- ✓ Décrire la procédure de prélèvement au client et ce qu'il peut faire pour faciliter le prélèvement ;
- ✓ Sélectionner et préparer le site de prélèvement : Utiliser l'annulaire ou le majeur pour prélever le sang (Ne pas utiliser un doigt ayant une cicatrice, blessure, entaille, infection, œdème, difformité, boutons, callosité, ou portant une bague) ;
- ✓ Chauffer le site de ponction ;
- ✓ Nettoyer la peau avec un tampon alcoolisé (alcool ou isopropanol à 70°) de la pulpe vers l'extrémité ;
- ✓ Laisser l'alcool sécher à l'air (Ne pas souffler sur le lieu de ponction pour sécher l'alcool car les bactéries pourraient s'y incruster) ;

- ✓ S'assurer que le doigt se trouve en dessous du cœur du sujet pour augmenter le flux du sang vers le doigt ;
- ✓ En décrivant un mouvement circulaire avec le pouce, appuyer doucement sur le doigt à partir de la jointure supérieure vers le bout ;
- ✓ Maintenir une pression légère quand le pouce atteint le bout du doigt ;
- ✓ Utiliser une lancette stérile rétractable pour piquer fermement la pulpe du doigt au niveau de la base, légèrement sur le côté ;
- ✓ Piquer le doigt en évitant l'extrémité du doigt ou les côtés extérieurs à l'empreinte digitale parce qu'il y a un risque d'atteindre l'os sous-jacent ;
- ✓ Nettoyer la première goutte de sang avec une compresse stérile pour éviter la coagulation du sang
- ✓ Exercer une légère pression sur le doigt pour avoir une large goutte de sang
- ✓ Réaliser le test T1 selon les procédures en vigueur.

2.3 Phase post-analytique

- ✓ Noter le résultat dans le registre de dépistage par les tests rapides
- ✓ Gérer les déchets générés par la réalisation du test.

3. PROCEDURES DE REALISATION DES TESTS RAPIDES

3.1 Procédures de réalisation du Wondfo HIV Test

- ✓ Mode Opérateur :
 - Déposer 10µl du sang prélevé au bout du doigt dans le puits
 - d'échantillon (Ne pas déposer l'échantillon dans le puit du tampon de migration)
 - Déposer 02 gouttes du tampon dans le puit de tampon de migration (Ne pas déposer le tampon dans le puit d'échantillon) ;
 - Attendre 15 minutes pour faire la lecture du résultat
 - Stabilité du résultat: 15 mn (Ne pas faire la lecture au-delà de 30 minutes).
- ✓ Interprétation du résultat

VIH POSITIF

Présence de deux traits rouges (« T » et « C »)

Rendez vous à l'hôpital pour la confirmation du résultat si possible



VIH NEGATIF

Présence d'un trait rouge (« C »)

Refaire le test 3 mois après ou aller à l'hôpital ultérieurement pour un nouveau test



RESULTAT INVALIDE

Absence du trait de contrôle (« C »)

S'il y a absence des 2 traits (« T » et « C »), Refaire le test

S'il y a absence du trait « C » mais présence du « T », Reprendre le prélèvement ou Refaire le test



3.2 Procédures de réalisation du Stat Pak

- ✓ Mode opératoire :
 - Déposer une goutte de sang au centre du puits S
 - Attendre que le sang soit absorbé par la zone de dépôt
 - Ajouter trois (03) gouttes de solution tampon sur la zone de dépôt de l'échantillon
 - Lire le résultat au bout de 15 mn
 - Stabilité du résultat: 05 mn (Ne pas lire le résultat après 20 mn)
- ✓ Interprétation du résultat

a) Négatif

b) Positif

c) Invalide

d) Invalide

1. Le résultat est valide lorsque la ligne Contrôle est visible (figure a, b);
2. En absence de ligne Contrôle, le résultat doit être invalidé et le test doit être repris (figure c, d);
3. Toute ligne même très faiblement colorée apparaissant sur la zone test doit être considérée comme positive

3.3 Procédures de réalisation du test Uni-Gold HIV

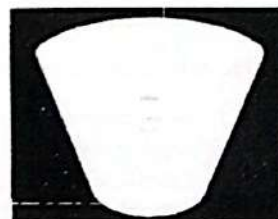
- ✓ Mode opératoire
 - Déposer deux (02) gouttes de sang dans le puits de dépôt à l'aide des pipettes (déposer verticalement, sans bulle d'air)
 - Ajouter immédiatement deux (02) gouttes de diluant (déposer verticalement, sans bulle d'air);
 - Faire la lecture des résultats au bout de 10 mn
 - Stabilité du résultat : 02 mn (Ne pas lire de résultat au-delà de 12 minutes après le dépôt du diluant)

Interprétations du résultat



REACTIVE

Positif



NON REACTIVE

Négatif



INVALID

Invalide

1. Le résultat est valide lorsque la ligne Contrôle est visible (figure a, b);
2. En absence de ligne Contrôle, le résultat doit être invalidé et le test doit être repris;
3. Toute ligne même très faiblement colorée apparaissant sur la zone test doit être considérée comme positive.

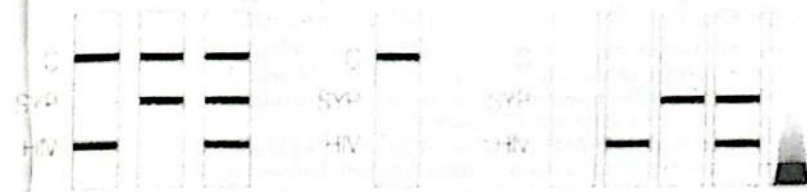
3.4 Procédures de réalisation du test HIV/Syphilis DUO de BIOLINE

- ✓ Mode opératoire
 - Déposer 20µl de sang total dans le puits de dépôt marqué « S » à l'aide d'une micropipette
 - Ajouter exactement trois (03) gouttes de diluant (déposer verticalement) dans le puit « S »;
 - Faire la lecture des résultats 15 minutes après l'ajout du diluant
 - Stabilité du résultat : 05 mn (Ne pas lire de résultat au-delà de 20 minutes après le dépôt du diluant).
- ✓ Interprétation du résultat

⊕ Positive

⊖ Negative

⊗ Invalid



3.5 Procédures de réalisation du Bioline Syphilis

- ✓ Mode opératoire
 - Déposer 20µl de sang total dans le puits d'échantillon ;
 - Ajouter quatre (04) gouttes de diluant (déposer verticalement) dans le puit ;
 - Faire la lecture des résultats 15 minutes après l'ajout du diluant ;
 - Stabilité du résultat : 05 mn (Ne pas lire de résultat au-delà de 20 minutes après le dépôt du diluant).

3.6 Procédures de réalisation du Toyo Ag HBS

- ✓ Mode opératoire
 - Déposer 02 gouttes de sang total dans le puits d'échantillon ;
 - Ajouter une (01) goutte de diluant (déposer verticalement) dans le puit et le laisser s'imprégner ;
 - Faire la lecture des résultats 15 minutes après l'ajout du diluant ;
 - Stabilité du résultat : 05 mn (Ne pas lire de résultat au-delà de 20 minutes après le dépôt du diluant).

4. INTERPRETATION DES RESULTATS DES TESTS RAPIDES

4.1 Grille pour le résultat final du dépistage de la population générale ou du testing

Si Wondfo HIV non réactif alors le client est déclaré VIH négatif ;

Si Wondfo HIV réactif, STAT PAK® réactif et Uni-Gold réactif alors le client est déclaré VIH positif ;

Tous les résultats positifs doivent être re-testés par un autre prestataire avant la mise sous TARV du client ;

Si Wondfo HIV réactif et STAT PAK® non réactif ou si Wondfo HIV réactif, STAT PAK® réactif et Uni-Gold non réactif alors noter résultat indéterminé dans le registre et retester le client après 14 jours.

4.2 Grille pour le résultat final du dépistage des femmes enceintes/allaitantes

Si Bioline HIV/Syphilis Duo non réactif pour le VIH alors le client est déclaré VIH négatif ;

Si Bioline HIV/Syphilis Duo réactif pour le VIH, STAT PAK® réactif et Uni-Gold réactif alors le client est déclaré VIH positif ;

Tous les résultats positifs doivent être re-testés par un autre prestataire avant la mise sous TARV du client ;

Si Bioline HIV/Syphilis Duo réactif pour le VIH et STAT PAK® non réactif ou si Bioline HIV/Syphilis Duo réactif pour le VIH, STAT PAK® réactif et Uni-Gold non réactif alors noter résultat indéterminé dans le registre et retester le client après 14 jours.

RECAP

1. Que vérifiez-vous dans un kit de dépistage avant l'emploi ?
2. Comment préparez-vous le client avant le prélèvement ?
3. Quel est le mode opératoire des tests rapides utilisés dans les nouveaux algorithmes de dépistage à 03 tests ?
4. Comment interprétez-vous un résultat positif dans le dépistage de la population générale et dans le dépistage des femmes enceintes/ allaitantes ?

IV. CAS PARTICULIER DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE CHEZ L'ENFANT : DBS

La majorité des enfants infectés par le VIH le sont du fait de la transmission mère-enfant au cours :

- ✓ De la grossesse,
- ✓ Du travail,
- ✓ De l'accouchement, ou de l'allaitement.

1. OUTILS DIAGNOSTIQUES

Le diagnostic biologique est indispensable pour confirmer une infection à VIH. Chez l'enfant, deux tests biologiques peuvent être utilisés :

- ✓ La PCR ADN, la sensibilité et la spécificité de ce test sont de 100%.
- ✓ Les tests rapides du VIH (test sérologique)

Le but du diagnostic biologique est de réaliser un diagnostic pédiatrique précoce des nourrissons infectés par le VIH et d'initier immédiatement le traitement antirétroviral chez les enfants séropositifs

2. STRATEGIE DE DIAGNOSTIC DE L'ENFANT

Le dépistage du VIH chez l'enfant sera réalisé selon les modalités suivantes :

- ✓ Dépistage systématique et obligatoire à 6 semaines de vie chez l'enfant exposé à la réalisation de la PCR en même temps que les vaccins du PEV selon l'âge de l'enfant

- ✓ Pour les enfants de plus de 6 semaines de vie chez qui l'exposition au VIH n'est pas connue : cas particulier
- ✓ Si l'âge est compris entre 6 semaines et 9 mois de vie, faire une PCR
- ✓ Si l'âge est compris en 9 mois et 18 mois, réaliser un dépistage avec les tests rapides. En cas de positivité du résultat, réaliser une PCR de confirmation
- ✓ Si l'âge est supérieur à 18 mois, faire un test rapide.

3. STATUT FINAL DE L'ENFANT

Un enfant exposé au VIH est considéré comme infecté par le VIH :

- ✓ Si la PCR est positive. Ce seul test suffit pour affirmer qu'un enfant est infecté par le VIH. Toutefois, les erreurs de manipulation ou d'étiquetage étant possible un 2^{ème} prélèvement devra être systématiquement réalisé. Le traitement devra être initié immédiatement et ce même avant les résultats de confirmation
- ✓ Si un test sérologique est positif après le 9^{ème} mois de vie et confirmé par une PCR positive pour les enfants qui n'ont jamais été dépistés

Un enfant exposé au VIH est considéré comme non infecté par le VIH :

- ✓ Si l'enfant n'est plus allaité depuis au moins six semaines et si la PCR est négative
- ✓ S'il n'est plus allaité depuis plus de 3 mois et ou la sérologie négative à 18 mois de vie.

NB : En cas d'allaitement

En cas d'allaitement, il existe un risque de contamination du VIH de l'enfant. Ce risque est constant pendant toute la durée de l'allaitement.

❖ Algorithme pour le diagnostic pédiatrique du VIH

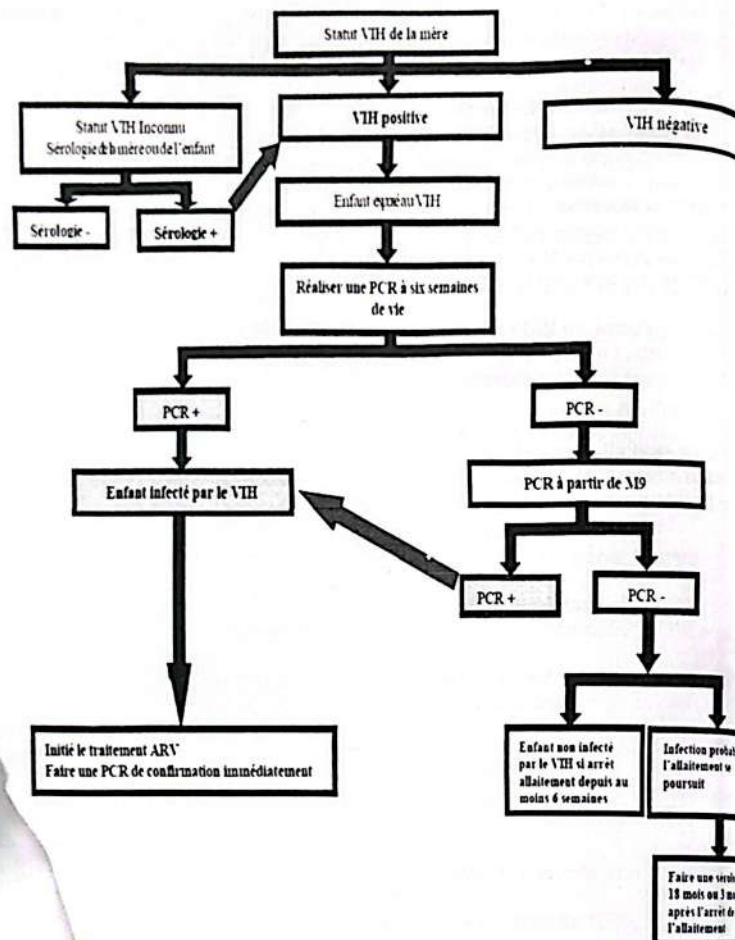


Figure 16 : Algorithme pour le diagnostic pédiatrique du VIH

4. PROCEDURES DE PRELEVEMENTS ET DE REALISATION DU DBS POUR LA PCR

4.1 Définitions et terminologie

Une procédure est l'ensemble des activités ou tâches réalisées dans un ordre chronologique et cohérent par des prestataires différents qui permettent d'aboutir au même résultat de qualité.

Un Prélèvement capillaire consiste à prélever du sang provenant du système veineux capillaire par pique transcutanée.

Le DBS : Le Dried Blood Spot ou DBS est un prélèvement de sang total recueilli sur du papier filtre absorbant et séché à la température ambiante. C'est un prélèvement moins traumatisant que le prélèvement veineux et qui nécessite une très faible quantité de sang pour sa réalisation. Il s'agit d'un type de prélèvement sanguin pour la conservation et la réalisation de certains examens de laboratoire (exemple : PCR).

POC : Point of Care est un appareil portatif qui permet de faire le diagnostic du VIH par PCR au lit du malade

4.2 Procédures de prélèvement capillaire et DBS

En pratique la procédure de collecte du sang capillaire est schématisée en 3 phases successives : pré analytique, analytique et post analytique.

4.2.1 Phase pré-analytique

➤ Préparation du matériel

Le prestataire dispose sur une surface (plan de travail) propre le matériel nécessaire au prélèvement :

- ✓ Lancette stérile ; Gants propres ; Compresse stérile ; Alcool 70°
- ✓ Cartes de papier filtre ; Stylo ; Fiche de prélèvement
- ✓ Etagère de séchage
- ✓ Collecteur d'aiguille
- ✓ Sac poubelle
- ✓ Essuie - tout



✓ Préparation du client :

- Installer confortablement l'accompagnant ou le client et le rassurer (Rappelez-vous que pour diminuer l'anxiété des sujets, il est important de prendre un air amical afin d'établir un climat de confiance)
- Décrivez-lui la procédure de prélèvement exacte et ce qu'il peut faire pour vous aider durant le prélèvement.
- Montrez lui que tout le matériel utilisé est stérile et à usage unique
- Remplir les fiches de prélèvement et le registre de dépistage
- Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon puis les sécher
- Porter des gants avant de commencer à effectuer le prélèvement
- Identifier et dater une carte de papier filtre en prenant soins de ne pas toucher les cercles

✓ Sélection et préparation du site de prélèvement :

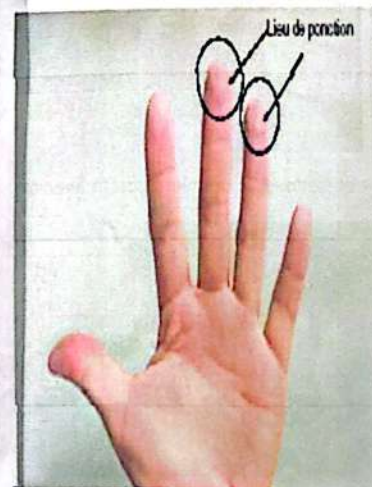
Pour les enfants de 6 semaines à 11 mois, le site de collecte est fonction du poids ou de l'âge de l'enfant



Le gros orteil pour les enfants âgés 4-10 mois ou pesant plus de 5kg

Le talon pour les enfants âgés de 1-4 mois ou pesant moins de 5kg

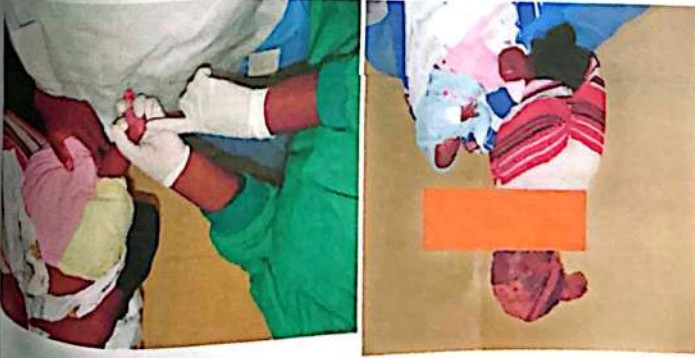
Pour les enfants de 12 mois ou plus et pour les adultes le bout du doigt est plus indiqué



- Le prélèvement sera plus facile si vous vous asseyez du côté opposé à la main du sujet
- Utilisez l'annulaire ou le majeur pour prélever le sang.
- N'utilisez pas un doigt ayant une cicatrice, blessure, entaille, infection, œdème, difformité, boutons, callosité, ou portant une bague

4.2.2 Phase analytique : Réalisation du DBS

Le talon pour les enfants âgés de 1-4 mois ou pesant moins de 5kg.



Demander à la mère de porter l'enfant et Réchauffer le site de ponction.



Presser la lancette contre la peau de l'enfant et Nettoyer la première goutte avec un coton sec.



Laisser une autre goutte se former et toucher la légèrement avec la carte ; Remplir les moins trois cercles.



Pour les enfants de 12 mois ou plus et pour les adultes, le bout du doigt

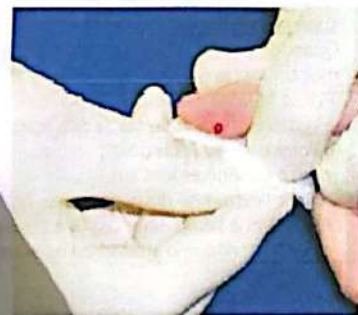
- Chauffer le site de ponction
- Nettoyer la peau avec un tampon alcoolisé. (alcool ou isopropanol à 70°)
- Si la peau est très sale prenez un nouveau tampon.
- Laissez l'alcool sécher à l'air.
- Ne soufflez pas sur le lieu de ponction pour sécher l'alcool car les bactéries pourraient s'y incruster.

Assurez vous que le doigt se trouve en dessous du cœur du sujet pour augmenter le flux du sang vers le doigt. En décrivant un mouvement circulaire avec le pouce, appuyez doucement sur le doigt à partir de la jointure supérieure vers le bout. Quand le pouce atteint le bout du doigt, maintenir une pression légère. Placez la lancette perpendiculairement à l'empreinte digitale sur la surface palmaire au bout du doigt, soit au centre ou légèrement sur le côté. Eviter l'extrémité du doigt ou les côtés extérieurs à l'empreinte digitale parce qu'il ya un risque d'atteindre l'os sous jacent

✓ Piqure



Utiliser une lancette stérile rétractable pour piquer fermement la pulpe du doigt au niveau de la base



Nettoyer la première goutte de sang avec une compresse stérile.



Exercer une légère pression sur le doigt pour avoir une large goutte

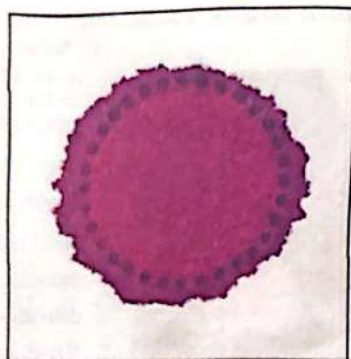
✓ Dépôt de la goutte de sang sur le papier filtre



1. Placer le doigt au dessus du cercle préimprimé du papier filtre sans toucher le papier filtre.
2. Déposer la goutte de sang en plein centre du cercle préimprimé.
3. Remplir complètement le cercle; Si le cercle n'est pas bien rempli, recueillir immédiatement une deuxième goutte .
4. Nettoyer le doigt avec une compresse stérile sèche une fois le nombre de cercles requis est rempli (au moins trois cercles)
5. Poser un pansement au point de piqûre

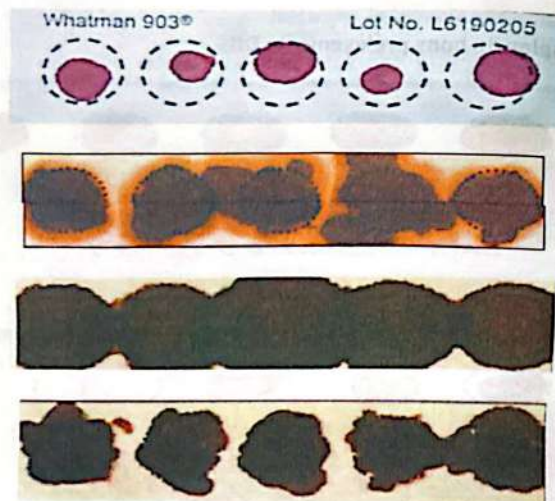
Deux exemples de bons prélèvements DBS

NAME <u>DB 3557 EO</u>				
DATE <u>28/08/2007</u>				
CE Lot No. B&S 6034 W-041 Expiry Date: 2007-08				
NAME <u>DB 3555 EO</u>				
DATE <u>28/08/2007</u>				
CE Lot No. B&S 6034 W-041 Expiry Date: 2007-08				



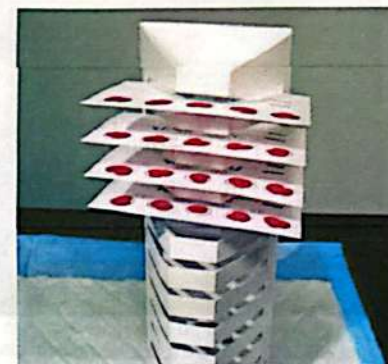
Dépôt correctement réalisé

Exemples de mauvais prélèvements DBS



Dépôts non conformes

4.2.3 Phase post analytique
✓ **Séchage des prélèvements DBS**



✓ **Elimination des déchets**



Après la piqûre, éliminer la lancette dans un conteneur rigide pour objet piquant et tranchant.



Eliminer les autres déchets souillés dans un sac poubelle approprié.

4.2.4 Conditionnement et transport des DBS au laboratoire Utiliser une enveloppe portant l'adresse du laboratoire et du site de prélèvement.



Le prestataire doit :

- ✓ Mettre tous les DBS dans une grande enveloppe préalablement identifiée avec le nom du site, le nom du laboratoire et la date du jour ;
- ✓ Mettre également toutes les fiches correspondantes dans la même enveloppe ;
- ✓ Remplir la fiche de transmission ;
- ✓ Transférer les prélèvements au laboratoire.

4.2.5 Rapportage des données dépistage précoce

Le numéro d'identification est l'élément déterminant pour identifier l'enfant au niveau de chaque site. Ce numéro unique pour chaque enfant, constitue la clé de liaison entre les différents supports d'informations sur l'enfant (la fiche d'identification et de prélèvement, la liste de transmission et de non-conformité, le registre de laboratoire, la fiche de résultat). Par ailleurs le numéro d'identification garantit l'identité de l'enfant dans le processus, l'anonymat, la confidentialité des résultats et une meilleure traçabilité des informations sur l'enfant.

L'établissement du numéro d'identification de l'enfant prend en compte en plus de l'identifiant existant sur le site, l'initial de l'activité : DBS, le code numérique du site et enfin le numéro d'ordre de l'enfant.

5. PROCEDURES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES SERVICES DE DEPISTAGE DU VIH

Le contrôle de la qualité des services de dépistage du VIH prend en compte :

- Autorisation de mise sur le marché (AMM) et la validation des lots de kits de dépistage ;
- Contrôle de qualité interne ;
- Contrôle de qualité externe ;
- Amélioration continue de la qualité.

5.1 Autorisation de mise sur le marché (AMM) et la validation des lots de kits de dépistage

La Direction de la Pharmacie, des Médicaments et des Laboratoires (DPML) :

- Délivre des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour tout kit de dépistage VIH commercialisé en Côte d'Ivoire ;
- Délivre des autorisations d'importation pour chaque kit de dépistage disposant d'une AMM à chaque importation sur le territoire.

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) à la charge de conduire les évaluations techniques préalables.

5.2 Contrôle de qualité interne du kit de dépistage

Il existe deux types de contrôle de qualité interne :

- La ligne ou spot de contrôle intégré aux tests qui permet de valider chaque épreuve ;
- Le contrôle réalisé de façon hebdomadaire, par des techniciens de laboratoire ou par des prestataires pour les postes de dépistage, sur des sérums témoins positifs ou négatifs fournis par le fabricant et/ou un laboratoire de référence.

Chaque semaine :

Le technicien de laboratoire teste les kits disponibles vis-à-vis des échantillons de statut VIH connu (VIH positif 1 et/ou 2, et/ou 1et2, VIH négatif), puis reporte les résultats obtenus dans le registre de dépistage.

En cas de résultats discordants, le technicien reprend les tests puis si la discordance persiste, il remonte les résultats au niveau du laboratoire de référence.

Dans le cas où le prestataire du poste est à mesure, il réalise lui-même ce contrôle. Dans le cas contraire, le prestataire du poste de dépistage enregistre le résultat de contrôle de qualité du laboratoire de référence dans son registre de dépistage.

5.3 Contrôle de qualité externe de la sérologie du VIH

C'est le contrôle de la qualité des résultats fournis par un laboratoire ou un poste de dépistage par un organisme extérieur de niveau supérieur (laboratoire de référence). Ce contrôle comprend : (i) le retesting des échantillons ; (ii) l'évaluation externe de la qualité et (iii) la supervision de la réalisation des tests.

5.4 Retesting des échantillons

De façon ponctuelle, un échantillonnage représentatif des résultats des postes de dépistage sera comparé aux résultats du laboratoire réalisés sur les mêmes sujets. Pour les postes de dépistage ayant des résultats discordants de VIH avec les laboratoires de suivi biologique, des échantillons négatifs représentatifs seront prélevés de façon aléatoire pour être retestés au laboratoire de référence.

5.5 Evaluation externe de la qualité (EEQ)

Les échantillons d'EEQ sont mis à disposition des laboratoires et postes de dépistage trois fois par an par le laboratoire de référence.

Pour les postes de dépistage, le panel est constitué d'au moins quatre échantillons. Le type d'échantillons est constitué d'au moins cinq échantillons. Pour les laboratoires, le panel est constitué de sérum, de plasma ou de sang séché en tube ou Dried Tube Specimen (DTS). A la réception des échantillons, chaque poste ou prestataire réalise les tests selon ses procédures habituelles. Les sites disposent d'un délai de trois semaines pour le retour des résultats sous forme électronique ou papier au laboratoire. Le laboratoire de référence dispose d'un délai d'un mois après la fin de la date de réception pour retourner les rapports préliminaires du laboratoire, du poste ou du prestataire. En cas de résultats non satisfaisants (inférieur à 100%), les sites disposent d'un délai d'un mois pour mettre en œuvre les mesures correctives avec l'appui du District sanitaire. Les sites ayant obtenu un score inférieur à 80% seront supervisés par le District sanitaire pour corriger les insuffisances. Un rapport annuel, résumant les résultats de toutes les distributions est envoyé au District, à la Région et au niveau central. Les avantages et intérêt de l'EEQ sont de :

- Suivre les performances des services de dépistage
- Identifier précoquement les problèmes
- Prouver objectivement la qualité des services
- Identifier les besoins en formation
- Faciliter les échanges d'information.

5.6 Supervision de la réalisation des tests
La procédure de supervision dans le cadre du contrôle qualité externe respecte le principe des supervisions de routine (Cf : module gestion des activités).

5.7 Amélioration continue de la qualité
L'amélioration continue de la qualité repose sur l'habilitation des prestataires et l'évaluation continue des compétences des prestataires et des sites de dépistage. Pour le prestataire, l'habilitation porte sur :

- La procédure de réalisation des tests de dépistage ;
- Le respect des règles d'hygiène et de biosécurité ;
- La réalisation des contrôles de qualité interne ;
- L'aptitude à conduire les activités de conseil ;
- L'évaluation continue des compétences portées sur les mêmes éléments en plus des résultats de l'EEQ.

Pour le site
Il s'agit d'une évaluation de l'organisation du site qui porte sur les éléments suivants :

- L'aménagement du poste de dépistage, (Propreté, éclairage, etc.) ;
- La condition de stockage des intrants ;
- L'hygiène et la biosécurité ;
- L'engagement du site dans le processus qualité (EEQ, politique qualité etc).

6. CONSEIL AU POSTE DE DEPISTAGE
6.1. Définition du conseil
L'OMS définit le conseil/counseling du VIH/sida comme « un dialogue confidentiel entre un client et un prestataire en vue de permettre au client de surmonter le stress et prendre des décisions personnelles par rapport au VIH/sida. »

Le counseling consiste notamment à évaluer le risque personnel de transmission du VIH et à faciliter l'adoption de comportements préventifs. La personne qui bénéficie du counseling est appelée client et le prestataire est appelé prestataire. Le client est donc assisté pour se maintenir dans les meilleures conditions psychologiques, physiques, et sociales.

6.2 Principes de base du dépistage du VIH
Les principes de base du dépistage en Côte d'Ivoire repose sur la loi N°2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le sida et sur les recommandations 2015 de l'OMS qui préconisent en matière de dépistage le principe des « 5 C », Conseil, Consentement, Confidentialité, résultat Correct et Connexions.

6.2.1. Conseil/counseling
C'est l'entretien avant, pendant et après le test de dépistage du VIH. L'article 6 de loi VIH indique que : « Les centres de santé, hôpitaux, cliniques ou laboratoires autorisés à effectuer les tests de dépistage du VIH sont tenus de fournir une assistance psychosociale pré-test, ainsi qu'une assistance psychosociale post-test aux personnes auxquelles ils offrent des services de dépistage du VIH ».

6.2.2. Consentement
L'accès aux services de dépistage procède d'une démarche volontaire d'un client désirant connaître son statut sérologique ou avoir des informations sur l'infection à VIH. Cependant, dans le cadre de l'offre de services de dépistage initiée par le prestataire, le dépistage est proposé systématiquement à tout client cible. Dans tous les cas, le dépistage reste volontaire et fait suite à un consentement qui peut être oral, tacite ou écrit.

6.2.3. Confidentialité
La confidentialité est un des principes de base de l'offre de services de dépistage. Elle doit transparaître dans toutes les étapes du dépistage. Tout prestataire doit l'observer. Le client confiera au prestataire des informations privilégiées que celui-ci devra garder confidentielles pour sauvegarder les droits et le bien-être du client. Cette confidentialité doit prévaloir entre le client et le prestataire. Elle doit être expliquée et acceptée par l'un et l'autre. Quel que soit le cadre dans lequel les services de dépistage sont offerts, la levée de la confidentialité est un droit qui appartient au client et ne se conçoit qu'avec son consentement « éclairé » sauf cas d'exception prévu par la loi. Pour les clients âgés de moins de 16 ans, le majeur incapable et pour toute personne dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'accord du représentant légal doit être obtenu. Si le partage de résultat s'impose pour préserver la sécurité ou le bien-être d'autrui, le prestataire doit se conformer aux articles 12 et 15 de la loi portant régime de prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH / sida. Toutefois le prestataire doit encourager le client à partager l'information avec une autre personne afin d'optimiser sa prise en charge et surtout avec son partenaire sexuel.

6.2.4. Résultat Correct
L'offre de services de dépistage du VIH doit utiliser des tests de qualité et suivre les procédures d'assurance qualité pour garantir un diagnostic correct.

6.2.5. Connexions/Liens
Les services de prévention, de traitement du VIH, de soins et de soutien doivent être assurés par des systèmes dotés des ressources nécessaires pour l'orientation, le soutien et le suivi des patients. L'offre de services de dépistage dans un cadre qui ne garantit pas le lien avec les services de soins et traitement n'a aucun intérêt pour les clients dépistés positifs au VIH.

7. DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES DE DÉPISTAGE
En Côte d'Ivoire, les approches de dépistage du VIH mises en œuvre sont les suivantes :

- Conseil Dépistage à l'initiative du Client : CDIC/CDV
- Le dépistage en communauté
- Conseil Dépistage à l'initiative du Prestataire : CDIP
- L'index-testing
- Auto-dépistage du VIH

A insérer du contenu de chaque approche (PNLS)

8.1 Conseil Pré-test
Le pré-test en situation de dépistage a pour objectif de préparer le client à effectuer le test. Le prestataire lors du conseil pré-test doit :

- Accueillir le client (se présenter, expliquer son rôle et rassurer le client du respect de la confidentialité) ;
- Informer le client sur les avantages de connaître son statut sérologique ;
- Informer sur les implications d'un résultat positif ou négatif ;
- Informer sur la disponibilité des soins et traitement en cas de résultat positif ;
- Expliquer comment va se faire le test rapide au bout du doigt ;
- Proposer des options de prévention et encourager le dépistage du ou des partenaires sexuels ;
- Obtenir le consentement du client ;
- Procéder au prélèvement.

En milieu clinique, en plus des étapes décrites ci-dessus, le prestataire doit :

- Expliquer l'importance du test pour la prise en charge du motif de consultation ;
- Procéder au prélèvement, sauf refus clairement exprimé ;
- Poursuivre la consultation pendant le temps de réaction du test ;
- Expliquer les possibilités de prise en charge quel que soit le résultat ;
- Assurer la prise en charge de la pathologie qui a conduit le patient en consultation
- Répondre aux éventuelles questions du patient.

Si le patient est hospitalisé, le prestataire l'invite dans son bureau pour l'entretien individuel ou fait l'entretien au lit en s'assurant du respect de la confidentialité.

- Fournit tous les soins liés à la pathologie qui a motivé la consultation ;
- Note le refus dans le registre de consultation de soins curatifs (CDIP proposé CDIP non réalisé) ;

- Encourage le patient à réfléchir à la question du dépistage du VIH ;

NB : En cas d'incapacité du client à donner son consentement (le mineur de moins de 16 ans, majeur incapable ou toute personne se trouvant dans l'impossibilité de manifester sa volonté), celui-ci devra être obtenu auprès du père, de la mère, du conjoint (e) ou du représentant légal. S'il n'y a personne à qui s'adresser, les prestataires devront agir en fonction de l'intérêt du patient concerné.

Le conseil pré test peut être précédé d'un conseil de groupe, dans ce cas le prestataire doit s'assurer que le client a bien compris les informations reçues et devra obtenir le consentement du client pour la réalisation du test.

8.2. Conseil post-test
Le conseil post-test a pour objectif d'annoncer le résultat au client en vue d'une meilleure prise en charge.

Le prestataire lors du conseil post-test :

- S'assure que le client est disposé à recevoir son résultat ;
- Aide le client à lire le résultat du test ;
- Confirme le résultat du test de dépistage du VIH au client de manière simple et claire ;
- S'assure que le client comprend la signification de son résultat ;
- Soutient le client, au besoin ;
- Discute des options de réduction du risque ;
- Encourage le client à partager son résultat ;
- Propose si possible des préservatifs ;
- Discute des autres préoccupations du client ;
- Rétère le client dépisté positif pour une prise en charge et le client négatif selon le besoin.

8.3 En cas de résultat négatif

- Le prestataire :
- Informe sur la période de la séroneconversion ;
 - Insiste sur l'importance de connaître le statut de son ou (ses) partenaire (s) sexuels ;
 - Informe sur la disponibilité des services de dépistage pour les partenaires et les couples ;
 - Rétère ou fait le lien avec d'autres services de prévention (Prévention et prise en charge des IST) ;
 - Discute de la possibilité de la sérodiscordance des résultats, des risques et bénéfices de la sérodifférence chez les couples et partenaires sexuels.

8.4 En cas de résultat positif

- Le prestataire :
- Discute avec le patient d'un style de vie positif (soins et soutien) ;
 - Informe le patient sur la disponibilité des services (soins et traitement ARV, groupe de soutien) ;
 - Informe le patient sur les procédures de prise en charge (bilan initial, traitement ARV, bilan de suivi, traitement des infections opportunistes) ;
 - Informe le patient sur les bénéfices du maintien dans les soins ;
 - Donne des informations au patient concernant la réduction de la transmission du VIH ;
 - Demande au patient d'encourager son conjoint et ses partenaires sexuels à faire le test ;

- 8.5.3. Cas de l'enfant exposé au VIH**
- Tout enfant exposé venant dans une structure de santé doit se voir proposer le test de dépistage du VIH.
- Le prestataire :
- Explique les raisons motivant cette proposition au parent (père, mère) ou représentant légal ;
 - Donne les avantages du dépistage (du point de vue clinique pour la pathologie en cours et du point de vue préventif dans la réduction des épisodes de morbidité et de mortalité) ;
 - Obtient le consentement d'un des parents ou du représentant légal ;
 - Annonce le résultat au parent ou au représentant légal ;
- Si le test est positif chez l'enfant :
- Informe les parents que le traitement du VIH est disponible et gratuit ;
 - Propose le dépistage aux parents (père, mère) ;
 - Encourage le dépistage de la fratrie ;
 - Rétère l'enfant pour sa prise en charge.
- En cas de refus du dépistage de l'enfant par les parents :
- Fournit tous les soins liés à la pathologie qui a motivé la consultation ;
 - Encourage le parent ou le représentant légal à réfléchir à la question du dépistage du VIH ;
 - Note le refus dans le registre de consultations curatives ;
 - Réfait la proposition du test au prochain rendez-vous.
- 8.5.4. Cas des enfants et adolescent**
- En dehors du consentement obtenu auprès de l'un des parents ou représentant légal, les étapes de la procédure des services de dépistage restent identiques chez l'enfant et l'adolescent de moins de 16 ans.
- Le prestataire : Eduque sur les comportements à moindre risque (tel que l'abstinence, l'utilisation correcte et systématique du préservatif en cas d'activité sexuelle...), la prévention de l'infection à VIH et les grossesses non désirées ;
- Informe sur la nécessité de se faire tester en cas de prise de risque (rapports sexuels non protégés, rupture de préservatifs, Etc.) ;
 - Fait la référence active vers les services adaptés si besoin.
- Recommande l'implication des parents ou du tuteur légal dans la prise en charge
- 8.5.5. Cas de la famille**
- Le prestataire :
- Commence les services en présentant à l'ensemble des membres de la famille les objectifs et les avantages du dépistage en famille ;
 - Fait une éducation sur le VIH/sida en tenant compte de la spécificité de la famille ;
 - Réalise une séance de conseil unique pour le couple ;
 - Réalise des séances de conseil individuel après le consentement des parents ou du représentant légal pour les enfants et les adolescents ;
 - Réalise des sessions de conseil individuel pour les adultes ;
 - Suit les procédures d'offre de services de dépistage spécifiques à chaque groupe ;
 - Encourage le partage des résultats au sein de la famille.

- 8.5.2. Cas de la femme enceinte/allaitante**
- Le prestataire :
- Informe sur les risques de transmission du VIH à l'enfant ;
 - Informe sur les mesures qui peuvent être prises pour réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant ;
 - Informe sur les avantages du dépistage précoce pour la mère et pour l'enfant ;
 - Encourage le dépistage du conjoint ;
 - Informe sur les modes d'alimentation pour réduire la transmission du VIH au cours de l'allaitement ;
 - Informe sur la nécessité de se faire tester dans la période périnatale ; (dernier trimestre de la grossesse, au cours du travail, post partum immédiat) en cas de négativité du test de dépistage précédant.
- 8.5.1. Cas du couple**
- 8.5. Conseil dans les cas particuliers**
- Le prestataire :
- Accueille le couple ;
 - Obtient l'accord du couple pour le recevoir en tant qu'entité unique durant toute le processus ;
 - Identifie le type de couple (polygame, monogame ou polyandre), en cas de polygamie ou polyandre, chaque couple est reçu séparément ;
 - Evite d'évoquer le comportement sexuel de chaque conjoint en dehors du couple ;
 - Donne les informations sur les risques de contamination du VIH au sein du couple ;
 - Donne les informations sur les moyens de prévention du VIH au sein du couple ;
 - Donne les informations sur la procédure de réalisation du test et discute des implications des résultats possibles ;
 - Insiste sur l'importance du partage du statut avec son conjoint ;
 - Informe clairement les partenaires et les couples que la réalisation du test peut se faire individuellement ;
 - Réalise simultanément le dépistage du couple en cas d'accord des deux partenaires ;
 - Donne simultanément le résultat du couple ;
 - Discute des options de réduction du risque au sein du couple ;
 - Développe un plan de réduction de risques ;
 - Apporte un soutien psychologique au couple et démarre le processus de prise en charge médicale, si couple concordant positif ou discordant ;
 - Aborde les questions de planning familial.
- Si le couple refuse d'être reçu comme une entité unique, le prestataire reçoit les partenaires séparément selon la procédure de l'entretien individuel et encourage le partage de résultat.
- NB :** Enregistrement des résultats à la fin de chaque entretien par le prestataire : [Annexe 3]
- Renseigne les outils de gestion de l'activité (dossiers, registres et fiches, Etc.) ;
 - Range ces outils de gestion sous clé.
- Encourager le client à favoriser le dépistage famille
 - Traite des autres préoccupations du patient ;
 - Réfère le client pour une prise en charge adaptée à ses besoins ;
 - Informe le client de l'existence d'une loi VIH lui faisant obligation d'informer ses partenaires sexuels de son statut positif VIH dans les trois mois suivant l'annonce ;

8.5.6. Cas des patients suspects de tuberculose

En cas de suspicion de la tuberculose (présence de toux depuis plus de 15 jours, fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids, notion de contact tuberculeux)

Le prestataire :

- Réalise le conseil et le dépistage du VIH selon la procédure décrite plus haut ;
- Réfère à un centre de prise en charge de la tuberculose ;
- Réfère le patient positif au test du VIH dans un site de PEC du VIH si le dépistage a eu lieu dans un CAT/CDT et que les examens bactériologiques ou moléculaires de crachats sont négatifs.

8.5.7. Cas des populations clés

Le prestataire (agent de santé, ou agent communautaire, éducateur de pair, Etc.) propose systématiquement le dépistage du VIH aux populations prioritaires aussi bien en stratégie fixe, qu'en stratégie mobile sur les lieux et aux heures adaptées aux cibles. Le test de dépistage du VIH est précédé d'un entretien de groupe et/ou individuel.

Pour faciliter l'identification des populations clés, le prestataire doit :

- Diriger l'entretien dans le sens de l'orientation et l'activité sexuelle du client
- Renseigner le type de population clé dans le registre de consultation

Pour les populations clés suivantes : travailleurs du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et utilisateurs de drogues injectables dépistées négatives, le prestataire :

- Encourage à refaire le test (contrôle) tous les trois mois ;
- Insiste à adopter un comportement à moindre risque (utilisation systématique et correct du préservatif et du gel lubrifiant à base d'eau, Etc.).

CONCLUSION

La réalisation du prélèvement capillaire, des DBS et des tests rapides VIH constitue une étape importante et incontournable dans la prévention de l'infection à VIH. Les tests rapides ont certes simplifié la réalisation du diagnostic biologique du VIH, cependant il importe aux prestataires de respecter rigoureusement les procédures de réalisation en vue de rendre des résultats fiables.

La fiabilité du résultat du dépistage de l'infection à VIH repose sur le management de la qualité.

CHAPITRE 5 : STRATEGIES DE PREVENTION DE L'INFECTION A VIH/SIDA

INTRODUCTION

L'épidémie actuelle du VIH/Sida en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne est en grande partie le fait de comportements individuels à risque. Bien que la prévention ne suffise pas pour juguler entièrement et efficacement tous les aspects de l'épidémie, elle constitue la pierre angulaire de la lutte contre l'infection à VIH et le Sida.

En l'absence de vaccin, la prévention de l'infection à VIH dans notre contexte repose essentiellement sur la promotion de comportements à moindre risque et l'application de mesures visant à empêcher la transmission du virus d'une mère infectée à son enfant. Ce chapitre présente les stratégies de prévention de l'infection.

Objectif General

A la fin de ce chapitre, l'étudiant devra être capable d'assurer les stratégies de prévention de l'infection à VIH.

Objectifs spécifiques : L'étudiant sera en mesure de :

1. Expliquer les mesures de prévention de la transmission sexuelle
2. Citer les mesures de prévention par voie sanguine
3. Décrire les mesures de prévention de la transmission mère enfant

Plan du cours

1. Prévention de la transmission sexuelle
2. Prévention de la transmission par voie sanguine du VIH
3. Prévention de la transmission Mère-Enfant

1. PREVENTION DE LA TRANSMISSION SEXUELLE

Les moyens de prévention de la transmission sexuelle sont les suivants :

1.1. Abstinence sexuelle

L'abstinence sexuelle est la non-participation à une activité sexuelle. Elle est conseillée comme méthode de prévention pour éviter tout risque d'exposition au VIH par la voie sexuelle.

1.2. Fidélité mutuelle mono partenaire

Il s'agit de la limitation des relations sexuelles à un (e) et seul (e) partenaire.

1.3. Rapport protégé

Les préservatifs masculins ou féminins réduisent le risque de transmission du VIH. L'utilisation correcte d'un préservatif lubrifié réduit le risque de sa rupture. Le préservatif féminin (fémidom) est aussi efficace que le préservatif masculin.

Le port de préservatif est recommandé dans un couple pratiquant la fidélité mais sérodifférents.

1.4. Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP au VIH)

Une approche novatrice de prévention recommandée par l'OMS depuis 2015 qui consiste à prendre un médicament contre l'infection à VIH chez les personnes séronégatives à haut risque de contracter le VIH par voie sexuelle

1.5. Autres pratiques à moindre risque

Ce sont les relations sexuelles sans risque ou à moindre risque :

- Rapports buco-génitaux protégés ;

- Masturbation ;
- caresses ;
- Baisers sur la bouche.

2. PREVENTION DE LA TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE DU VIH

Toute transfusion sanguine doit se faire avec du sang testé. Toutes les injections (intramusculaires, ou intraveineuses) et certaines pratiques rituelles (scarifications, tatouages, circoncisions, toilettes mortuaires, Etc.) doivent être faites avec du matériel à usage unique ou stérilisé.

En milieu de soins, des mesures d'hygiène doivent être prises pour prévenir les accidents d'exposition au sang (AES) et aux produits biologiques : port de gants, blouse, masque, pansement sur des plaies même mineures etc.

3. PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE-ENFANT

Elle passe par une sensibilisation large des populations sur les 4 piliers de la PTME :

- La prévention primaire dans le cadre de la PTME ;
- La prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées ;
- La Prévention de la transmission de l'infection à VIH des mères infectées à leurs enfants ;
- Les Soins et traitements aux mères infectées, leurs enfants et leur famille.

3.1. Prévention primaire dans le cadre de la PTME

Elle concerne la population en âge de procréer (hommes et femmes). Cette prévention consiste à :

- L'abstinence : le sujet s'abstient de tout rapport sexuel.
- Le retard aux premiers rapports sexuels. Les rapports sexuels précoces exposent la fille à l'infection à VIH du fait de l'immaturité des organes sexuels.
- La sécurité transfusionnelle.
- L'utilisation du matériel de soins à usage unique
- Promouvoir des pratiques sexuelles à moindre risque et responsables
- Faciliter l'accès aux préservatifs
- Diagnostiquer et traiter précocement les infections sexuellement transmissibles
- Offrir le conseil et le dépistage VIH aux partenaires sexuels des femmes dépistées séronégatives.

Les séances éducatives dans les services de CPN doivent inclure des informations sur la maternité à moindre risque, le VIH/Sida, la PTME, les infections sexuellement transmissibles (IST), la vaccination, la PF, le suivi de la croissance du futur nouveau-né

3.2. Prévention des grossesses non désirées chez les femmes infectées

- Offrir le conseil et les services de planning familial ;
- Offrir après l'accouchement la double contraception ;
- Offrir le dépistage et le conseil VIH aux partenaires sexuels des femmes dépistées séropositives au VIH dans le cadre de la PTME.

3.3. Prévention de la transmission de l'infection à VIH des mères infectées à leurs enfants

La prévention de la transmission du VIH de la mère infectée à son enfant peut se faire par les :

- Médicaments ARV (Cf module traitement ARV);

- Pratiques sûres d'accouchement
- Pratiques sûres d'alimentation

Les interventions spécifiques pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère infectée à son enfant se situent à trois niveaux : (i) pendant la grossesse, (ii) pendant l'accouchement, (iii) pendant l'allaitement.

3.3.1. Pendant la grossesse

Le suivi des femmes enceintes infectées par le VIH repose sur les consultations prénatales.

Les consultations prénatales intègrent la prévention du paludisme, des infections opportunistes en l'occurrence la tuberculose et la prévention de la transmission mère enfant. On parle de CPN recentrée (CPNr). Elle donne l'occasion d'informer, d'éduquer et de faire le suivi de la gestante.

Il est recommandé à toute femme enceinte d'effectuer au moins 4 CPN.

La grossesse chez une femme infectée par le VIH étant une grossesse à risque, la femme devra être vue chaque mois en consultation prénatale.

Au 2^{ème} trimestre de la grossesse, la mettre sous Cotrimoxazole en remplacement d'un éventuel traitement préventif anti palustre.

3.3.2. En salle de travail et d'accouchement

Le prestataire de soins passe en revue les antécédents cliniques de la parturiente et vérifie son statut sérologique VIH dans le carnet de santé mère-enfant :

- Si statut VIH connu Positif :
 - S'enquérir du traitement en cours :
 - Si TARV,
 - o Vérifier le protocole ARV et autres médicaments prescrits et la prise de la dose journalière d'ARV, lui remettre son traitement en cas d'oubli.
 - Si pas de TARV,
 - o Démarrer son traitement immédiatement en donnant la dose journalière
- Si statut VIH inconnu :
 - Proposer le dépistage et la prise en charge adéquate.

Les mesures à prendre dépendent du mode d'accouchement par voie basse

- Minimiser la pratique de l'examen cervical
- Eviter la rupture artificielle des membranes avant 8 cm de dilatation
- Eviter le travail prolongé (partogramme)
- Eviter les manœuvres obstétricales (versions)
- Eviter les manœuvres instrumentales (forceps, ventouse)
- Eviter les épisiotomies autant que possible
- Eviter de traire le cordon
- Nettoyer le cordon avec la solution de chlorexidine avant de le sectionner
- Faire la section rapide du cordon sous compresse
- Devant une indication de révision utérine, utiliser les gants de révision utérine.

3.3.3. Pendant les suites de couches et la période de l'allaitement

Tableau XVIII : Suivi de la mère infectée et de son enfant

Soins du Post-Partum aux femmes et à leurs nouveau-nés	
Dès la Naissance	
La mère	Le bébé
✓ Proposer le test de dépistage VIH si statut inconnu ou si VIH négatif depuis plus de 3 mois. - Si Test VIH Négatif, donner des conseils à la mère et l'encourager à rester séronégative - Si test VIH Positif, Initier le traitement ARV de la mère en lui donnant sa première dose, remettre une dotation d'1 mois de traitement ARV et prélever pour le bilan initial ✓ Donner un rendez-vous pour la prochaine visite à J7 ✓ Mettre la femme en contact avec l'intervenant communautaire de son lieu de résidence.	✓ Administrer la première dose de prophylaxie ARV au nouveau-né en fonction du risque de transmission au VIH
A 7 jours (J7)	
La mère	Le bébé
• Renforcer l'intérêt de l'allaitement ainsi que la bonne alimentation de la mère • Rechercher les effets indésirables précoces des ARV • Vérifier et renforcer l'observance au traitement • Discuter des questions sexuelles liées à la période du post-partum, y compris la PF • Donner un rendez-vous pour la prochaine visite à 6 semaines	• Observer la mise au sein du bébé • Evaluer la prise de la prophylaxie par le bébé ; • Rechercher des signes d'infection précoce au VIH (candidose, infection respiratoire, parotidite, adénopathie, hépatomégalie, splénomégalie, otite suppurée...)

A 6 Semaines	
La mère	Le bébé
• Discuter des questions sexuelles liées à la période du post-partum, y compris la PF • Rechercher systématiquement des effets indésirables des ARV • Faire l'évaluation et le soutien à l'observance • Renouveler les ARV et le Cotrimoxazole pour 1 mois • Offrir le paquet de soins et soutien : Recherche active de la tuberculose, évaluation et conseils nutritionnels pour la mère, dépistage du cancer du col de l'utérus, santé positive, dignité, prévention	• Vaccination selon le PEV • Prélèvement DBS pour la première PCR • Noter la date de réalisation de la PCR ainsi que le numéro de prélèvement (dans les outils de collecte de données) • Initier la prophylaxie au Cotrimoxazole • Noter le rendez-vous de la prochaine visite (à 10 semaines) dans le carnet de l'enfant
A 10 Semaines	
La mère	Le bébé
• En l'absence de signe d'appel, la mère n'a pas de soin. Particulier au centre de santé. Renouveler ses ARV Toutefois elle doit accompagner son bébé pour ses rendez-vous de suivi	• Doses vaccinales selon le PEV • Résultat de la PCR 1 : • SI PCR1 positive : Prélever DBS pour PCR2, ouvrir un dossier individuel client pour l'enfant, préparer la mère à l'observance ARV de l'enfant, initier systématiquement le traitement ARV, initier le Cotrimoxazole, Faire un prélèvement pour le bilan de suivi (CD4, Hb ...), mettre la mère en contact avec les intervenants communautaires (si ce n'est déjà fait). • SI PCR1 négative : Vérifier si l'enfant a été allaité les 6 dernières semaines. ✓ Si non, l'enfant est <u>déclaré négatif</u>. Référer l'enfant dans le service de prise en charge des enfants sains (L'enfant sort alors du programme PTME) ✓ Si oui, continuer le Cotrimoxazole et faire un 2^e prélèvement DBS pour PCR 2, 6 semaines après l'arrêt de l'allaitement. • Si cette PCR 2 est négative, l'enfant est déclaré négatif. Référer l'enfant

	dans le service de prise en charge des enfants sains (L'enfant sort alors du programme PTME) • Si cette PCR 2 est positive, l'enfant est déclaré infecté par le VIH, on initie alors son traitement ARV.
A 14 Semaines	
La mère	Le bébé
En l'absence de plainte ou de signe d'appel, • Assurer le suivi de la mère selon l'offre différenciée des services de prise en charge selon le type de patient	• Recherche d'effets indésirables aux médicaments • S'assurer de l'observance du traitement auprès de la mère • Renouveler son traitement ARV • Doses vaccinales selon le PEV

La mère allaitante et son nouveau-né étant des patients instables auront un suivi conformément à l'offre différenciée des services de prise en charge selon le type de patient et selon la classe d'âge (Voir le suivi du patient en L2)

3.3.4. Soins et soutien aux mères infectées, leurs enfants et leur famille

L'objectif premier de la prise en charge de la personne infectée par le VIH est d'améliorer la qualité de vie pour restaurer sa dignité. Cet objectif une fois atteint, aura un impact bénéfique sur l'enfant, le partenaire, la famille et la communauté.

Cette prise en charge repose sur un suivi régulier pour offrir des soins adaptés aux besoins du client. Le suivi comprend le traitement ARV, les soins préventifs et curatifs des co-infections, des symptômes pénibles, les soins et soutien.

CONCLUSION

Les stratégies de base de la prévention reposent sur la :

- Prévention de la transmission sexuelle
- Prévention de la transmission par voie sanguine du VIH
- Prévention de la transmission Mère-Enfant.

MODULE 1 : OEI. GENERALITES SUR LE VIH ET LE SIDA

OBJECTIF GENERAL

Renforcer les connaissances des prestataires de santé sur la pandémie du VIH et du sida et son impact dans la société.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

A la fin de ce module, l'étudiant doit être capable de :

- Définir le VIH et le sida ;
- Indiquer le taux de séroprévalence du VIH en Côte-d'Ivoire ;
- Décrire chaque mode de transmission ;
- Citer les facteurs de risques et les impacts du VIH et du sida

DEFINITION

- **VIH** : Virus de l'Immunodéficience Humaine ; il en existe deux types : **VIH1** et **VIH2**
- **SIDA** : Syndrome de l'Immunodéficience acquise

Les principaux organes et liquides biologiques pouvant abriter le virus sont :

- Les ganglions
- Les liquides biologiques humains, plus particulièrement :
 - Le sang
 - Le sperme
 - Les sécrétions vaginales
 - Le liquide amniotique
 - Le lait maternel

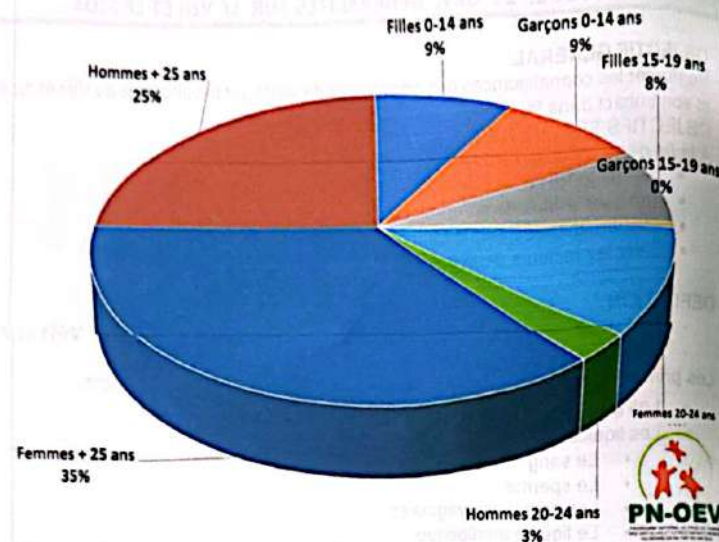
I. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1. Au niveau mondial et régional (Afrique subsaharienne) selon ONUSIDA 2022

- 38,4 millions personnes vivent avec le VIH en 2021
- 1,5 millions de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH la même année 2021
- Les filles et les jeunes adultes femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les jeunes adultes hommes
- Les femmes et les filles représentaient 63% de toutes les nouvelles infections au VIH en 2021

2. Au niveau national (Selon les estimations du SPECTRUM 2023)

- La prévalence du VIH est estimée à 1,82% dans la tranche de 15 à 49 ans en fin 2022
- 407 595 personnes vivent avec le VIH à fin 2022, dont 20 981 enfants
- 386 614 adultes, 270 405 femmes (66%) et 137 190 hommes (34%).
- Chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, 18% des nouvelles infections proviennent de la tranche d'âge de 0-4 ans.



II. MODES DE TRANSMISSION

- Transmission sexuelle : rapports hétérosexuels ou homosexuels non protégés par pénétration vaginale, anale ou buccale
- Transmission sanguine : transfusion de sang ou dérivés sanguins infectés par le VIH ; accidents d'exposition au sang ; matériels souillés par du sang infecté
- Transmission de la mère à l'enfant : au cours de la grossesse (5 à 10%), lors de l'accouchement (10 à 20%) au cours de l'allaitement (5 à 20%)

• GESTES DE LA VIE COURANTE QUI NE TRANSMETTENT PAS LE VIH

- Serrer la main, toucher ou serrer dans les bras une personne vivant avec le VIH ;
- Baiser léger ;
- Partager les mêmes toilettes, latrines ou douches ;
- Utiliser les mêmes couverts ou ustensiles de cuisine ;
- Utiliser les mêmes téléphones ;
- Dormir, jouer ensemble ;
- Nager dans une piscine ;
- Proximité dans le bus, au travail, à l'école, au marché...
- Toux, éternuement, salive, larme, sueur, urines ;
- Piqûre de moustique ou autre insecte ;
- Morsures d'animaux...
- Acheter les produits vendus par une personne infectée ;
- Se faire masser, recevoir/donner des caresses superficielles

III. FACTEURS DE RISQUES ET IMPACT DU VIH ET DU sida (1/6)

1. Facteurs de risques liés à la sexualité, aux modes de vie comportementaux et aux activités socio-économiques et culturels :

• Facteurs liés à la Sexualité

- Précocité des rapports sexuels ;
- Prostitution occasionnelle ou régulière ;
- Multiplicité des partenaires sexuels
- Rapports sexuels non protégés
- Pratiques sexuelles à risque (cunnilingus, anulingus, sodomie, fisting (poing dans le vagin ou l'anus), dry sex (rapport sexuel sans lubrification vaginal) etc,

• Socio-économique et culturel

- Promiscuité
- Pauvreté/richeesse
- Coutumes (lévirat, sororat, mariage précoce, scarification, excision)
- Méconnaissance/violation des droits humains en l'occurrence le droit des enfants et celui des femmes (viol)

• Modes de vie comportementaux

- Mouvements des populations et conflits sociaux (voyages, guerres, déplacements, migrations...);
- Déscolarisation qui conduit à l'oisiveté ;
- Consommation de la drogue et de l'alcool
- Analphabétisme
- Mauvaise utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) : pornographie, présence de prédateurs sexuels

• Facteurs biologiques et actes médicaux

✓ Biologiques

- Immaturité des organes génitaux de la jeune fille ;
- Non circoncision chez les hommes ;
- Fragilité et étendue de la surface de contact chez la femme lors des rapports sexuels.
- Fragilité de la muqueuse anale
- Existence des autres IST.

✓ Actes médicaux

- Transfusion de sang non testé ;
- Tout acte chirurgical avec du matériel souillé ;
- Injections avec des aiguilles souillées.
- Accidents d'exposition au sang (AES)

• Sur l'enfant, l'adolescent.e et le ménage:

- Orphelins et problèmes psychoaffectifs,
- Discriminations,
- Difficultés d'accès aux services médicaux de base et à l'éducation

- Stress physique et psychosocial
- Responsabilités au dessus de leur âge,
- Crises humanitaires, risque de famine

• **Sur la famille élargie et la société:**

- Déclin des ressources financières,
- Malnutrition,
- Perte des systèmes de valeur,
- Arrêt de l'éducation,
- Délinquance et crime
- Prostitution

2. Facteurs aggravant l'impact de la maladie

• **Situation économique :** habitudes du ménage et de la communauté en terme de redistribution des revenus (repas familial, soins, éducation, loisirs, transport, assistance à autrui, etc.) Pour un ménage déjà pauvre, la survenue du sida peut entraîner une pauvreté extrême.

• **Contexte social et culturel et religieux :** pratiques sociales, culturelles et religieuses influencent les réponses aux besoins des familles. Exemple : Au lieu de prendre ses ARV et se nourrir correctement (repas équilibrés), on demande au malade de jeûner et de prier.

• **Contexte socio politique :** destruction des infrastructures sanitaires, déplacement massif de personnel sanitaire qualifié, non fonctionnalité des centres CDV, rupture des chaînes d'approvisionnement en médicaments.

• **Perception de la maladie :** opinions, attitudes, interprétations et préjugés sur le VIH et le sida peuvent conduire à la stigmatisation et au rejet des personnes affectées et ou des personnes vivant avec le VIH.

• **Accès aux services sociaux de base :** La difficulté d'accès aux services sociaux de base rend davantage vulnérables les individus et les familles affectés par le VIH à mieux gérer leur situation.

• **Environnement juridique et politique :** engagement des politiques, adoption d'un cadre légal.

• **Fausse croyance de la communauté sur le VIH :** moustique transmet le VIH, punition de Dieu, VIH héréditaire, VIH sort lancer par les sorciers, on peut guérir du VIH.

MODULE 2 : GENERALITES SUR LES OEV ET LEURS FAMILLES EN LIEN AVEC LE VIH

OBJECTIF GENERAL

Au terme de ce module, les prestataires de santé doivent connaître les généralités sur les OEV en lien avec le VIH.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

A la fin du module, les étudiants doivent être capable de :

- Définir les concepts et termes clés
- Identifier les portes d'entrée des OEV
- Décrire les sept (7) problèmes rencontrés par les OEV et leurs familles en lien avec le VIH et le sida
- Définir l'approche centrée sur la famille ;
- Citer les principes d'une approche centrée sur la famille
- Décrire les sept (7) problèmes rencontrés par les OEV et leurs familles en lien avec le VIH et le SIDA,

I. DÉFINITION DES CONCEPTS ET DES TERMES CLÉS

- **Enfant :** un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable
- **Adolescent, e :** Située entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescence est la période de croissance et de développement humain comprise entre 10 et 19 ans
- **Jeune adulte :** Les personnes âgées de 20-24 ans sont considérés comme « jeune adulte »
- **Enfant Orphelin :** enfant qui a perdu au moins un parent
- **Enfant infecté,** enfant qui a été dépisté positif au VIH
- **Enfant affecté :** enfant qui subit l'impact socioéconomique et psychosocial
- **Enfant ou adolescent vulnérable :** enfant ou l'adolescent.e susceptible d'être atteint par un mal ou un péril qui le ou la menace
- **"OEV" :** Le terme "OEV" désigne généralement des orphelins et autres groupes d'enfants qui sont plus exposés aux risques que leurs pairs.

II. CONCEPT OEV EN LIEN AVEC LE VIH ET LE sida EN CÔTE D'IVOIRE

En Côte d'Ivoire, l'OEV du fait du VIH est tout enfant ou adolescent(e) de 0 à 24 ans accomplis qui a un lien direct avec le VIH et qui présente l'une des vulnérabilités suivantes :

- Infecté par le VIH
- Orphelin de père, de mère ou des deux parents (orphelin double) du fait du VIH
- Dont l'un ou les deux parents est/sont infecté(s) par le VIH;
- Dont la famille accueille un enfant infecté, affecté ou un orphelin du fait du VIH ;
- Dont la famille est affectée économiquement par la pandémie du VIH (soutien de personnes malades ou d'orphelins du fait du VIH, etc.).
- **Enfants ou adolescent(e)s ou jeune adultes vulnérables au VIH**
- Selon la Politique Nationale en soins et soutien aux OEV et leurs familles, est considéré comme vulnérable au VIH tout enfant ou adolescent(e) ou jeune adulte de 0 à 24 ans accomplis ayant un lien indirect avec le VIH, et qui :

- Est dans une situation l'exposant au VIH : victime de viol, d'abus, d'exploitation sexuelle et de MGF, en situation de handicap, travailleur du sexe, consommateur de drogues ;
- Vit dans un milieu à risque au VIH : milieu des travailleurs de sexe et des usagers de drogues, milieu carcéral, environnement de la rue (enfant ou adolescent des rues).

Représentation des liens entre l'OEV et le VIH

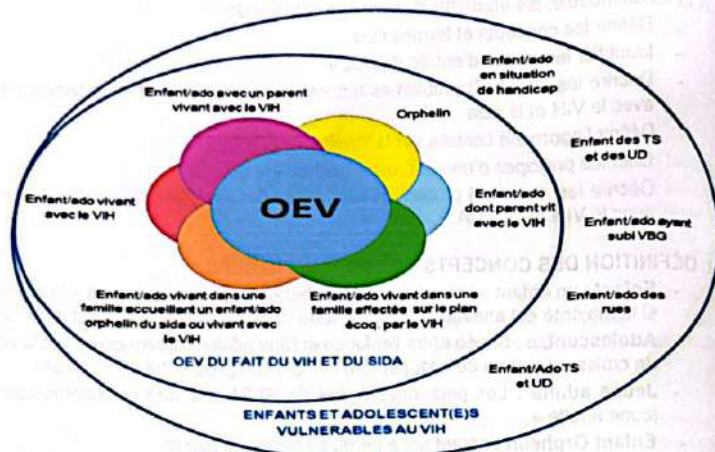


Figure 17 : Représentation des liens entre l'OEV et le VIH

III. PROBLEMES RENCONTRES PAR LES OEV, LES ADOLESCENT(E)S ET LES JEUNES ADULTES

- Éducation et mise en apprentissage
- Économiques des ménages
- sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Soins de santé
- Psychosociaux
- Protection
- Abri et soins

IV. PORTES D'ENTRÉE POUR L'IDENTIFICATION DES OEV

Les portes d'entrée pour l'identification des OEV sont :

- Les structures de santé : CHU, CHR, HG, FSU, CSU, SSSU, CSR, cliniques privées, etc.
- Les structures sociales : les Centres Sociaux (CS) et les autres services sociaux
- Les structures communautaires : les ONG et les autres organisations à base communautaire/basées sur la foi et les associations de personnes infectées et affectées par le VIH et le sida (PIAVIH)

V. APPROCHE DE LA PROGRAMMATION VIH CENTRÉE SUR LA FAMILLE

Introduction

L'approche de la programmation VIH centrée sur la famille s'appuie sur les ressources (humaines, matérielles, financières, etc.) qui existent au sein de la famille afin de tirer le meilleur parti des services proposés aux enfants.

C'est une « approche de soins globale et coordonnée qui prend en charge les besoins tant des enfants que des adultes au sein d'une famille et qui s'efforce de satisfaire les besoins en matière de soins de santé et de soutien social, soit directement, soit indirectement, au moyen de partenariats stratégiques et/ou d'orientations vers d'autres prestataires de services, ou de liens avec ceux-ci » (Wakhweya, A. et al. (2008))

Dans le cadre d'une programmation centrée sur la famille, il faut connaître :

- La situation géographique de la famille de l'enfant
- Les membres de la famille : parents directs, famille élargie
- Les personnes en charge de l'enfant
- Les donneurs de soins (autres intervenants extérieurs au ménage)
- Les ressources de la famille
- Les besoins en compétence parentale (santé, éducation, protection, renforcement économique...)
- Les structures ou organisations qui peuvent offrir les services complémentaires.

5.1. Principes d'une programmation VIH centrée sur la famille

Les principes sont :

- L'implication de la famille : la famille doit s'approprier les actions visant à améliorer le bien-être de l'enfant;
- Le travail en collaboration : l'intervenant social doit travailler en synergie avec les autres parties prenantes;
- La satisfaction des besoins holistiques de la famille : l'intervenant social doit veiller à la satisfaction des besoins globaux de la famille,
- la référence et la contre référence : lorsque l'intervenant social est limité dans ses actions, il devra référer le bénéficiaire vers une structure compétente et faire le suivi;
- L'efficacité et l'efficience : le plan d'intervention sur la famille devra produire des résultats visibles qui permettent de sortir la famille à moindre coût du programme de soutien;
- la coordination des interventions : chaque structure devra instituer un cadre de coordination interne qui respecte les normes pour le suivi des familles.

5.2. Composantes de la programmation VIH centrée sur la famille

- L'enfant

Tous les enfants et les adolescents ont des besoins physiologiques, sociaux et émotionnels de base qui doivent être satisfaits de manière adaptée par la famille et la communauté, en vue de leur assurer un développement sain.

- La famille

Les membres de la famille ont des relations clairement définies, des engagements à long terme, des obligations et des responsabilités mutuelles ainsi qu'un sentiment partagé d'appartenance.

- La communauté

La communauté désigne habituellement les personnes vivant dans une même zone géographique (village, quartier, etc.).

Elle peut également désigner les personnes unies par une histoire, une langue, une culture, une confession religieuse, un intérêt ou une activité.

VI. GESTION DES CAS DANS L'APPROCHE FAMILLE

Introduction

La notion de gestion des cas est une notion qui évoque un rôle spécifique de coordination des services auprès d'une clientèle ciblée

Le gestionnaire de cas (intervenant social) intervient sur la personne et son environnement afin d'assurer son fonctionnement psychosocial optimal

6.1 Définition

La gestion de cas est un processus d'identification des ressources, des capacités et des besoins prioritaires des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et leurs familles affectées par le VIH en vue de l'amélioration de leur bien-être (santé, éducation, protection et stabilité).

L'intervenant social, en collaboration avec la famille, évalue les besoins du client et ceux de ses proches aidants (s'il y a lieu), planifie, coordonne, négocie, effectue le suivi et représente les droits de son bénéficiaire pour l'obtention de services diversifiés pouvant répondre à ses besoins complexes

6.2 Les principes de la gestion des cas dans l'approche famille

- Promouvoir la collaboration et le partenariat avec chaque famille ou ménage bénéficiaire, incluant un ou plusieurs enfants et les personnes qui prennent soin d'eux ;
- Intégrer les approches et les interventions adaptées à l'âge et au stade de développement de l'enfant ;
- Reconnaître les multiples vulnérabilités des OEV et leurs familles et chercher à améliorer la collaboration et l'intégration des services entre les différents secteurs
- Promouvoir la sécurité des bénéficiaires et veiller à la mise en place des procédures opérationnelles pour gérer les urgences (ex : violence domestique, maltraitance, abus, négligence, exploitation, malnutrition aiguë sévère) auxquelles ils pourraient faire face ; Utiliser la gestion axée sur les objectifs pour évaluer les résultats obtenus et promouvoir les résultats de qualité
- Bâtir sur les forces, les ressources et la contribution potentielle des ménages et des organisations existantes, pour améliorer la protection et le bien être des bénéficiaires plutôt que sur une approche basée sur la pathologie, qui, elle est fixée sur les besoins et les problèmes auxquels fait face le bénéficiaire
- Promouvoir l'excellence professionnelle, le maintien de la compétence et le respect de la confidentialité dans les pratiques.

6.3 Etapes de la gestion des cas dans les programmes OEV

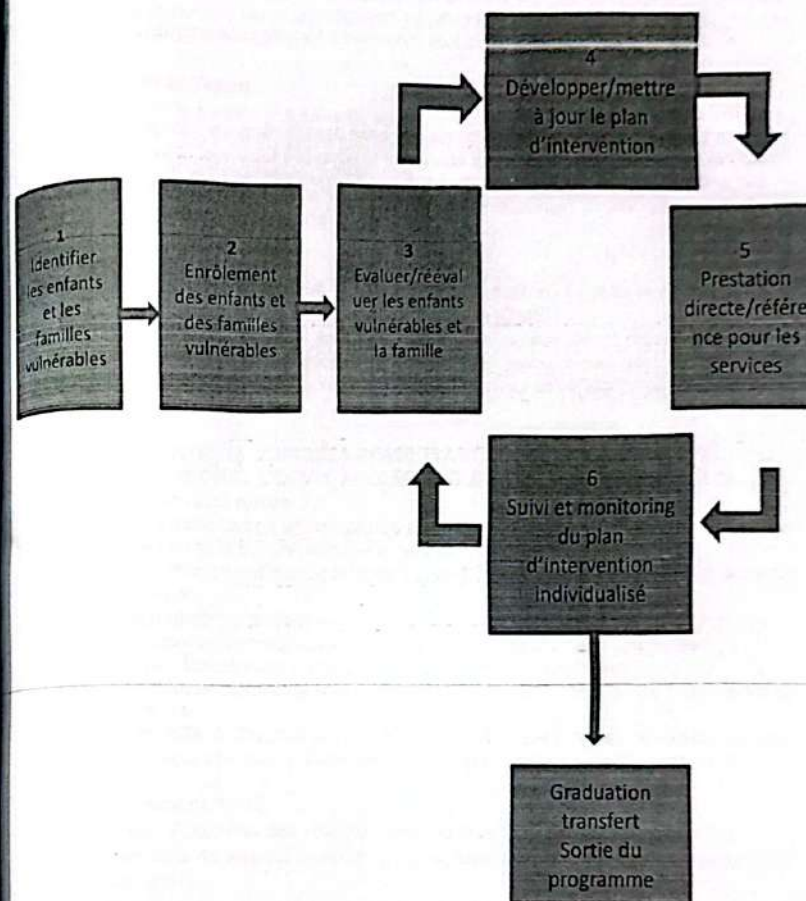


Figure 18 : Etapes de la gestion des cas dans les programmes OEV

6.4 Rôle de gestionnaire de cas (Intervenant social)

Le gestionnaire de cas ou l'intervenant social en plus de son rôle habituel dans l'offre des services aura les responsabilités suivantes :

- Développer et suivre les plans d'interventions ;
- Coordonner les actions des acteurs en vue de l'achèvement des objectifs du plan ;
- Faciliter les références aux services appropriés ;
- S'assurer que les décisions prises répondent à l'intérêt supérieur de l'OEV et leur famille.

CONCLUSION

Au regard du rôle des structures sociales de base dans la réponse face à la pandémie du VIH et du sida, l'IDE/SFM doit s'approprier le concept « OEV » et l'approche centrée sur la famille vise à établir un partenariat avec la famille afin de bâtir des interventions efficaces pour l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte.

MODULE 3 : SOUTIEN AUX SOINS DE SANTÉ DES OEV

Objectif général

Amener les prestataires de santé à favoriser l'accès aux soins de santé promotionnels, préventifs et curatifs selon les besoins des OEV, dans une approche de continuum de soins en vue de leur bien-être.

Objectifs spécifiques

- Définir le soutien aux soins de santé
- Décrire les manifestations cliniques courantes et le dépistage de l'infection à VIH chez l'OEV, l'adolescent(e) et le jeune adulte
- Reconnaître les éléments du diagnostic clinique de l'infection liée au VIH chez l'OEV, l'adolescent.e et le jeune adulte

Définition

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (OMS).

Pour les enfants qui naissent en bonne santé, il est capital de les maintenir en bonne santé mentale, physique et sociale. Pour ceux ne naissant pas dans cet état, il est primordial de les amener à recouvrer la santé complète et/ou améliorer leur qualité de vie.

I. MANIFESTATIONS CLINIQUES PERMETTANT DE SOUPCONNER L'INFECTION LIÉE AU VIH CHEZ L'OEV L'ADOLESCENT.E ET LE JEUNE ADULTE (1/5)

1.1 Infections récurrentes

- **Candidose bucco pharyngée ou muguet** : Présence de taches blanches ou de plaies dans la bouche et/ou au niveau de l'œsophage
- **Parotidite chronique** : gonflement devant l'oreille persistant plus de 30 jours ou récurrent
- **Adénopathies généralisées** : Présence de ganglions
- **Hépatosplénomégalie** : augmentation de la taille du foie ou de la rate
- **Fièvre** : température à plus de 37°5 C, prolongée, inexpliquée
- **Problèmes neurologiques** : Céphalées répétées, Convulsions Troubles de la mémoire
- **Méningite à Cryptocoque** : Fièvre, céphalées persistantes et résistantes aux antalgiques habituels, convulsions, bombement de la fontanelle chez l'enfant.

1.2 Problèmes cutanés

- **Zona** : Apparition des vésicules, avec douleur
- **Sarcome de Kaposi** : macules (taches), papules (boutons) ou des nodules (gros boutons) ...
- **Prurigo** : Apparition répétée de boutons rouges

1.3 Pneumopathie interstitielle lymphoïde :

Problèmes respiratoires, ganglions au niveau du cou, gonflement devant l'oreille

1.4 Pneumonie à Pneumocystis :

Toux sèche, dyspnée ou difficulté à respirer, amaigrissement.

1.5 Otite chronique :

Écoulement de l'oreille durant 14 jours ou plus.

1.6 Diarrhée persistante :

Émission de plus de 3 selles liquides par jour

1.7 Retard de croissance :

Perte de poids ou écart progressif et continu par rapport à la courbe de poids d'une croissance normale.

1.8 Infections sexuellement transmissibles (IST) :

Douleurs pelviennes ; écoulements vaginaux écoulements urétraux ; ulcérations génitales ; végétations vénériennes ; conjonctivite du nouveau-né

II. CONDUITE À TENIR DEVANT LES AFFECTIONS COURANTES LIÉES AU VIH CHEZ L'OEUVRE L'ADOLESCENT.E ET LE JEUNE ADULTE

2.1 Conduite à tenir face à la fièvre

❖ A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage et l'enfant/l'adolescent.e ou le jeune adulte si possible sur les circonstances de survenue de la fièvre
- Rechercher les signes de gravité (Température > 39,5°, Enfant pâle, Enfant somnolent ou dans le coma, Convulsions)
- Ramener et maintenir la température normale à 37,5°
- Référer de façon systématique l'enfant ou l'adolescent à un centre de santé

❖ A NE PAS FAIRE

- Couvrir l'enfant ou l'adolescent avec plusieurs vêtements
- Faire des massages à l'eau chaude
- Mettre l'enfant ou l'adolescent près d'une source de chaleur
- Fermer les portes et fenêtres
- Donner des médicaments sans avis médical
- Garder l'enfant ou l'adolescent malade à la maison

2.2 Conduite à tenir face à la diarrhée chronique

A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage et l'enfant ou l'adolescent.e si possible, l'adolescent.e ou le jeune adulte sur la date de début, de la fréquence et l'aspect de la diarrhée
- Évaluer l'état physique de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte en recherchant les signes de détresse respiratoire
- Compenser rapidement les pertes en eau avec la réhydratation par voie orale
- Continuer d'alimenter de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte en petite quantité
- Conseiller des mesures hygiéno-diététiques aux parents et à l'entourage
- Référer systématiquement l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte malade à un centre de santé

2.3 Conduite à tenir face à la toux et difficultés respiratoires

❖ A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte si possible sur les circonstances de la survenue

- Évaluer l'état physique de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte en recherchant les signes de détresse respiratoires
- Rassurer l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte et les parents
- Continuer à alimenter l'enfant l'adolescent.e ou le jeune adulte
- Donner à boire à l'enfant l'adolescent.e ou le jeune adulte en petite gorgée
- Proposer un mélange fait de miel, de jus de citron et d'eau
- Référer l'enfant l'adolescent.e ou le jeune adulte à un centre de santé

❖ A NE PAS FAIRE

- Paniquer
- Laisser l'enfant ou l'adolescent seul
- Exposer l'enfant ou l'adolescent(e) au froid
- Donner des médicaments sans avis médical.

2.4 Conduite à tenir face une affection cutanée

❖ A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage de l'enfant, de l'adolescent.e ou le jeune adulte si possible sur les circonstances de la survenue
- Apprécier l'aspect des anomalies sur la peau et leurs effets sur l'état général de l'enfant, de l'adolescent.e ou le jeune adulte
- Conseiller des mesures simples aux parents ou à l'entourage
- Proposer des aliments riches en vitamines A et B6
- Référer l'enfant, de l'adolescent.e ou le jeune adulte vers la structure spécialisée

❖ A NE PAS FAIRE

- Manipuler les boutons ou furoncles
- Appliquer des produits non conseillés par un agent de santé.

2.5 Conduite à tenir face à une candidose buccale

- Interroger les parents ou l'entourage de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte si possible sur les circonstances de la survenue
- Apprécier l'aspect des anomalies dans la bouche et les capacités de l'enfant, de l'adolescent.e ou le jeune adulte à s'alimenter
- Rechercher les signes d'extension de la candidose à l'œsophage.
- Conseiller des mesures hygiéno-diététiques aux parents ou à l'entourage
- Donner à l'enfant, à l'adolescent.e ou au jeune adulte des boissons froides
- Frotter doucement les plaques blanches dans la bouche
- Donner à l'enfant, à l'adolescent.e ou au jeune adulte des aliments mous, non épicés
- Faire des bains de bouche à l'eau tiède modérément salée
- Brosser les dents de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte si possible, après chaque repas avec une brosse souple
- Éviter les aliments épicés, chauds et acides
- Référer l'enfant ou l'adolescent.e ou le jeune adulte à un centre de santé

❖ A NE PAS FAIRE

- Donner des aliments qui nécessitent une longue mastication ou ceux qui sont collants et difficile à avaler (beurre, cacahuète...)
- Donner des aliments épicés ou trop salés (piments, curry)

- Donner des aliments acides ou aigres (orange, citron, ananas, vinaigre, tomate...)

2.6 Conduite à tenir face à la nausée et vomissements

❖ A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage sur les circonstances de survenue des nausées et/ou vomissements
- Évaluer l'état physique de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte en recherchant des signes de déshydratation
- Continuer d'alimenter l'enfant ou l'adolescent(e) en donnant à manger et à boire en petite quantité
- Conseiller aux parents de faire manger l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte en position assise
- Proposer des mesures simples permettant de lutter contre les vomissements
- Proposer des aliments secs et salés comme du pain grillé, (biscotte) et des céréales
- Référer l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte dans un centre de santé.

❖ A NE PAS FAIRE

- Allonger l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte juste après le repas
- Donner des aliments gras, huileux et très sucrés
- Donner des médicaments sans avis médical.
- Arrêter de s'alimenter

2.7 Conduite à tenir face à la douleur

❖ A FAIRE

- Interroger les parents ou l'entourage de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte sur les circonstances de la survenue
- Évaluer la douleur en recherchant sa cause
- Rechercher les facteurs déclenchant ou aggravant de la douleur
- Rechercher les facteurs calmant la douleur : position de repos, médicament...
- Rechercher les signes associés
- Évaluer l'état psychologique de l'OEUV
- Mettre l'OEUV au repos dans un environnement calme
- Soulager la douleur avec des mesures simples
- Mobiliser (aider le malade à faire de petits exercices physiques) et masser doucement les endroits douloureux
- Trouver une bonne position pour le soulager
- Appliquer un linge humide et froid sur les endroits douloureux
- Proposer du Paracétamol en fonction de l'âge, poids
- Rechercher les obstacles à la prise en charge
- Référer l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte

❖ A NE PAS FAIRE

- Donner des médicaments sans avis médical.

2.8 Conduite à tenir face à l'asthénie et faiblesse

❖ A FAIRE

- Évaluer la fatigue ou la faiblesse

- Apporter un soutien moral et/ou émotionnel à l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte et à son entourage
- Conseiller à l'enfant ou à de l'adolescent.e ou au jeune adulte (ou aux parents) le repos
- Examiner ce qui peut aider l'enfant ou l'adolescent.e ou le jeune adulte à atténuer le plus possible sa fatigue
- Proposer des exercices ou des jeux de relaxation
- Encourager les parents à bien alimenter l'enfant ou l'adolescent.e et l'amener à consommer des fruits et légumes
- Référer l'enfant ou l'adolescent.e ou le jeune adulte à un centre de santé.

❖ A NE PAS FAIRE

- Donner des médicaments sans avis médical.
- Prendre des excitants (alcool, drogue, tabac, excès de café...)
- Faire des exercices physiques intenses.

2.9 Conduite à tenir face au sommeil et à l'insomnie

❖ A FAIRE

- Évaluer les caractéristiques des problèmes de sommeil de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte
- Évaluer les facteurs pouvant affecter le sommeil de l'enfant, de l'adolescent.e ou du jeune adulte
- Proposer à l'enfant, à l'adolescent.e ou au jeune adulte, à ses parents ou à l'entourage des mesures simples visant à améliorer le sommeil
- Référer l'enfant, l'adolescent.e ou le jeune adulte vers une structure spécialisée

❖ A NE PAS FAIRE

- Prendre des repas lourds le soir
- Être dans un endroit bruyant
- Consommer du café, de l'alcool, de la cigarette ou d'autres drogues
- Regarder la télévision au lit.

2.10 Retard de croissance

❖ A FAIRE

- Recueillir des informations auprès des parents ou l'entourage de l'enfant sur l'alimentation et les conditions sociales
- Demander aux parents ou à l'entourage, de décrire exactement ce que l'enfant mange
- Évaluer l'état physique de l'enfant
- Évaluer le retard de croissance à partir de l'âge, du poids et de la taille de l'OEUV
- Référer l'OEUV à un centre de santé.

❖ A NE PAS FAIRE

- Attendre que l'enfant ait 24 mois avant de le référer pour le retard staturo-pondérale
- Observer une restriction alimentaire
- Donner des médicaments sans avis médical.

2.11 Conduite à tenir face aux IST

❖ A FAIRE

- Poser des questions à l'OEV ou à son entourage
- Faire la recherche des agents contaminateurs probables et les sujets contacts (briser la chaîne de contamination)
- Promouvoir l'éducation sexuelle des OEV, des adolescent.e.s et des jeunes adultes au sein des familles et de la communauté.
- ✓ Encourager les entretiens entre groupes d'adolescent.e.s, des jeunes adultes et des parents sur les risques liés à l'infection par le VIH et les IST.
- ✓ Promouvoir l'éducation sexuelle chez les OEV
- ✓ Encourager la scolarisation de l'OEV
- Référer l'OEV à un centre de santé ou à une structure spécialisée

❖ A NE PAS FAIRE

- Donner ou prendre des médicaments sans avis médical.
- Juger ou gronder les enfants, les adolescent.e.s ou les jeunes adultes présentant des IST
- Ne pas communiquer sur la sexualité et les IST avec les enfants, les adolescent.e.s et les jeunes adultes
- Avoir des rapports sexuels (OEV).

L'intervenant social doit s'imprégner des différentes attitudes à adopter face aux affections courantes liées au VIH et au sida chez les OEV.

L'intervenant social doit connaître ses limites et référer l'OEV au centre de santé ou à une structure spécialisée.

III. NOTIONS DE BASE SUR LE TRAITEMENT ARV DE L'INFECTION À VIH

3.1 Définition du traitement antirétroviral hautement actif

Un traitement antirétroviral (ARV) hautement actif est l'association efficace de trois médicaments ou plus, appartenant en général à au moins deux classes différentes.

3.2 Intérêt et principes du traitement

❖ Intérêt du traitement

Le traitement ARV permet :

- La diminution de la charge virale (diminution de la quantité de virus dans le sang) ;
- L'augmentation des CD4 (protection renforcée de l'organisme) ;
- La réduction des infections opportunistes (moins de maladies) ;
- L'amélioration de la qualité de vie (retour à une vie normale) ;
- La réduction du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant (une femme séropositive augmente ses chances d'avoir un enfant séronégatif).

❖ Principes du traitement

Les principes du traitement ARV répondent aux initiatives de l'OMS et de l'ONUSIDA sur les « 90 90 90 » d'ici 2020, et « 95 95 95 » d'ici 2030.

Le PEPFAR s'attend à ce que 95% des PVVIH connaissent leur statut, 95% d'entre eux sont sous traitement et 95% de cette seconde catégorie, ont une charge virale supprimée ainsi que le « Tester Traiter tous ».

3.3 Mécanisme d'action des ARV

Les médicaments agissant sur le VIH bloquent son cycle (son évolution) à différentes étapes de sa multiplication. Les ARV ne détruisent pas le virus. C'est pourquoi, à ce jour, il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement, une fois commencé

IV. OBSERVANCE ET EDUCATION THERAPEUTIQUE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT.E ET DU JEUNE ADULTE VIVANT AVEC LE VIH.

4.1 Définition de l'observance thérapeutique

Capacité d'une personne à prendre un traitement selon la prescription donnée :

- L'adhésion est le degré d'accord du patient au traitement
- La compliance (conformité) est le respect du rythme des prises médicamenteuses

4.2 Avantages d'une bonne observance

Réduction de la possibilité de multiplication du virus dans l'organisme se traduisant par :

- Amélioration de l'état de santé
- Prolongement de la vie
- Réduction des infections opportunistes
- Réduction des dépenses liées à la prise en charge des infections opportunistes
- Amélioration de la relation soignant / patient
- Réduction du nombre de RDV de suivi médical
- Diminution du nombre d'orphelins

4.3 Inconvénients d'une mauvaise observance

- Aggravation de la maladie
- Hospitalisation plus fréquente
- Apparition des infections opportunistes
- Dégradation de la qualité de vie
- Diminution des CD4 et augmentation de la charge virale
- Altération de la relation soignant/malade
- Résistances aux médicaments
- Échec du traitement ARV.

4.4 Facteurs déterminants de l'observance

- Au niveau du client : accessibilité financière et géographique, analphabétisme, promiscuité, croyance religieuse, représentation sociale et culturelle du SIDA, Auto-stigmatisation, âge.
- Au niveau du traitement : Complexité du traitement, restriction alimentaire, effets indésirables ou secondaires.
- Au niveau de l'entourage : Confidentialité, stigmatisation, discrimination, soutien, recours aux tradipraticiens.
- Au niveau du personnel soignant : Relation entre soignant et patient, niveau de connaissance de l'infection à VIH, charge de travail, gestion de la confidentialité.

4.5 Outils d'évaluation de l'observance

- L'auto questionnaire
- L'entretien
- Le carnet journal
- Le dénombrement des comprimés rapportés
- Le renouvellement des ordonnances
- DOTS (observation directe de prise effective du traitement)

- Le pilulier électronique.
- Le contrôle de la charge virale

4.6 Stratégies pour améliorer l'observance

❖ Lors de la préparation au traitement

- Identifier la personne qui administrera le traitement à l'enfant ou de l'adolescent ou le jeune adulte
- Évaluer les connaissances de cette personne sur les ARV
- Expliquer aux parents la possibilité de survenue d'effets secondaires
- Donner des informations sur les ARV : mécanisme d'action ARV, effets secondaires, interaction médicamenteuse
- Savoir que le traitement est à vie même si on se sent bien
- Donner les principes de l'observance
- Ne jamais manquer une dose
- Respecter les horaires de prise
- Anticiper sur les difficultés
- Prendre en compte l'environnement social de l'OEUV et adapter les heures de prises à sa vie quotidienne
- Susciter le partage de l'information avec un autre membre de la famille proche
- Parler du risque de survenue des effets secondaires liés au traitement
- Expliquer les conséquences d'une mauvaise observance
- Rappeler le prochain rendez-vous.

❖ Lors du démarrage du traitement ARV

- Évaluer et renforcer les connaissances du patient sur les ARV reçus à la préparation du traitement
- Renforcer les informations sur l'adhésion au traitement
- Donner des informations sur les mesures d'accompagnement du traitement ARV
- Se reposer suffisamment au besoin
- Manger des aliments propres et bien cuits
- Se laver les mains avant et après chaque repas
- Inciter le partage de l'information avec un autre membre de la famille
- S'enquérir de l'engagement des parents ou tuteurs à créer et respecter les conditions d'une bonne observance
- Expliquer le choix des formes galéniques prescrites
- Expliquer comment et quand les médicaments seront administrés
- Expliquer comment seront conservés les médicaments
- Rappeler le prochain rendez-vous
- Effectuer des visites à domicile.

❖ Suivi des enfants sous traitement ARV

- S'enquérir du déroulement du traitement ARV (évolution de l'état de santé, existence des effets secondaires, existence des problèmes relatifs à l'administration des médicaments)
- Mesurer l'observance (entretien, renouvellement d'ordonnance, état physique)
- S'assurer que les médicaments sont suffisants jusqu'au prochain contrôle
- Aider à trouver des stratégies pour améliorer l'observance
- Rappeler le prochain rendez-vous
- S'enquérir du déroulement du traitement ARV (évolution de l'état de santé, existence des effets secondaires, existence des problèmes relatifs à l'administration des médicaments)
- Mesurer l'observance (entretien, renouvellement d'ordonnance, état physique)

- S'assurer que les médicaments sont suffisants jusqu'au prochain contrôle
- Aider à trouver des stratégies pour améliorer l'observance
- Rappeler le prochain rendez-vous

• Ce qu'il ne faut pas faire

- Identifier plusieurs personnes pour donner le traitement à l'OEUV
- Instituer un traitement sans préparation de l'OEUV et de son parent
- Imposer les horaires de prises
- Être impatient ou indisponible pour écouter
- Avoir des feed-back négatifs
- Semer la peur sur la prise des médicaments

4.7 Education thérapeutique

❖ Définition de l'éducation thérapeutique

L'éducation thérapeutique est un processus visant l'apprentissage du client (et de son entourage) lui permettant ainsi d'acquérir des compétences pour :

- Se soigner ;
- S'adapter à sa maladie ;
- Vivre le mieux possible avec la maladie et son traitement ;
- Mieux communiquer et coopérer avec les soignants et les intervenants sociaux ;
- Rendre le patient plus autonome.

L'éducation thérapeutique est un processus visant l'apprentissage du client (et de son entourage) lui permettant ainsi d'acquérir des compétences pour :

- Prendre en charge de manière active la maladie, ses soins, la prévention de la transmission en partenariat avec les soignants
- Prévenir les complications thérapeutiques
- Améliorer l'observance thérapeutique
- Maintenir ou améliorer sa qualité de vie

❖ Démarche de l'éducation thérapeutique (ETP) de l'enfant, de l'adolescent(e) ou du jeune adulte vivant avec le VIH (1/2)

L'ETP comprend les activités de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, l'hospitalisation et les autres institutions de soins concernées (soins et soutien) ainsi que les comportements de santé et de maladie du client.

Cette démarche d'éducation consiste à accompagner le client dans la gestion de la maladie par l'organisation de séances d'ETP qui sont :

- Entretiens individuels (conseil prétraitement, conseil de suivi de l'observance, conseil renforcé pour l'observance) ;
- Entretien de groupe (Groupe de parole, club d'observance) ;
- Consultations d'observance

V. PREVENTION PRIMAIRE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES

5.1 Prophylaxie au cotrimoxazole

- A qui donner la prophylaxie au Cotrimoxazole

Nourrisson à partir de 6 semaines né de mère vivant avec le VIH jusqu'à infirmation de l'infection à VIH ;

- Tout enfant et adolescent ou jeune adulte vivant avec le VIH : Initiation systématique en dehors de toute contre-indication.

5.2 Mesures hygiéno-diététiques

- Respect des bonnes conditions d'hygiène corporelle, alimentaire et du milieu.
- Consommation d'aliments cuits à point, notamment les viandes et les volailles
- Consommation d'eau potable, de fruits et légumes lavés
- Lavage fréquent des mains avant tous les repas et après les toilettes.
- Pas de contacts constants avec les animaux domestiques, notamment le chat
- Alimentation suffisante et variée sans excès
- Usage de moustiquaires imprégnées d'insecticides
- Vaccination, déparasitage et supplémentation en vitamines

5.3 Vaccinations

Un enfant, un adolescent.e ou un jeune adulte infecté peut être vacciné mais se référer toujours au médecin qui le suit.

CONCLUSION

L'observance du traitement ARV est le principal déterminant du succès thérapeutique. La bonne observance conduit à l'amélioration de la qualité de vie.

La mauvaise observance expose l'enfant, l'adolescent.e et le jeune adulte à la détérioration de sa santé.

Les mesures hygiéno-diététiques et la vaccination permettent de maintenir de façon générale la santé de l'OEV.

MODULE 4 : SOUTIEN A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET A LA NUTRITION DES OEV

Objectif Général

Apporter un soutien à la sécurité alimentaire et à la nutrition aux OEV, adolescent.e.s et jeunes adultes et leurs familles en lien avec le VIH et le sida.

Objectifs Spécifiques

A la fin de ce module, les prestataires de santé doivent être capable de :

- Connaître les généralités sur la sécurité alimentaire et la nutrition
- Expliquer les principes d'une bonne alimentation du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent.e et du jeune adulte
- citer les causes de la malnutrition
- Connaître les Stratégies pour lutter contre l'insécurité alimentaire
- énumérer les actions à mener pour renforcer la sécurité alimentaire des ménages affectés par le VIH et le sida

Plan du module

Chapitre 1 - Généralités sur la sécurité alimentaire et la nutrition

Chapitre 2 - Actions Essentielles en Nutrition (AEN)

Chapitre 3 - Alimentation de l'OEV, de l'adolescent.e et du jeune adulte affectés ou infectés par le VIH

Chapitre 4 - Suivi et promotion de la croissance

Chapitre 5 - Malnutrition

Chapitre 6 - Stratégies pour lutter contre l'insécurité alimentaire

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

Définitions

- **Sécurité alimentaire** : situation où une personne/ une famille a accès, de façon régulière, tout au long de l'année, aux aliments en quantité et en qualité qui lui permettent de bien se nourrir.
- **Nutrition** : c'est l'ensemble des réactions par lesquels notre corps transforme et utilise les aliments pour obtenir l'énergie et pour assurer le maintien de la vie. C'est un acte non volontaire.
- **Aliments** : substances donnant aux êtres vivants l'énergie, la matière première et les composés chimiques pour le bon fonctionnement du corps.

Alimentation : action d'introduire les aliments dans le corps à travers la bouche. C'est un acte volontaire.

Alimentation équilibrée : Ensemble de mesures concernant la quantité de nourriture, leur répartition dans la journée, le type d'aliments et la manière de s'alimenter dans un but de respect de l'équilibre alimentaire

Nutriment : Ce sont des substances chimiques provenant de la transformation de l'aliment dans l'organisme. Les nutriments essentiels pour la santé sont les macronutriments et les micronutriments.

Macronutriment : Ce sont des substances qui sont nécessaires en grande quantité au bon fonctionnement de l'organisme. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Exemple (les glucides, les lipides et les protéines)

Micronutriment : Ce sont des substances qui sont nécessaires en petite quantité au bon fonctionnement de l'organisme (les vitamines et sels minéraux...)
Digestion : processus de transformation par l'appareil digestif des aliments en substances plus petites (les nutriments) pour qu'ils soient absorbés et passent dans le sang.

Métabolisme de base : C'est l'énergie minimale quotidienne dont l'organisme a besoin.

Calorie : C'est l'unité de mesure de la valeur énergétique ou de la quantité d'énergie contenue dans les aliments.

Ration alimentaire : quantité d'aliment à ingérer chaque jour pour couvrir la totalité des dépenses et assurer l'équilibre nutritif de l'individu.

Besoins nutritionnels de l'organisme

○ Besoins énergétiques

➢ Assurés essentiellement par les glucides (hydrates de carbone) généralement retrouvés dans les aliments de base et les sucres et les lipides.

➢ Principales sources des glucides :

- céréales (maïs, riz, sorgho, blé, mil, fonio...)
- tubercules (manioc, patate douce, banane, igname...)
- sucre (miel, canne à sucre, fruits)

➢ Lipides : entrent dans la constitution de la structure des membranes cellulaires et du système nerveux.

➢ Aliments riches en lipides : noix de cajou (anacarde), arachide, noix de coco, avocat, huiles, beurre, fromage...

○ Besoins de construction

➢ Assurés essentiellement par les protéines, essentielles pour la croissance et la reconstruction des cellules et des tissus de l'organisme (croissance du fœtus, croissance de l'enfant, production du lait).

➢ Sources de protéines : animale (viande, poissons, volailles, œufs, lait, fromage), végétale (légumineuse, noix, graines oléagineuses, céréales, légumes, feuilles vert foncé).

○ Besoins en protection

➢ Assurés par les sels minéraux et les vitamines.

➢ Aliments de protection :

- Feuilles et légumes : feuilles de manioc, feuilles de courge, feuilles de haricots, feuilles de patate douce, choux, tomate, navet, laitue, courge, haricot vert, carotte, gombo, amarante, épinard
- Fruits : orange, citron, banane, mangue, papaye, ananas, pastèque, goyave, mandarine

○ Besoins en eau

➢ L'eau est un véhicule, un solvant et un élément régulateur de la température. Elle constitue 70 à 80% du poids du corps de l'enfant. Les besoins en eau augmentent avec : température extérieure, activité physique, fièvre, diarrhée, vomissements.

L'alimentation équilibrée

Une alimentation équilibrée est composée d'aliments de force, d'aliments de construction et d'aliments de protection

Caractéristiques d'une alimentation équilibrée

- **Variété :** aliments de tous les groupes apportant tous les nutriments essentiels.
- **Quantité :** quantité selon les besoins en énergie, construction, protection

Satisfaction : doit tenir compte des goûts
Principes essentiels d'une bonne alimentation

○ En général

- Équilibrer l'alimentation avec les différents groupes d'aliments.
- Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour
- Privilégier la consommation des aliments de saison

○ Pour les enfants de 0-2 ans

- Favoriser l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois de vie

Favoriser l'allaitement jusqu'à 2 ans en introduisant à partir de 6 mois les aliments de complément.

CHAPITRE 2 : ACTIONS ESSENTIELLES EN NUTRITION (AEN)

Alimentation des femmes enceintes et allaitantes

○ Alimentation des femmes enceintes

Pendant la grossesse : augmenter les apports alimentaires afin de couvrir les besoins de la femme et celui du bébé avec un repas en plus par jour et plus si le poids avant la grossesse était faible.

○ Alimentation des femmes allaitantes

Pendant l'allaitement : pour couvrir les besoins de la mère et de l'enfant, augmenter les apports alimentaires de la mère avec deux repas en plus par jour.

Allaitement exclusif

- L'allaitement exclusif signifie allaiter le nouveau-né uniquement au sein et sans aucun apport d'autres éléments liquides (l'eau, jus de fruit, décoction) ou solides, en dehors des vitamines ou des minéraux et les médicaments prescrits, cela dès la naissance jusqu'à 6 mois.
- L'allaitement doit être initié dans l'heure après la naissance

Avantages de l'allaitement exclusif

CHEZ L'ENFANT	CHEZ LA MERE
● Contient tous les éléments nutritifs ● Facile à digérer ● Bien assimilé ; ● Protège contre les infections ; ● Assure une croissance et un développement harmonieux ; ● Renforce les liens affectifs entre la mère et son enfant	● Sans coût ● Disponible à tout moment ● Contribue à protéger la mère d'une nouvelle grossesse (MAMA : Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée) en retardant le retour de couche ● Réduit le risque de cancer du sein

Colostrum : C'est le premier lait de couleur jaunâtre produit par la mère.

- Il est riche en anticorps, en globules blancs, en facteurs de croissance, en vitamine A.
- C'est un purgatif, protège contre les allergies et les infections, évite les ictères et renforce les intestins.
- Contrairement aux préjugés, qui le qualifient de lait sale et de mauvaise qualité, il est essentiel au développement de l'enfant.

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions (1/7)

Ignorances et préjugés

○ Raisons souvent évoquées pour justifier l'arrêt de l'allaitement sont:

- le manque de lait,
- les pleurs du bébé,
- le refus de téter,
- l'affaissement des seins

Conseils et actions

- Les seins produisent suffisamment de lait pour nourrir un ou deux bébés, même si les mères se disent que leur bébé ne reçoive pas assez lait. En réalité ils reçoivent tous le lait dont ils ont besoin

Donner à téter à la demande

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions

Aider la mère à maîtriser la technique de positionnement du bébé au sein pour une bonne tétée

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions

Obstacles liés à des pathologies

- ✓ Engorgement mammaire: C'est un gonflement douloureux et fébrile des seins avec chaleur et aplatissement des mamelons
- ✓ Conseils et actions
- Appliquer des compresses chaudes sur le sein et secouer doucement pour faire couler le lait.
- Utiliser la technique de la bouteille chaude pour libérer la pression dans le sein et faire couler le lait
- Exprimer un peu de lait.
- Après avoir exprimé le lait, appliquer les feuilles de chou ou des compresses froides pour réduire le gonflement
- Donner le sein plus fréquemment et pendant plus longtemps au bébé

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions (5/7)

Obstacles liés à des pathologies

- ✓ Canaux obstrués, c'est d'une douleur, gonflement et rougeur de la zone affectée du sein accompagnés d'une dureté avec trainée rouge
- Porter des vêtements et soutiens gorges amples
- ✓ Mastite
- Se rendre à l'hôpital

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions (6/7)

Obstacles liés à des pathologies

- ✓ Mamelons gercés ou douloureux

Conseils et Actions pour toutes les femmes

- Appliquer quelques gouttes de lait en fin de tétée sur le mamelon lésé et laisser sécher à l'air
- Exposer les seins à l'air et au soleil
- Ne pas utiliser de savon ou de crème sur les mamelons

Conseils et Actions pour les femmes séropositives au VIH

- Interrompre l'allaitement du côté du sein affecté jusqu'à la guérison
- Exprimer manuellement le lait du sein affecté et le jeter
- Continuer à allaiter avec le sein non affecté

Obstacles à l'allaitement exclusif et solutions (7/7)

Conseils et Actions pour toutes les femmes qui ne connaissent pas leur état sérologique ou qui sont séronégatives au VIH

- Commencer la tétée sur le côté qui fait le moins mal ou avec le sein non affecté
- S'assurer que le bébé a une bonne position et une bonne prise
- Laisser le bébé se détacher du sein par lui-même avant de mettre fin à la tétée

Techniques d'expression du lait maternel (1/5)

- Se laver les mains ainsi que le bol destiné au lait avec du savon et de l'eau propre ;
- S'asseoir ou rester debout dans une position confortable, dans un endroit isolé et calme. Boire une boisson chaude et essayer de se relaxer autant que possible. Si possible, se faire masser le dos pour aider à se relaxer ;
- Appliquer une compresse chaude sur les seins. Les masser légèrement et les étirer doucement ou exercer des mouvements circulaires au niveau des mamelons

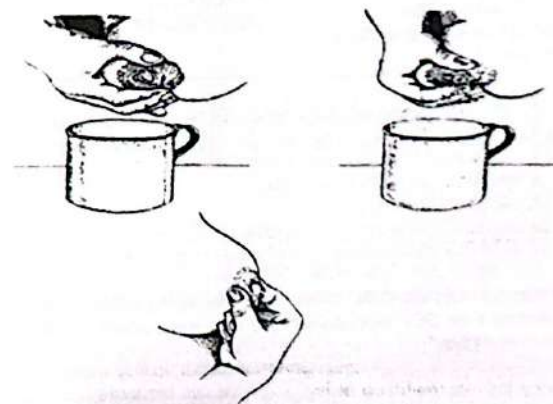
Techniques d'expression du lait maternel (2/5)

- Mettre le pouce sur le sein au-dessus du mamelon et de l'aréole (partie foncée) et l'index en-dessous. Soutenir le sein avec les autres doigts
- Presser doucement avec le pouce et l'index simultanément
- Presser puis relâcher, pour faire couler le lait. Cela ne doit pas faire mal. Si c'est douloureux, c'est que ce n'est pas correctement fait
- Presser de la même manière sur les côtés de l'aréole pour vider toutes les parties du sein

Techniques d'expression du lait maternel (3/5)

- Ne pas comprimer le mamelon et ne pas frotter les doigts sur la peau. Les doigts doivent rouler sur le sein
- Exprimer le lait d'un sein pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le flux ralentisse, et passer à l'autre sein. Puis recommencer sur les deux seins
- Changer de main lorsque l'une est fatiguée. Utiliser indifféremment la main droite ou gauche pour exprimer le lait du sein droit ou gauche

Techniques d'expression du lait maternel (4/5)



Techniques d'expression du lait maternel (5/5)
Durées maximales de conservation du lait exprimé

- Température ambiante : 4 à 6 heures
- Réfrigérateur : 3 à 8 jours
- Congélateur : 6 à 12 mois

Conseils et actions

- Informer toutes les femmes enceintes de l'avantage de l'allaitement et sa pratique
- Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement et comment entretenir la lactation même si elles sont séparées de leurs nourrissons
- Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement et recommander à la femme enceinte et aux mères d'y aller dès leur sortie du centre de santé

Alimentation de complément

- C'est le fait de donner d'autres aliments en plus du lait maternel ou du lait de remplacement à partir de 6 mois pour satisfaire les besoins nutritionnels des nourrissons.
- Les aliments de complément doivent être des aliments nutritifs, préparés et donnés à l'enfant en quantités adéquates, dans de bonnes conditions d'hygiène et de façon interactive pour assurer une croissance optimale, la santé et le développement.
- L'âge de six mois est l'âge recommandé pour commencer l'alimentation de complément.

Conséquences de l'introduction précoce ou tardive des aliments de complément

Introduction précoce (avant 6 mois)	Introduction tardive (après 6 mois)
Réduction de la tétée Risques accrus d'une alimentation déséquilibrée Risques accrus de maladies facteurs de réduction de la protection autres aliments pas aussi propres aliments difficiles à digérer Risques accrus d'une grossesse rapprochée	Malnutrition Carence en vitamines Ralentissement du développement physique et mental de l'enfant Risques accrus de maladies associées à une malnutrition

Facteurs clés pour réussir une alimentation de complément

- La quantité de la nourriture consommée
- La consistance de la nourriture consommée
- La variété des aliments consommés
- La fréquence des repas
- La préparation et la conservation saine des aliments
- La technique d'alimentation (alimentation assistée par exemple)

Soins nutritionnels des OEV, adolescent.e.s et jeunes adultes malades (1/2)

Alimentation d'un OEV, de l'adolescent.e et du jeune adulte malade

Un enfant malade a besoin de plus d'énergie et d'éléments nutritifs pour lutter contre l'infection.

pour éviter la perte de poids, La mère de l'enfant, l'adolescent.e ou du jeune adulte devra :

- l'encourager à boire de l'eau et à manger avec beaucoup de patience ;
- le nourrir fréquemment avec de petites quantités ;
- lui donner des aliments qu'il aime ;
- lui donner une variété d'aliments riches en substances nutritives ; continuer à allaiter l'enfant.

Soins nutritionnels des OEV, et adolescent.e.s et jeunes adultes malades (2/2)

Alimentation pendant la convalescence

L'appétit de l'enfant augmente après sa maladie. C'est le moment opportun pour les familles de donner de la nourriture supplémentaire afin que le poids perdu soit rapidement récupéré, ceci permet de rattraper la croissance.

La mère doit à cette période:

- Donner des tétées supplémentaires
- Donner des repas supplémentaires
- Nourrir avec plus de patience et plus d'attention

Lutte contre la carence en vitamine A

Rôles de la vitamine A

- Augmente la résistance aux infections
- Élément clé pour la croissance et le développement de l'enfant
- Essentielle pour la vision nocturne
- Lutte contre l'anémie

source de vitamine A

Lait, beurre ; foie, œufs, poisson ; feuilles vert foncé (manioc, épinard, patate, haricot ...) ; fruits et légumes à chair jaune orangé (tomate, mangue, papaye, carottes ; maïs jaune ; huile de palme)

La lutte contre la carence en iode

Rôles de l'iode

- Participe à la régulation de la température du corps, au fonctionnement du cerveau, à la croissance, et à la reproduction.
- Favorise le développement intellectuel

Sources d'iode

- Fruits de mer (poissons; algues, crustacés) ; huile de foie de morue ; lait ; œufs

La lutte contre la carence en Fer (1/2)

Rôle du fer

- Lutte contre l'anémie

Sources de fer

- Feuilles vertes (épinard, patates...), foie, viande, œufs, mil, sorgho, etc.
- NB : Le thé empêche l'absorption du fer, tandis que la vitamine C augmente cette absorption.

Rôle du fer

- Lutte contre l'anémie

Sources de fer

- Feuilles vertes (épinard, patates...), foie, viande, œufs, mil, sorgho, etc.
- NB : Le thé empêche l'absorption du fer, tandis que la vitamine C augmente cette absorption.

La lutte contre la carence en Fer (2/2) Conséquences de l'anémie

CHEZ LA MERE	CHEZ L'ENANT
• Naissances de bébés de petite taille • Accouchements prématurés • Décès maternels • Décès périnataux (28^{ème} semaine de la grossesse au 8^{ème} jour de naissance) • Décès fœtaux (les 8 premières semaines de la grossesse jusqu'à l'accouchement)	• Altération du développement mental et des capacités d'apprentissage • Faible croissance en taille/ longueur • Affaiblissement du système immunitaire

Lavage des mains

Technique de lavage des mains:

- Se mouiller les mains à l'eau propre et courante
- Utiliser du savon
- Se les frotter pendant 20 secondes jusqu'à l'avant coude
- Se les rincer à l'eau propre et courante
- Se sécher complètement les mains à l'aide d'un chiffon propre et sec de préférence en papier (à usage unique) ou à l'air libre

CHAPITRE 3 : ALIMENTATION DE L'OEUV, DE L'ADOLESCENT.E ET DU JEUNE ADULTE AFFECTES OU INFECTES PAR LE VIH

Généralités sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant 1/2

Transmission du VIH de la mère à l'enfant

Il existe 3 modes de transmission:

- Pendant la grossesse
- Pendant l'accouchement
- Pendant l'allaitement

Généralités sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant 2/2

Facteurs de risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant

MERE	ENFANT
• CD4 bas inférieur 350 cel/mm³ • Charge virale élevée • infection du sein (abcès, fissures) • infection récente au VIH	• durée de l'allaitement • type d'alimentation (alimentation mixte) • lésions orale ou intestinales • prématurité

Liens entre l'infection à VIH et la nutrition chez les enfants/adolescent.e.s vivant avec le VIH (1/2)

- Les enfants/adolescent.e.s vivant avec le VIH ont un besoin important en énergie qui augmente progressivement jusqu'à atteindre plus de 100% des besoins des enfants et adolescents non infectés.
- Les enfants/adolescent.e.s vivant avec le VIH ont souvent des carences en vitamines et minéraux tels que les Vitamines A, complexes B, C, E, le sélénium et le Zinc.

Alimentation de l'enfant né de mère vivant avec le VIH (1/2)

Recommandations sur l'alimentation d'un enfant né de mère vivant avec le VIH

- Le choix de la meilleure option pour l'alimentation de son nourrisson
- L'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois
- L'alimentation de remplacement si la mère remplit toutes les 05 conditions AFADS
- A 12 mois, arrêter l'allaitement chez l'enfant de statut VIH négatif ou inconnu si l'alimentation est AFADS ;
- continuer l'allaitement jusqu'à 24 mois. Si l'enfant vit avec le VIH,

Alimentation de l'enfant né de mère vivant avec le VIH 2/2

Recommandations sur l'alimentation de l'enfant né de mère séronégative et statut inconnu

- Pratiquer l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois ;
- Poursuivre l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus ;
- Introduire dès l'âge de 6 mois, des aliments complémentaires qui donneront un équilibre nutritionnel suffisant et qui sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité ;
- Eviter l'alimentation mixte pendant les 6 premiers mois. L'alimentation mixte augmente le risque de diarrhée, des infections, et de malnutrition de tous les enfants.

Critères AFADS (1/2)

Pour aider une mère à prendre la meilleure décision, vous devez faire une "évaluation AFADS" de sa situation familiale et financière.

- **Acceptable** : la mère ne voit aucun obstacle majeur qui s'oppose au choix d'une méthode d'alimentation, que ce soit au niveau social, au niveau familial ou la peur de la stigmatisation
- **Faisable** : la mère ou un membre de la famille dispose du temps, des connaissances, du savoir faire pour la préparation du repas du bébé.

Critères AFADS (2/2)

- **Abordable** : la mère et la famille, avec l'aide de la communauté, peuvent supporter le coût de l'alimentation de remplacement, sans compromettre l'équilibre alimentaire et sanitaire du reste de la famille.
- **Durable** : la mère bénéficie sans interruption et aussi longtemps que possible de tous les ingrédients nécessaires.
- **Sûre** : les aliments de remplacement sont conservés, préparés et donnés à l'enfant correctement dans de bonnes conditions d'hygiène et en quantité suffisante.

CHAPITRE 4 : SUIVI ET PROMOTION DE LA CROISSANCE

Définition et importance de l'évaluation nutritionnelle

L'évaluation nutritionnelle est un processus qui permet de déterminer l'état nutritionnel d'une personne.

Elle s'appuie sur :

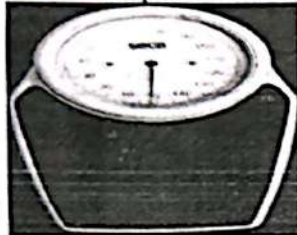
- la prise du poids, de la taille, du périmètre brachial ;
- les informations relatives au régime alimentaire, à l'état clinique, au statut biologique et aux facteurs psychosociaux et économiques.

Types de pèse-personne



Balance électronique

Pèse bébé de précision



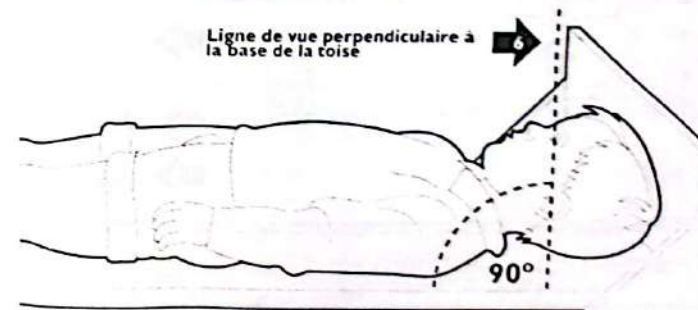
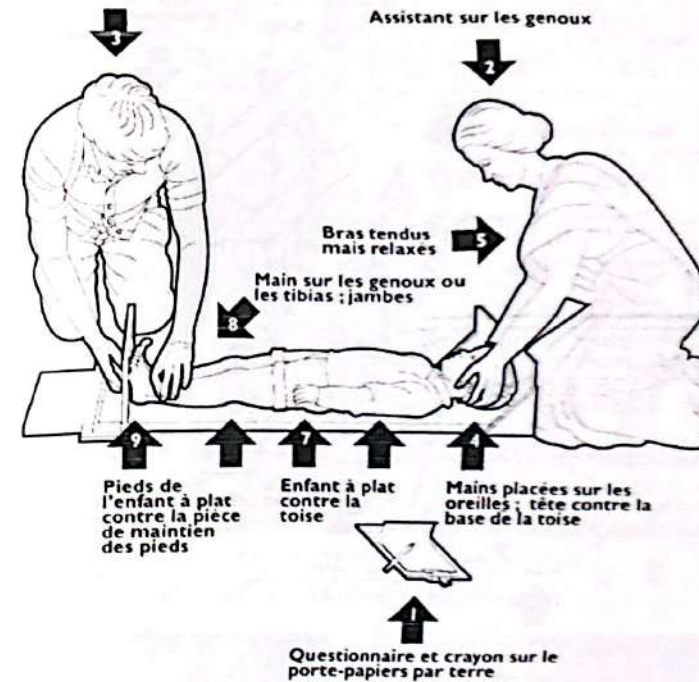
Balance mécanique

Mesures anthropométriques

Mesure couchée de la taille de l'enfant

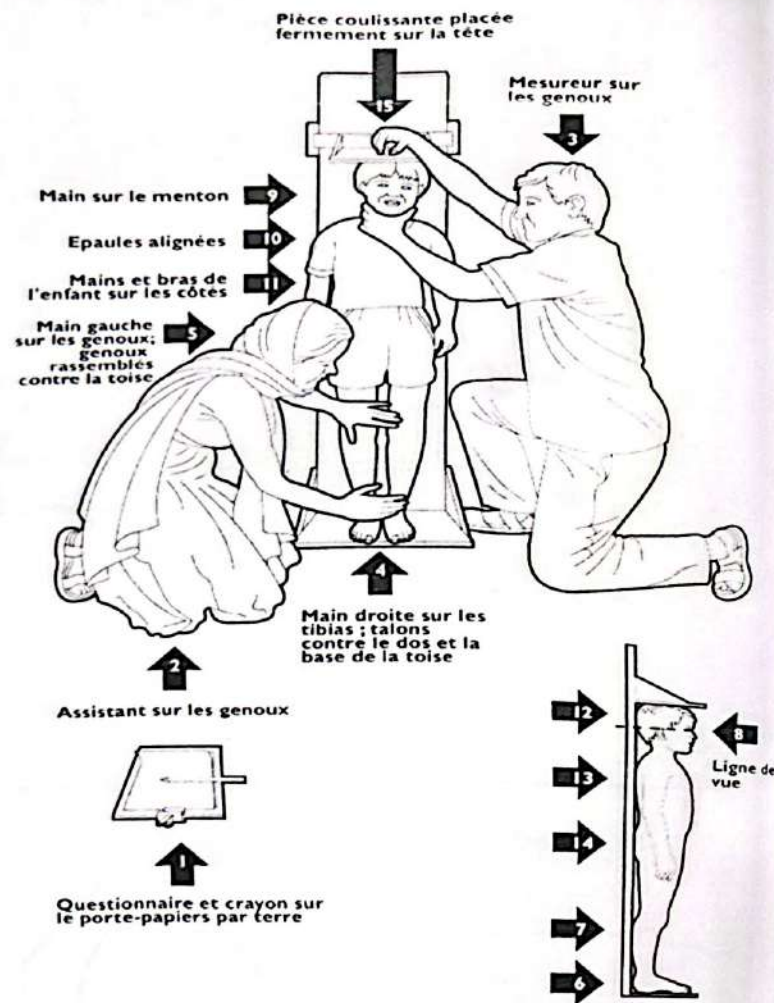
Mesureur sur les genoux

Assistant sur les genoux



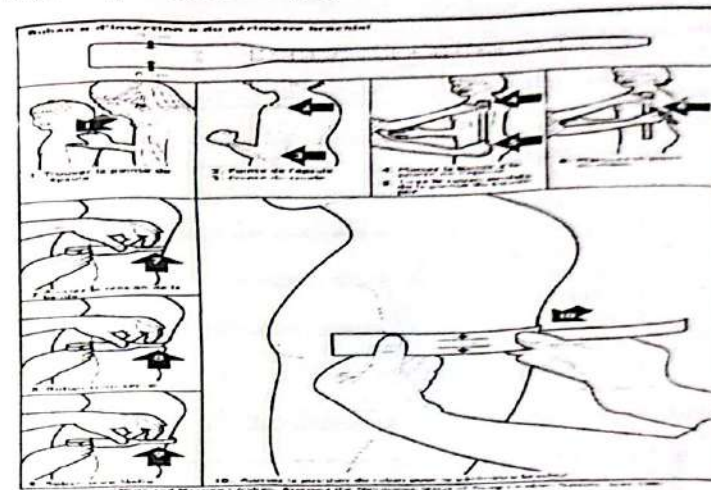
Source : How to Weigh and Measure Children : Assessing the Nutritional Status of Young Children, Nations Unies, 1998.

Mesure de la taille de l'enfant et adolescent(e) debout



Source : How to Weigh and Measure Children : Assessing the Nutritional Status of Young Children, Nations Unies, 1984

Mesure du périmètre brachial (PB)



- Est en même temps une mesure et un indice qui permet de faire le dépistage de la malnutrition aiguë
- Parmi toutes les mesures pour évaluer l'état nutritionnel, la mesure du périmètre brachial est la plus accessible et la plus facile à obtenir. Cependant, elle est moins précise.

Tableau de classification de l'état nutritionnel en fonction du PB

Tranche d'Age	Malnutrition aiguë sévère (MAS)	Malnutrition aiguë modérée (MAM)	Etat nutritionnel normal
6-59 mois	< 11.5cm	11.5 – 12.5 cm	≥ 12.5cm
5-9 ans	<13.5 cm	13.5-14.5 cm	≥14.5cm
10-14ans	<16cm	16-18.5 cm	≥18.5 cm
15 ans et plus	<18.5cm	18.5 -21 cm	≥21 cm
Femmes Enceintes/Allaitantes	<21cm	21- 23 cm	≥23 cm

CHAPITRE 5 : MALNUTRITION

Généralités sur la malnutrition (1/6)

Définition de la malnutrition

- La malnutrition est un état pathologique (anormal) résultant de la carence ou de l'excès relatif ou absolu d'un ou plusieurs nutriments essentiels.

○ 2 aspects :

➤ Malnutrition par excès

- Le surpoids ;
- L'obésité ;
- Le diabète ;
- La dyslipidémie (anomalie de la répartition des lipides dans le corps), etc.

➤ Malnutrition par carence

- Malnutrition chronique ou retard de croissance ;
- Malnutrition aiguë modérée ;
- Malnutrition aiguë sévère (marasme, kwashiorkor)
- Insuffisance pondérale ;
- Carences en micronutriments.

Tableau comparatif entre marasme et kwashiorkor (1/2)

	MARASME	KWASHIORKOR
ÂGE	Surtout dans la première année de vie. Les formes très précoces sont souvent très graves.	Souvent dans les mois qui suivent le sevrage (18 à 30 mois)
POIDS	Amaigrissement très net. Fonte musculaire et disparition de la graisse sous-cutanée. L'air d'un «petit vieux soucieux »	Déficit pondéral, mais peut être masqué par l'augmentation de poids due aux œdèmes.
TAILLE	Limitation de la croissance.	
OEDEMES	Absent	Toujours sont présents et bilatéraux débutent aux pieds, après peuvent apparaître sur les jambes, les mains ou la face (face de lune)

Tableau comparatif entre marasme et kwashiorkor (2/2)

	MARASME	KWASHIORKOR
CHEVEUX	Plus fins que chez les enfants normaux	Ternes, décolorés, cassants.
PEAU	Mince	Mince, brillante avec lésions cutanées fréquentes. Peau devient atrophiée avec des rides, étirée. La peau quelques fois tellement étirée qu'elle suinte. Du fait du déficit des fonctions immunitaires et inflammatoires, les lésions cutanées ne sont pas douloureuses chez l'enfant atteint de Kwashiorkor
APPETIT	Affamé	Anorexique
COMPORTEMENT	Enfant fatigué mais intéressé. Irritable. Pleurs.	Enfant craintif, replié sur lui-même. Apathique misérable.

Causes de la malnutrition

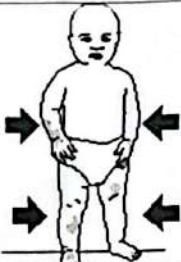
○ Causes immédiates

- Apports alimentaires inadéquats
- Maladies infectieuses

○ Causes fondamentales

- Socioculturelles (interdits alimentaires, ignorance, mauvaise répartition de la nourriture familiale)
- Socio-économiques et politiques (faible pouvoir d'achat, faible taux de scolarisation des femmes, guerre)

Les 3 grades des œdèmes

LEGERS +	MODERES ++	SEVERES +++
		
Œdèmes sur les 2 pieds	Œdèmes sur les 2 pieds et la partie inférieure des 2 Jambes ou les 2 mains et la partie inférieure des 2 avant-bras	Œdèmes généralisés ou sur les 2 pieds, 2 jambes et 2 mains et la face

Traitement nutritionnel de la malnutrition aigue modérée (MAM) (1/2)

Les aliments habituellement utilisés pour les programmes de supplémentation sont les produits alimentaires spécialisés et les mélanges produits localement.

- Produits Alimentaires Spécialisés pour la prise en charge de la MAM :
 - Aliments Mélangés Fortifiés (AMF) ou Farines Enrichies Améliorées (FEA).
Ex : CSB, WSB, RSB
 - Aliments de Supplémentation Prêts à l'Emploi ou ASPE (Plumpy sup)
- Mélanges à base de produits locaux pour la prise en charge de la MAM :
 - Composition
 - Base : céréales (riz, maïs, sorgho, mil, fonio)
 - Sources riches en protéines : haricots, lentilles, lait écrémé en poudre, arachide (cacaahuètes), soja
 - Sources riches en énergie : huile végétale, beurre, cacaahuète, huile de graines végétales, sucre

Traitement médical systématique de la MAM

- Supplémentation en Vitamine A
- Déparasitage
- Prévention de l'anémie (Fer et l'acide folique seront administrés durant la période de la prise en charge)
- Vaccination contre la rougeole (toujours vérifier le statut vaccinal du bénéficiaire à son admission et le référer au poste de vaccination si besoin est)

Surveillance de la malnutrition

- Le suivi de l'état nutritionnel se fera pour chaque bénéficiaire une fois par semaine par la mesure du poids.
- La taille sera prise une fois par mois afin de déterminer l'indice poids/taille.
- Un examen clinique sera fait pour évaluer l'état du malade.

Education nutritionnelle

- Promouvoir l'allaitement exclusif dans les 6 premiers mois de la vie et la poursuite de l'allaitement de l'enfant au moins jusqu'à 2 ans
- S'assurer que les femmes enceintes et allaitantes prennent des repas supplémentaires pour couvrir leurs besoins et ceux de leurs bébés
- Encourager une alimentation de complément variée et progressive pour les enfants à partir de 6 mois
- Mentionner l'importance d'une prise adéquate de vitamine A par les enfants de 6 à 59 mois tous les 6 mois
- Mentionner l'importance du déparasitage tous les 6 mois

Mesures préventives de la malnutrition (1/2)

- Améliorer la situation économique de la famille de l'OEUV du fait du VIH
- Evaluer les habitudes alimentaires de la famille et de la communauté et proposer des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire
- Conseiller les parents au sujet des croyances fausses concernant les aliments (interdits alimentaires)
- Conseiller les parents sur les méthodes simples et pratiques pour la préparation des aliments

Mesures préventives de la malnutrition (2/2)

- Eduquer les familles sur les mesures d'hygiène alimentaire en milieu communautaire
- Faire la promotion d'une alimentation équilibrée
- Accorder une attention particulière au cas de la femme enceinte en leur conseillant d'accroître la consommation des fruits et légumes, produits d'origine animale, sel iodé, aliments fortifiés
- Adopter des mesures d'hygiène alimentaires
- Eduquer les familles sur les mesures d'hygiène alimentaire en milieu communautaire
- Faire la promotion d'une alimentation équilibrée
- Accorder une attention particulière au cas de la femme enceinte en leur conseillant d'accroître la consommation des fruits et légumes, produits d'origine animale, sel iodé, aliments fortifiés
- Adopter des mesures d'hygiène alimentaires

Faire manger l'enfant dans des endroits propres ;

Mesures d'hygiène alimentaire (2/2)

- Protéger les aliments contre la poussière, les mouches et les cafards ;
- Eviter de boire les boissons alcoolisées (vin, bière, koutoukou...) ;
- Eviter de consommer le tabac et d'autres drogues ;
- Eviter de manger les fruits non mûrs ;
- Laver les ustensiles de cuisine à l'eau propre, au savon et les sécher à un endroit propre à l'abri des animaux.

CHAPITRE 6 : STRATEGIES POUR LUTTER CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE

Effets du VIH et du sida sur la sécurité alimentaire des ménages

Dans une famille ayant un adulte vivant avec le VIH :

- L'activité peut être réduite et la productivité baisser
- Les dépenses des soins de santé ont tendance à primer sur les dépenses en alimentation
- Le statut nutritionnel se détériore et peut affecter la capacité de travail de l'adulte vivant avec le VIH
- Les biens peuvent être vendus avec un risque d'endettement de la famille
- Les enfants deviennent orphelins parfois déscolarisés et exposés à toute sorte d'exploitation

La cellule familiale peut se désintégrer et créer l'insécurité alimentaire

Actions à mener à par les intervenants sociaux (1/2)

- Evaluer la sécurité alimentaire du ménage
 - Encourager les ménages à faire des provisions alimentaires et des cultures de contre saison
 - Aider les ménages à choisir des aliments locaux riches en micronutriments
 - Aider les ménages à mieux conserver les aliments
 - Aider les ménages à préparer les aliments de façon appropriée
- #### Actions à mener à par les intervenants sociaux (2/2)
- Aider les ménages à réallouer les dépenses afin d'augmenter l'achat d'aliments nutritifs
 - Promouvoir la création de jardins potagers et l'élevage d'animaux
 - Aider les ménages à la création d'AGR, ou à intégrer les AVEC/GEC
 - Référer les bénéficiaires éligibles aux institutions qui octroient un soutien alimentaire

Conclusion du Module

- La sécurité alimentaire et la nutrition sont inextricablement liées. L'insécurité alimentaire, au niveau d'une personne ou d'un ménage, favorise l'exposition aux différentes formes de malnutrition.
- Dans le contexte de la lutte contre le sida, il est à noter que les services nutritionnels et alimentaires jouent un rôle important dans la gestion du VIH pour les personnes vivant avec le VIH, notamment chez les enfants et les adolescent(e)s vivant avec le VIH.
- Au niveau de la sécurité alimentaire, l'intervenant social doit accompagner l'autonomisation économique des ménages à travers des AGR, AVEC/GEC, etc.

MODULE 5 : DES MODULES DROITS HUMAINS RELATIFS AUX PVVIH

LE BUT

Ce module a pour but de contribuer à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans l'offre de services de santé.

LES OBJECTIFS

Objectif Général

Améliorer l'offre de service aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés par le renforcement des capacités des professionnels du parcours de soins et la formation initiale des étudiants en sciences de la santé.

Objectifs spécifiques

1. Renforcer les connaissances des professionnels et étudiants du parcours de soins sur les Droits de l'Homme en lien avec le VIH ;
2. Renforcer les connaissances des professionnels et étudiants intervenant dans le parcours de soins sur la notion de VBG ;
3. Identifier et adresser les attitudes et comportements qui portent atteintes aux Droits de l'Homme.

I. STIGMATISATION ET DISCRIMINATION

PLAN

DEFINITION DE LA STIGMATISATION

TYPES DE LA STIGMATISATION

SOURCES DE LA STIGMATISATION

DEFINITION DISCRIMINATION

MANIFESTATIONS

CONSEQUENCES

SOLUTIONS

RELATION STIGMATISATION, DISCRIMINATION ET DROIT DE L'HOMME.

1. DEFINITIONS

- ✓ Selon Goffman (1963), la stigmatisation est « un attribut indésirable ou discréditant que possède un individu, réduisant son statut aux yeux de la société ». La stigmatisation est la croyance qu'une situation est « mal » ou moralement inacceptable. Elle se traduit par une perception négative du phénomène au sein des communautés, parmi les parties prenantes, et au-delà. La stigmatisation est fréquemment perpétuée par la société (en particulier les opposants au changement).
- ✓ La stigmatisation est un processus dynamique d'évaluation.
- ✓ La stigmatisation liée au VIH/SIDA repose sur des attitudes et idées négatives qu'elle renforce au sein de la société.

2. TYPES

Deux catégories de stigmatisation:

- ✓ **Stigmatisation intériorisée** : elle se rapporte aux prévisions que les personnes stigmatisées ont de la manière dont les autres réagiront à leur égard
- ✓ **Stigmatisation subie** : terme utilisé pour décrire une personne stigmatisée qui fait l'expérience d'actes discriminatoires. Exemple: sentiments et réactions d'une personne stigmatisée lorsque son statut est divulgué contre sa volonté.

3. SOURCES

- ✓ Elle peut trouver sa source dans les lois et politiques encadrant un phénomène.

Si une loi restreignant les droits ou l'accès aux services d'un groupe donné a été adoptée, cela envoie un message aux citoyens du pays faisant croire que les personnes ou la pratique en question sont fondamentalement mauvaises, chacun pouvant penser qu'il y a une bonne raison à cette restriction. Ce sont en particulier les cas de l'avortement, des droits des LGBTQI, et de l'accès aux services de DSSR des populations marginalisées et des jeunes.

- ✓ Elle peut trouver sa source dans des normes sociales et croyances culturelles.
- Les croyances religieuses, les normes de genre et les traditions culturelles peuvent contribuer à la stigmatisation au sein des communautés et des structures familiales. Il est difficile pour les individus de prendre position pour un changement remettant en cause des normes ainsi enracinées.
- L'avortement, les droits des LGBTQI, les MGF et le mariage des enfants sont autant d'exemples de thématiques marquées par les croyances culturelles et religieuses où prévaut une forte stigmatisation sociale.
- ✓ Elle peut trouver sa source dans le manque de connaissances ou de compréhension d'un enjeu.
- Si l'enjeu est globalement mal compris, ou si les individus/communautés/sociétés n'ont pas accès à des sources d'information factuelles, la stigmatisation peut être alimentée par la perpétuation d'informations inexacts. C'est ainsi, par exemple, que de nombreux individus refusent de partager un repas avec des personnes séropositives, pensant à tort que le VIH/sida peut être transmis par le toucher ou la salive, alors que la recherche médicale a prouvé que les seuls vecteurs sont le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel.

4. DISCRIMINATION

4.1 DEFINITION

- ✓ La discrimination est l'une des conséquences de la stigmatisation la discrimination renvoie à toute forme de distinction, d'exclusion ou de restriction arbitraires à l'égard d'une personne, généralement mais exclusivement en fonction d'une caractéristique inhérente à cette personne ou perçue comme appartenant à un groupe particulier (cas des populations clés). Des personnes vivant avec le VIH, des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, des travailleuses du sexe, des personnes transgenres, les populations carcérales et utilisateurs de drogues se voient ainsi refusés entre autres le droit aux soins de santé, à l'emploi, à l'éducation et à la libre circulation.

5. MANIFESTATIONS

- ✓ Isolement;
- ✓ Refus d'emploi;
- ✓ Refus de logement;
- ✓ Refus de mariage;
- ✓ Rejet par la communauté
- ✓ Retard dans l'administration des ARV;
- ✓ Refus d'assistance médicale;
- ✓ Injures ;
- ✓ Comportements humiliants;

- ✓ Commerçages
- ✓ Harcèlement

6. LES CONSÉQUENCES

Les trois types de conséquences:

- ✓ Pour les cibles (les PVVIH et celles présumées avoir le Sida)
- ✓ Pour les cibles potentielles (les personnes ne sachant connaissant pas leur statut)
- ✓ Pour la société en général

Les conséquences pour les cibles :

- Certaines PVVIH recourent à des mesures extrêmes pour éviter de divulguer leur statut et de s'exposer à la stigmatisation; Exemple: refus du port de préservatif de peur que le (la) partenaire ne suspecte le statut positif.
- Réduction de l'efficacité des efforts de prévention
- Régression au niveau des avancées du pays
- Empêchement des PVVIH d'avoir accès aux structures de soins
- Traumatisme psychologique chez les PVVIH
- Perte d'estime en soi;
- Dépression;
- Désespoir;
- Isolement.

Les conséquences pour les cibles potentielles :

- Refus de faire le test de dépistage par peur d'être stigmatiser si positif ;
- Propagation du VIH;

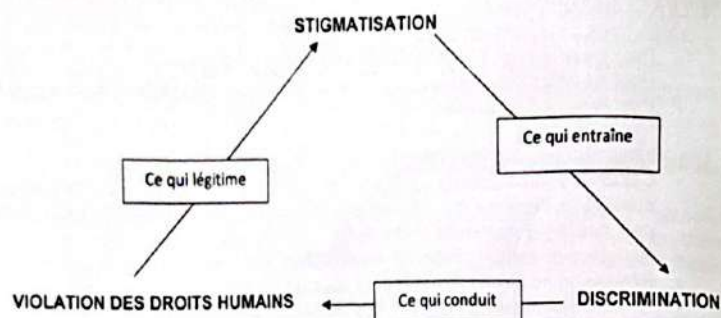
Les conséquences pour la société :

- Propagation rapide de l'épidémie dans la société ;
- Réduction des efforts de prévention du VIH.

7. SOLUTIONS

- Promouvoir la loi du 14 Juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et répression en matière de lutte contre VIH et le Sida;
- Orienter les cibles sur leurs droits et devoirs ;
- Renforcer la prise en charge juridique et judiciaire des cibles en cas de violation des droits;
- Promouvoir les dispositifs de PEC des cas de violences et de violations
- Plaider pour l'intégration des modules droits humains dans le curriculum de formation des prestataires ;
- Lois, réformes législatives pour lutter contre les abus – Etc.
- Sensibilisation des acteurs clés pour un environnement favorable

8. RELATION STIGMATISATION, DISCRIMINATION ET DROIT DE L'HOMME



Analyses La stigmatisation associée aux violences sexuelles empêche les victimes et surtout les populations clés d'aller vers les centres de prise en charge. La capacité d'un individu à être ouvert face aux personnels de santé ou professionnels de Droit est entachée par les craintes, faits avérés ou supposés de stigmatisation. La stigmatisation conduit à la discrimination et à la violation d'autres Droits de l'Homme.

CONCLUSION

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH/SIDA, sont préjudiciables aux PVVIH, aux personnes présumées vivre avec le VIH et à la société en général. Elles mettent un frein aux actions de prévention et de prise en charge.

II. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG)

PLAN

1. LES DÉFINITION DES NOTIONS CLÉS
2. LES TYPES DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
3. LES FACTEURS FAVORISANTS ET LES CONSÉQUENCES DES VBG
4. LES CONSÉQUENCES DES VBG SUR LES PERSONNES SURVIVANTES/VICTIMES

1. DÉFINITIONS DES NOTIONS CLÉS

La violence	Le genre	Le sexe
✓ Recours à la force pour contrôler un individu ou une population ✓ Toute forme d'abus, de contrainte ou de pression physique, psychologique, sociale ou économique ✓ Peut être ouverte (agression ou menace avec une arme), ou plus insidieuse (intimidation, menace ou autres formes de pression psychologique ou sociale).	✓ Chances, aux opportunités, aux droits et devoirs qu'on accorde à un individu (homme ou femme) au sein d'une société. ✓ Différence entre les hommes et les femmes dans leurs relations sociales.	✓ Différences biologiques (naturelles) entre les femmes et les hommes. ✓ Caractéristiques biologiques immuables et universelles des femmes et des hommes. ✓ Pour les femmes, la grossesse et l'allaitement sont les seules activités déterminées par leur appartenance biologique au sexe féminin.
Source : Document de la Politique Nationale sur l'Egalité des Chances, l'Equité et le Genre (2009).	Source : Document de la Politique Nationale sur l'Egalité des Chances, l'Equité et le Genre (2009).	Source : Document de la Politique Nationale sur l'Egalité des Chances, l'Equité et le Genre (2009).

- ✓ La violence basée sur le genre est tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu'un et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes/filles et garçons. (Document de Stratégie Nationale de lutte contre les VBG, 2014).
- ✓ Acte qui s'exerce sur une personne sur la base de son statut social mis en rapport avec son sexe. Elle inclut :
 - Les actes qui infligent un préjudice et/ou une souffrance physique, mentale ou sexuelle,
 - La menace de tels actes,
 - La coercition et autres privations de liberté

2. LES TYPES DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

Six (06) types de VBG :

Le viol : Le viol au sens du code pénal en son article 403 se définit comme tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel imposé à autrui sans consentement en usant d'une autre partie du corps humain ou d'un objet, par violence, menace, contrainte ou surprise.... Également tout rapport sexuel avec ou sans le consentement d'un mineur de moins de 15 ans est considéré comme un viol.

Les agressions sexuelles : contact sexuel sans consentement ne débouchant pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration (Article 405 CP).

Les agressions physiques : formes de violence physique qui ne sont pas de nature sexuelle. (Article 381 CP).



Le mariage forcé : Tout mariage arrangé contre le gré de la personne concernée, sans son consentement personnel. **Le mariage précoce** est un mariage dans lequel au moins l'un des conjoints n'a pas l'âge requis par la loi 18 ans

Le déni de ressources, d'opportunités ou de services prend en compte les cas de déni de l'accès légitime à des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux.

La maltraitance psychologique /émotionnelle est l'infliction de douleurs ou de blessures mentales ou émotionnelles : les mauvais traitements verbaux non sexuels, insultants, dégradants ou avilissants... Exemples : menaces de violence physique ou sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux pour la personne



3. LES FACTEURS FAVORISANTS LES VBG

Inégalités de genre : Les VBG sont souvent le résultat de rapports de pouvoir inégaux entre les hommes et les femmes. Les normes patriarcales et sexistes légitiment la violence pour maintenir la domination masculine ;

Facteurs culturels : Les stéréotypes de genre, les attentes normatives concernant la féminité et la masculinité, et la perception de la famille comme une sphère privée sous l'autorité masculine contribuent à la violence ;

Facteurs économiques : La pauvreté et la dépendance économique des femmes peuvent les rendre plus vulnérables à la violence ;

Facteurs juridiques : L'absence de lois strictes contre les auteurs de VBG et la perception de la violence comme une honte pour la victime plutôt que pour l'agresseur aggravent le problème ;

Facteurs sociaux : L'abus d'alcool, la toxicomanie, et le manque de soutien social peuvent également augmenter les risques de VBG.

4. LES CONSÉQUENCES DES VBG SUR LES PERSONNES SURVIVANTES/ VICTIMES

Les blessures

Les handicaps
Les IST

Les grossesses forcées et non désirées

- Les fistules
- Les troubles psychologiques
- La mort
- La déscolarisation

III. INTRODUCTION AUX VIOLENCES DOMESTIQUES PLAN

1. DEFINITION DES VIOLENCES DOMESTIQUES
2. LES FORMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES
3. LES CAUSES DES VIOLENCES DOMESTIQUES
4. CONSEQUENCES DES VIOLENCES DOMESTIQUES
5. DIFFERENCE ENTRE LA VBG ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE

1. DEFINITION DES VIOLENCES DOMESTIQUES

Il y a violence domestique lorsqu'une personne essaie de contrôler, exerce ou menace d'exercer un pouvoir sur son partenaire dans une relation intime, au sein d'une relation familiale, conjugale ou maritale en cours ou dissoute.

En droit ivoirien, la violence domestique se définit comme étant tous les actes de violences qui surviennent :

- ✓ Au sein de la famille ou du foyer;
- ✓ Entre des anciens ou actuels conjoints ou concubins ou personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime.

2. LES FORMES DE VIOLENCES DOMESTIQUES

Violence physique (frapper, secouer, mordre, étrangler, bousculer) ;

Violence psychologique (menaces, humiliations, intimidations) ;

Violence sociale (privation d'autonomie, surveillance étroite des contacts, séquestration) ;

Violence sexuelle (harcèlement sexuel, contrainte à des actes sexuels, viol).

3. LES CAUSES DES VIOLENCES DOMESTIQUES

Les facteurs qui peuvent contribuer à la violence domestique sont:

- ✓ Expérimenter des traumatismes dans l'enfance
- ✓ Avoir certaines croyances sur la hiérarchie et la domination
- ✓ Avoir été témoin de violences domestiques dans l'enfance
- ✓ Mécontentement et insatisfaction conjugales
- ✓ Problèmes de communication au sein du couple
- ✓ La pandémie de COVID-19 a également contribué à l'augmentation des violences domestiques dans de nombreux pays.

4. LES CONSEQUENCES DES VIOLENCES DOMESTIQUES :

Les violences domestiques occasionnent des coûts pour les personnes touchées, mais aussi pour la société :

- ✓ coûts de la justice,
- ✓ de la police, coûts médicaux,
- ✓ assistance financière (aide sociale),
- ✓ consultations pour personnes subissant ou exerçant de la violence etc.

Par ailleurs, les violences domestiques ont des répercussions économiques en termes d'absences du travail, d'incapacité durable de travailler et ou de remplir les tâches domestiques.

5. DIFFERENCE ENTRE LA VBG ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE

La violence basée sur le genre (VBG) et la violence domestique sont deux concepts liés mais distincts.

- ✓ La VBG englobe tous les actes de violence dirigés contre une personne en raison de son sexe ou de son genre. Cela inclut les violences physiques, sexuelles,

psychologiques, émotionnelles et économiques¹. La VBG peut se manifester dans divers contextes y compris au sein de la famille, au travail, ou dans la communauté. Elle touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, mais peut également affecter les hommes et les garçons¹.

- ✓ La violence domestique, quant à elle, se réfère spécifiquement aux actes de violence qui se produisent au sein du foyer ou entre partenaires intimes. Elle peut inclure des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques, et peut être perpétrée par un conjoint, un partenaire, un membre de la famille ou une personne vivant sous le même toit². La violence domestique est une forme de VBG lorsqu'elle est motivée par des dynamiques de pouvoir et de contrôle basées sur le genre³.

- ✓ En résumé, la VBG est un terme plus large qui inclut la violence domestique, mais aussi d'autres formes de violence liées au genre dans divers contextes.

IV. LA LOI N°430-2014 DU 14 JUILLET 2014 PORTANT REGIME DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE REPRESSION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Cette loi comporte 58 Articles et est subdivisée en 3 grandes parties :

- ✓ la prévention,
- ✓ la protection,
- ✓ la répression.

1. LES PRINCIPES DE LA PREVENTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA

Consentement libre et éclairé : le patient de plus de 16 ans avec toutes ses facultés mentales doit donner son accord (Art 3). Cependant, un moins de 16 ans en état de grossesse peut se soumettre librement et volontairement au test de dépistage en ce sens que l'Etat fait obligation au prestataire de proposer le test à la femme enceinte (Art 9)

Confidentialité : le médecin, la sage femme ou la conseillère ne révélera pas le résultat du test sans l'avis du patient (Art 5). Toutefois après 3 mois, le patient devra révéler son statut sérologique à son ou ses partenaires avec l'aide du prestataire de santé pour éviter les représailles (Article 11 et 12)

2. LA PROTECTION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA

- ✓ Tout rejet ou tout refus de soins médicaux à une personne vivant avec le VIH est interdit; Art 18
- ✓ Le dépistage, la prescription des ARV ainsi que les analyses sont gratuites; Art 26
- ✓ La personne vivant avec le VIH a droit à l'emploi; Art 30.

3. LA REPRESSION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA

Il existe 4 catégories d'infractions :

- ✓ Les infractions liées à la transmission du VIH ;
- ✓ Les infractions liées aux injures basées la séropositivité supposée ou avérée d'une personne
- ✓ Le refus de soins à l'égard d'une personne vivant avec le VIH et les diffusions mensongères sur le traitement ou les préservatifs ;
- ✓ Les infractions liées au personnel de santé ; L'abus de faiblesse.

Les infractions liées à la transmission du VIH

Celui qui par imprudence, inattention, maladresse, provoque l'infection d'autrui au VIH, est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs (Art 50).

Les infractions liées aux injures basées la séropositivité supposée ou avérée d'une personne

L'auteur d'injures, de dénigrement ou de discours haineux à l'endroit d'une personne fondée sur la séropositivité avérée ou supposée est passible d'un emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs. Art 52

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des participants à l'atelier de révision des documents de formations

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT
01	Pr EHUI Eboi	DC	PNLS	
02	Dr LADJI NAZAGUEHI PATRICE	DCA	PNLS/	0757579359
03	GNAHOU GLAZAHI DOMINIQUE	ENSEIGNANT	INFAS ABIDJAN	0707396567
04	BOHOUSSOU KONAN	CHEF ANTENNE	INFAS AGBOVILLE	07 07 96 75 37
05	AIDEGO BENOIT	ENSEIGNANT	INFAS ABIDJAN	0707 67 79 10 aidegobenoit@yahoo.fr
06	Dr OUATTARA POGADJODORY	MEDECIN	CHU DE BOUAKE	0707096994 Pogacuat79@gmail.com
07	Dr KOUAME KONAN Blaise	MEDECIN	PNLS	0708047279 Kouame.blaise@pnls-ci.com
08	Dr DEMBELE FASSERY	MEDECIN	USAC/HDJ	0748603987 dembefassery@yahoo.fr
09	KOBENAN DOMBRODA FELIX	ENSEIGNANT	INFAS ABIDJAN	0707 08 18 78 dombroda@gmail.com felix.kobenan@infas.edu.ci
10	KOFFIE KOFFI KRA FRANCOIS	ENSEIGNANT	INFAS ABENGOUROU	07 08 34 34 25
11	KOFFI KONAN MARCEL	Membre PNLS	PNLS	0708047279
12	NIANGARA MASSOU CINTHIA	ENSEIGNANT	INFAS ABOISSO	0708944916
13	NIAMIEN KOUADIO EMMANUEL	ENSEIGNANT	INFAS BOUAKE	0101154702
14	ADOI KOFFI	COORDONNATEUR DES STAGES	INFAS ABOISSO	07 75 63 53 adoikomoe@gmail.com
16	YAO GOLLY ERNEST	ENSEIGNANT	INFAS KORHOGO	ygolly@yahoo.fr 03 42 40 71
17	KOUASSI YAO	ENSEIGNANT	INFAS KORHOGO	0749601144

N°	NOM ET PRENOMS	FONCTION	STRUCTURE	CONTACT
18	KOFFI KOYE MARCELLIN	ENSEIGNANT	INFAS DALOA	07 48 53 71 26
19	COULIBALY BASSIDIGUI	ENSEIGNANT	INFAS DALOA	07 48 89 85 78
20	KOFFI NEE AMANI AYA CECILE	ENSEIGNANT	INFAS BOUAKE	07 07 24 00 79
21	KOFFI KOYE MARCELLIN	ENSEIGNANT	INFAS DALOA	07 48 53 71 26
22	OTROU ZOHONON CECILE EPOUSE BOKA	ENSEIGNANTE	INFAS ABIDJAN	07 77 89 79 15
23	BROU KOUAME FELIX	ENSEIGNANTE	INFAS MAN	07 47 91 06 90
24	YAO AHOU ROSE	MEMBRE PNLS	PNLS	05 84 53 74 55
25	KOMAN VICTOR ANTHEME	ENSEIGNANT	INFAS ABENGOUROU	07 79 74 24 25
26	Dr ZOULO TOUALI	ENSEIGNANT	INFAS ABIDJAN	07 07 86 63 02
27	Dr NATHALIE KROU DANHO	MEDECIN	I-TECH CIV	05 04 01 41 41
28	Dr DIKOURI LOGNON ANNIE	MEDECIN	I-TECH CIV	05 56 09 97 80
29	Dr KOUADJALE DJAHOURY	MEDECIN	I-TECH CIV	05 59 39 93 47
30	TETCHI MATILDE	MEMBRE PNLS	PNLS	07 07 06 92 13

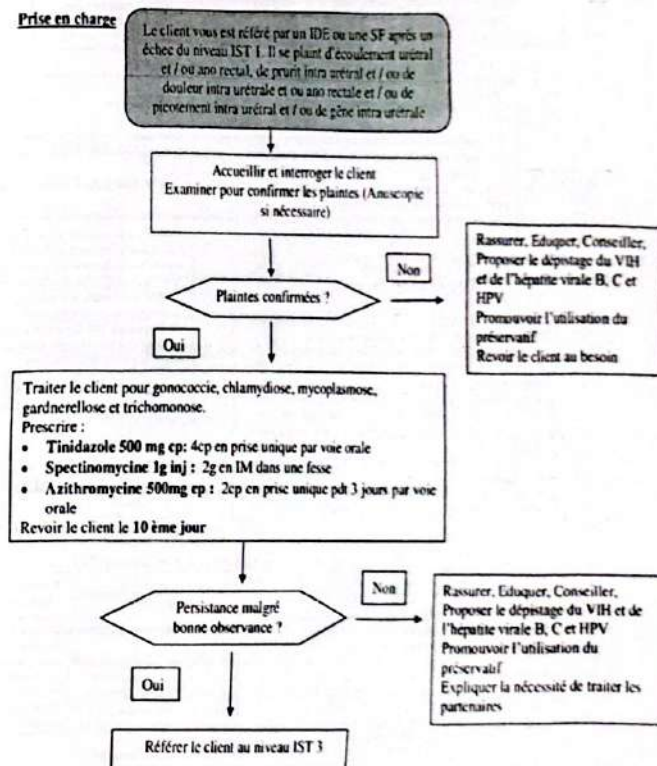
Annexe 2 : Algorithme de prise en charge syndromique des IST

ÉCOULEMENT URETRAL ET OU ANORECTAL CHEZ L'HOMME

Niveau IST 1 avec compétence médicale

Définition : Un écoulement urétral et/ou ano-rectal est une sécrétion anormale provenant de l'urètre et/ou de l'anus accompagnée ou non de prurit, et/ou douleur ano-rectale, et/ou brûlure mictionnelle. Ces signes peuvent remplacer la sécrétion.

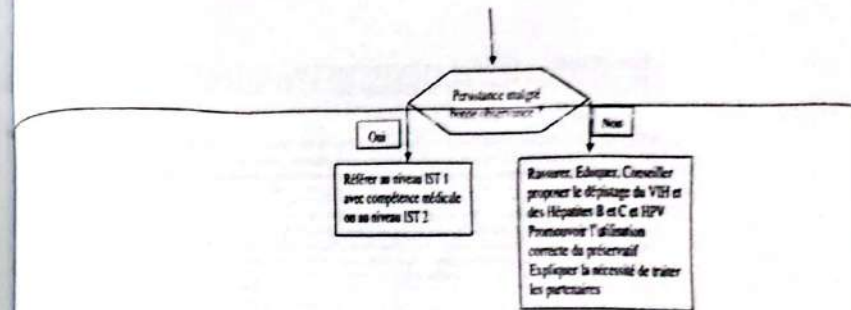
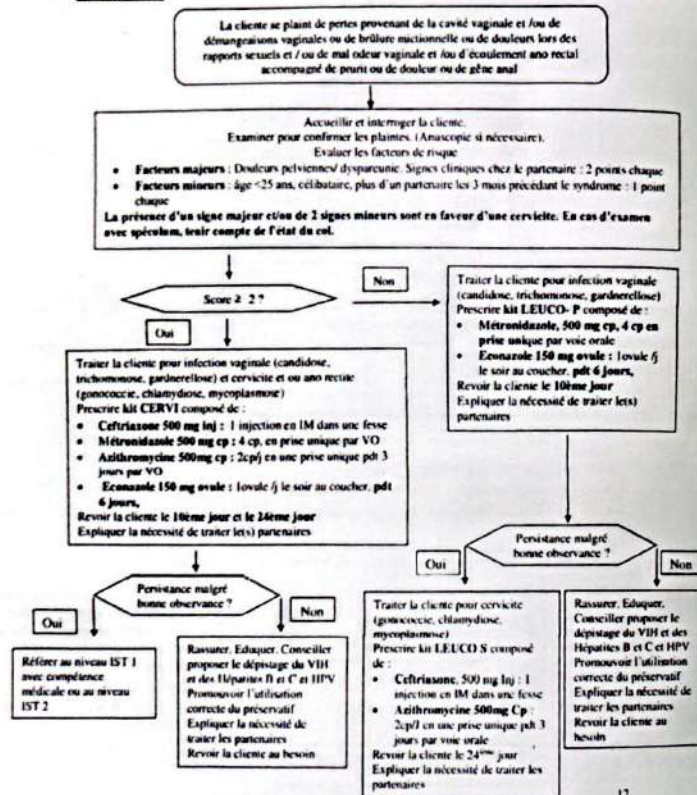
Prise en charge



ÉCOULEMENT VAGINAL ET/OU ANORECTAL CHEZ LA FEMME NON ENCEINTE Niveau IST1

Définition : Une sécrétion anormale (par sa quantité, sa couleur ou son odeur) provenant de la cavité vaginale ou du col de l'utérus accompagnée ou non de prurit, de dysurie ou de brûlure mictionnelle et/ou de sécrétion de la région ano rectale, accompagnée ou non de prurit, ou de douleur ou de gêne anale.

Prise en charge



NB :

1 - Dans tous les cas :

- Éducation et conseils (CCC, Commenter l'ordonnance)
- Si allergie et/ou contre-indication à l'une des molécules, référer au niveau supérieur
- Pas de consommation d'alcool
- En cas de positivité du VIH et/ou VHB, VHC, HPV référer le client dans les structures spécialisées pour la prise en charge
- Encourager à devenir pair éducateur
- Chez les Travailleuses du sexe (TS), proposer une visite médicale mensuelle de suivi et appliquer l'algorithme de la cervicite

2 - Chez l'enfant (<15 ans)

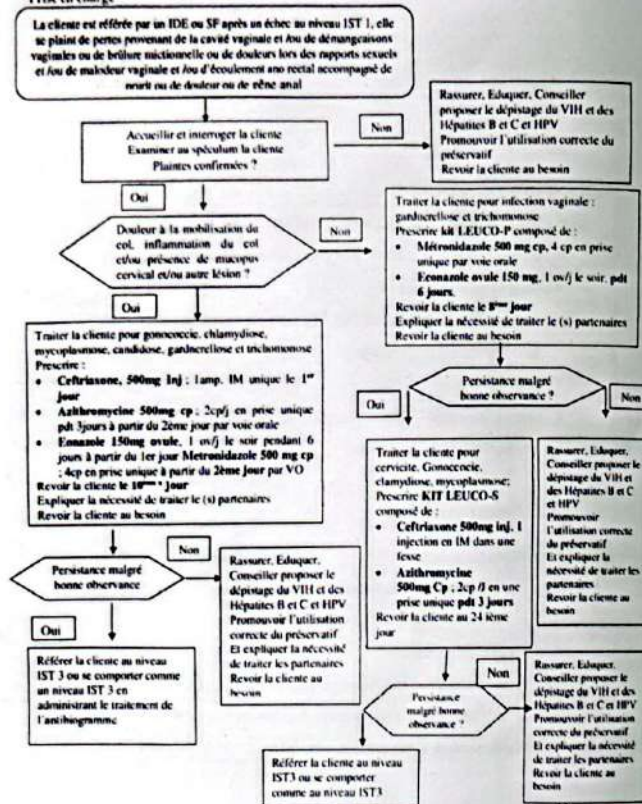
- Prescrire :
 - Ceftriaxone, 50 mg/kg de poids sans dépasser 250 mg
 - Azithromycine, 50mg/kg/j sans dépasser 1g/j.
- En cas d'échec, prescrire :
 - Métronidazole, 50mg/kg/j en prise unique et
 - Erythromycine, 50 mg/kg/j en deux prises pendant 14 jours
- En cas de deuxième échec, référer au niveau IST2 et 3

ÉCOULEMENT VAGINAL ET/OU ANORECTAL CHEZ LA FEMME NON ENCEINTE

Niveau IST1 avec compétence médicale

Définition : Une sécrétion anormale (par sa quantité, sa couleur ou son odeur) provenant de la cavité vaginale ou du col de l'utérus accompagnée ou non de prurit, de dysurie ou de brûlure mictionnelle et/ou de sécrétion de la région ano rectale accompagnée ou non de prurit, ou de douleur ou de gêne anale

Prise en charge

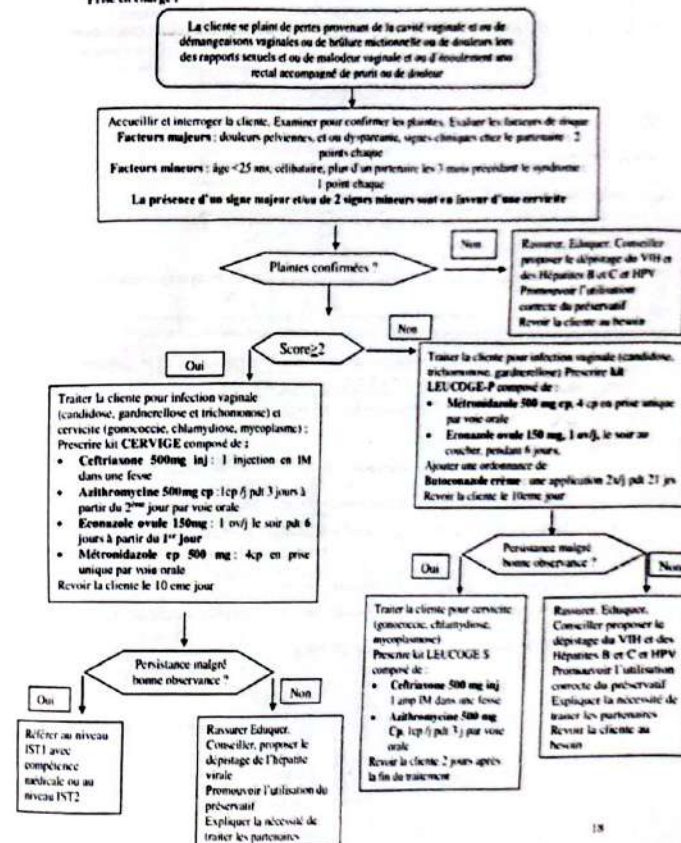


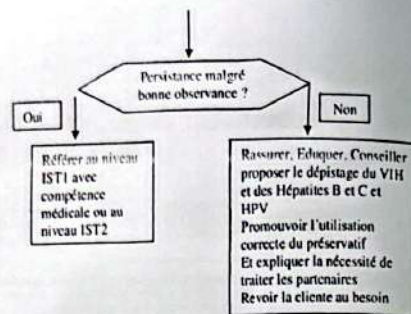
ÉCOULEMENT VAGINAL ET/OU ANORECTAL CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Niveau IST1

Définition : Une sécrétion anormale (par sa quantité, sa couleur ou son odeur) provenant de la cavité vaginale ou du col de l'utérus accompagnée ou non de prurit, de dysurie ou de brûlure mictionnelle et/ou de sécrétion de la région ano rectale accompagnée ou non de prurit, ou de douleur ou de gêne anale

Prise en charge :





NB:

1) Dans tous les cas :

- Education et conseils (CCC*, Commenter l'ordonnance)
- Si allergie et/ou contre-indication à l'une des molécules, référer au niveau supérieur
- Pas de consommation d'alcool
- En cas de positivité du VIH et/ou VHB, VHC, HPV référer le client dans les structures spécialisées pour la prise en charge
- Encourager à devenir pair éducateur
- Chez les Travailleuses du sexe (TS), proposer une visite médicale mensuelle de suivi et appliquer l'algorithme de la cervicite

2 - Chez l'enfant (<15 ans)

- Prescrire,
 - Ceftriaxone : 50 mg/kg de poids sans dépasser 250 mg en IM
 - Azithromycine : 50 mg/kg/j à partir du 1^{er} jour pendant 3 jours par voie orale
- En cas d'échec, prescrire :
 - Métronidazole 50mg/kg/j en prise unique par voie orale
 - Erythromycine 50 mg/kg/j en deux prises pendant 7 jours juste avant le repas par voie orale
- En cas de deuxième échec, référer au niveau IST 2 ou 3

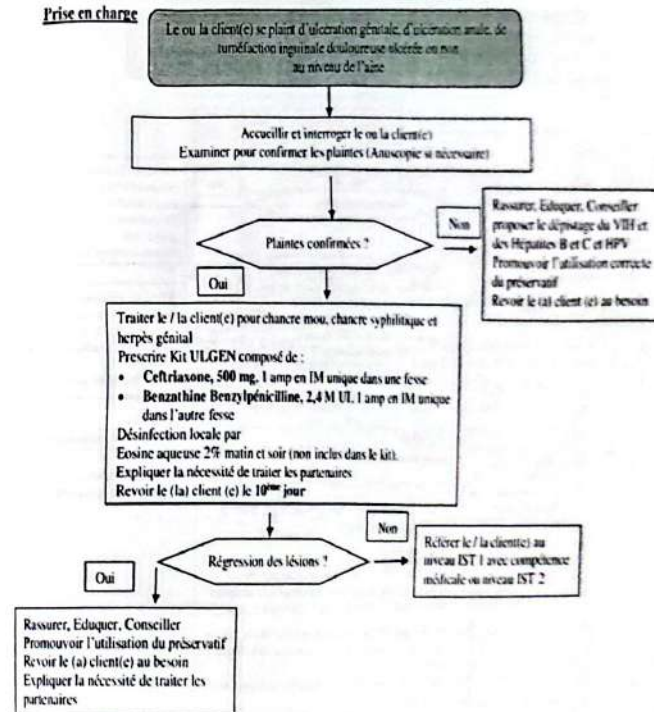
ULCERATION GENITALE ET/OU ANORECTALE ET/OU BUBON

Niveau IST1

Définitions

- **Ulcération génitale** : c'est une solution de continuité non traumatique localisée sur la peau ou sur les muqueuses des organes génitaux externes et / ou la région anorectale chez l'homme ou la femme enceinte ou non.
- **Bubon** : c'est une hypertrophie inflammatoire des ganglions de la région inguinale.

Prise en charge



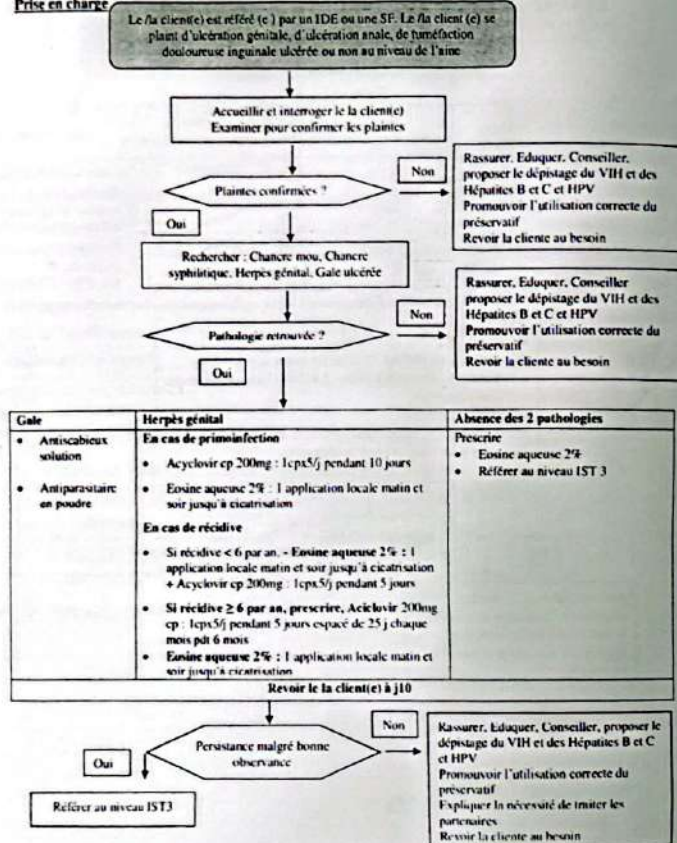
ULCERATION GENITALE ET OU ANORECTALE ETOU BUBON

Niveau IST1 avec compétence médicale

Definitions

- Ulcération génitale** : c'est une solution de continuité (non traumatique) localisée sur la peau ou les muqueuses des organes génitaux externes chez l'homme ou la femme enceinte ou non.
- Bubon** : c'est une hypertrophie inflammatoire des ganglions de la région inguinale.

Prise en charge

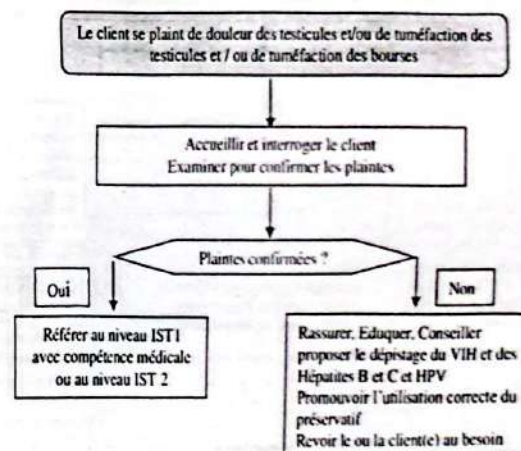


DOULEURS TESTICULAIRES

Niveau IST1

Définition : C'est une manifestation douloureuse des testicules avec ou sans tuméfaction des testicules.

Prise en charge

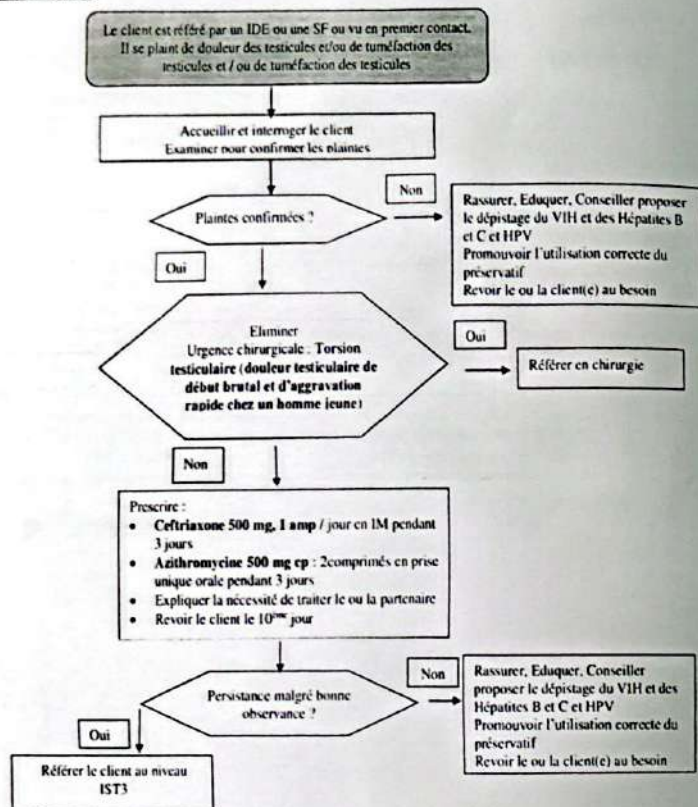


DOULEURS TESTICULAIRES

Niveau IST1 avec compétence médicale

Définition : c'est une manifestation douloureuse des testicules avec ou sans tuméfaction des testicules

Prise en charge

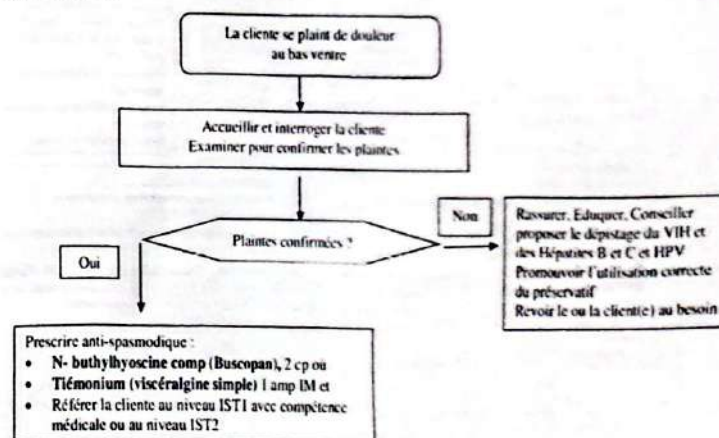


DOULEUR ABDOMINALE BASSE CHEZ LA FEMME NON ENCEINTE

Niveau IST1

Définition : C'est une manifestation douloureuse pelvienne chez la femme

Prise en charge

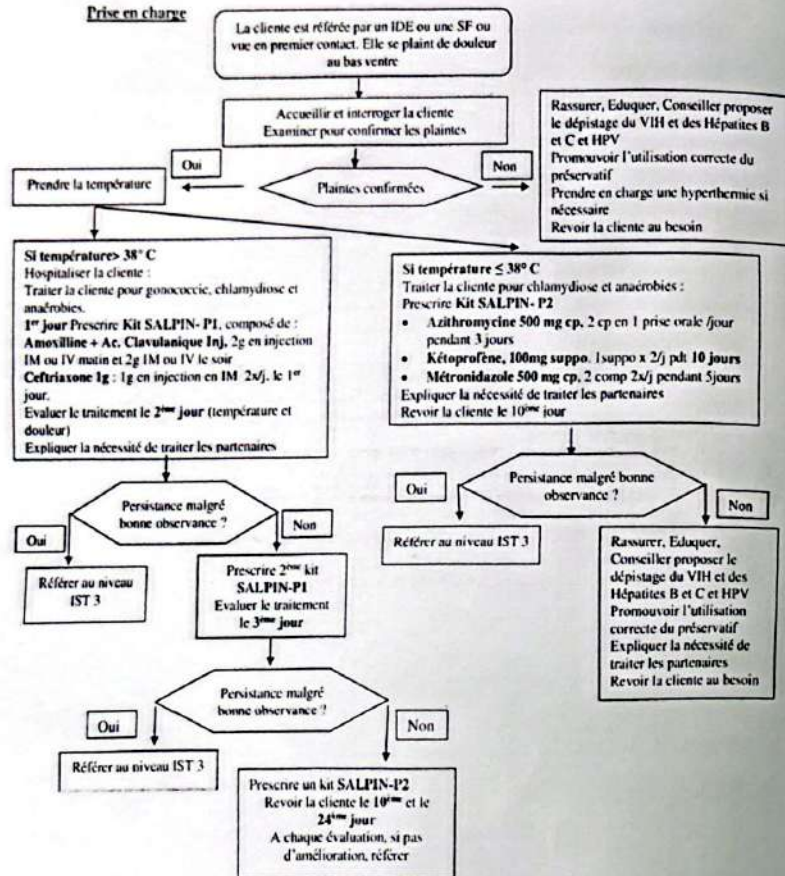


DOULEUR ABDOMINALE BASSE CHEZ LA FEMME NON ENCEINTE

Niveau IST1 avec compétence médicale

Définition : Manifestation douloureuse pelvienne chez la femme qui ne signale pas d'améliorée

Prise en charge



CONJONCTIVITE DU NOUVEAU-NE ; Prévention

Niveau IST1, IST2, IST3

Définition : c'est une inflammation des conjonctives avec ou sans sécrétions chez l'enfant de 1 à 28 jours

Prévention de la conjonctivite du nouveau-né

Niveau IST1, IST2 et IST3.

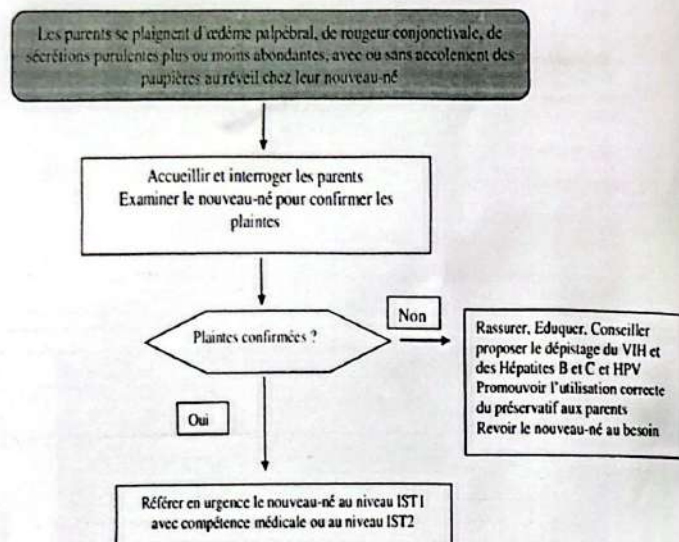
Prescrire systématiquement chez tout nouveau-né un antiseptique oculaire :
Rifamycine collyre ou un antibiotique oculaire : 1 goutte dans chaque œil immédiatement après la naissance

CONJONCTIVITE DU NOUVEAU-NE

Niveau IST1

Définition : c'est une inflammation des conjonctives avec ou sans sécrétions chez l'enfant de 1 à 28 jours

Prise en charge



N.B. :

Dans tous les cas :

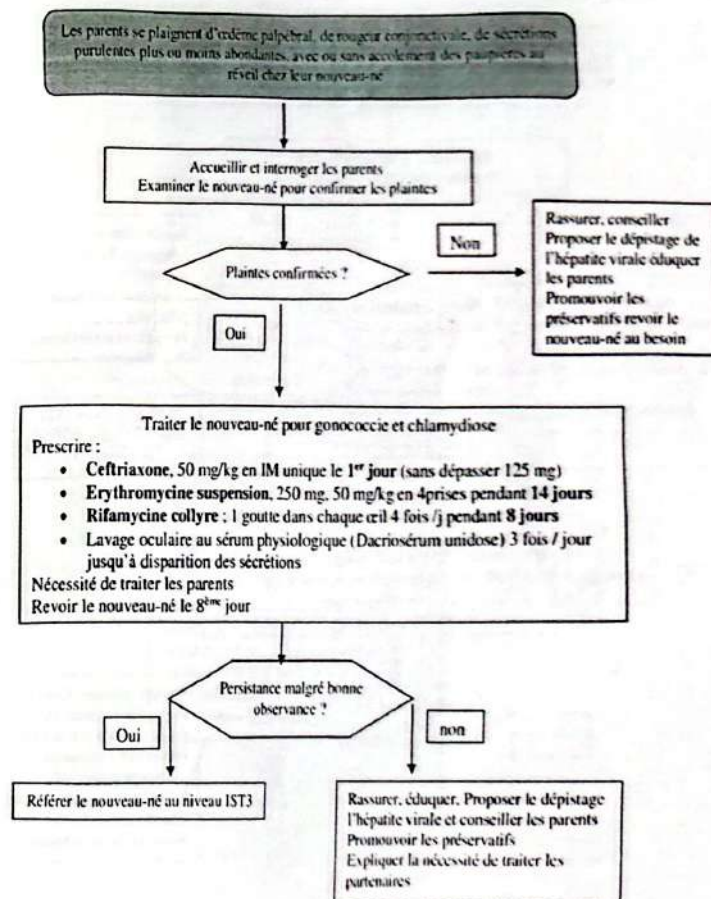
- Education et conseils (CCC*, Commenter l'ordonnance) au père et à la mère
- Nécessité de traitement des parents

CONJONCTIVITE DU NOUVEAU-NE

Niveau IST1 avec compétence médicale

Définition : c'est une inflammation des conjonctives avec ou sans sécrétions chez l'enfant de 1 à 28 jours

Prise en charge

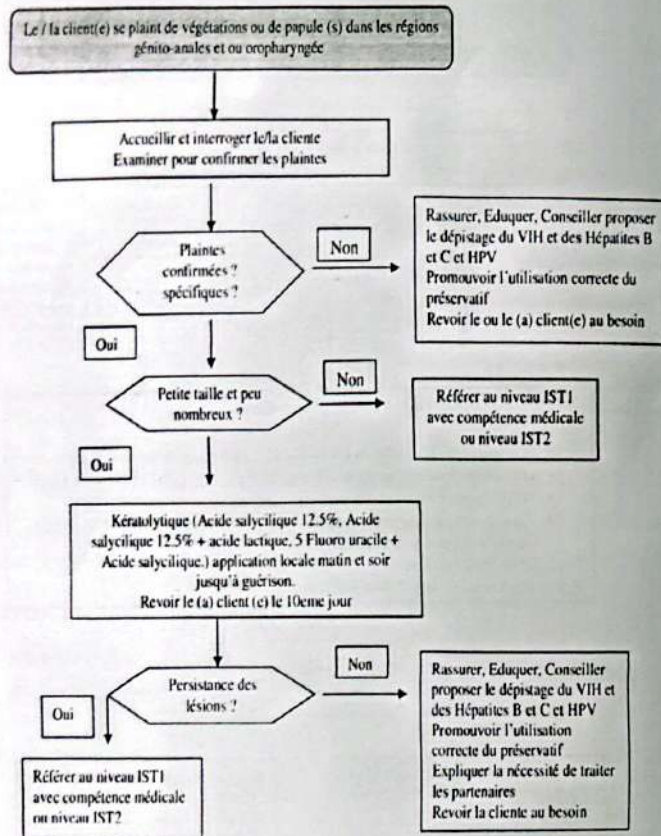


CONDYLOMES ACUMINES OU CRETES DE COQ

Niveau IST1

Définitions : C'est une excroissance cutanée ou muqueuse de la région génito-anale et ou oropharyngée ressemblant à une crête de coq et due à un virus (VHP)

Prise en charge

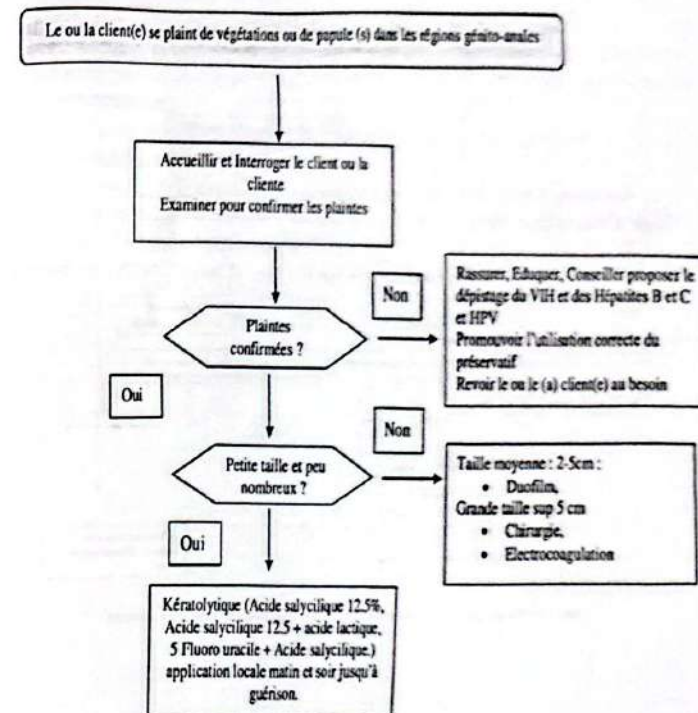


CONDYLOMES ACUMINES OU CRETES DE COQ

Niveau IST 1 avec compétence médicale, et Niveau IST 2

Définitions : C'est une excroissance cutanée ou muqueuse de la région génito anale ressemblant à une crête de coq et due à un virus, chez l'homme ou la femme.

Prise en charge



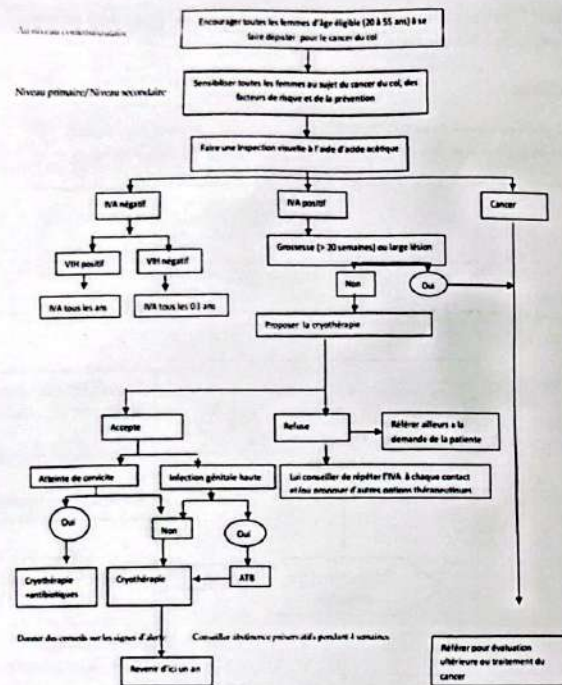


Figure 14 : Graphique d'évolution modèle pour la Prévention du cancer du col chez la femme

1. Fiche d'identification et de prélèvement

Elle est utilisée :

- pour collecter les informations d'identification de l'enfant (le numéro DBS, le numéro site de l'enfant, sa date de naissance, son site de provenance, la structure d'enrôlement, le type d'allaitement)
- Pour collecter les informations sur le traitement reçu par l'enfant et la mère, si l'information est disponible.
- Pour accompagner l'échantillon prélevé et permet de recueillir les informations de laboratoire précisant la catégorie de test à effectuer sur l'échantillon prélevé et le motif, s'il s'agit d'un second prélèvement.

Elle doit être remplie par l'agent de santé qui réalise le prélèvement sur DBS.

Diagnostic précoce du VIH chez les enfants

DBS / PCR

Fiche de Prélèvement et d'Identification

IDENTIFIANT DEM 01. Date interview (jj mm année) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

IDENTIFIANT DEM 02. Statut VIH de la mère
1 - VIH 1 2 - VIH 2 3 - VIH 1+2 4 - VIH-PCR 5 - Inconnu

IDENTIFIANT DEM 03. Provenance de l'enfant
1 - PTMB 2 - Vaccination 3 - Pouchon 4 - Enfants 5 - Autres (Spécifier)

IDENTIFIANT DEM 04. Si TEST 03 - autre, spécifier

IDENTIFIANT DEM 05. Code du Site ☐ ☐ ☐

IDENTIFIANT DEM 06. Nom du Site

IDENTIFIANT DEM 07. Numéro DBS de l'enfant DBS - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

IDENTIFIANT DEM 08. Numéro d'identification Site de l'enfant

IDENTIFIANT DEM 09. Numéro de Laboratoire
L'inscrire une fois par Laboratoire

Informations de l'Enfant

IDENTIFIANT DEM 10. Date de naissance (jj mm année) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

IDENTIFIANT DEM 11. Age (en mois) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

IDENTIFIANT DEM 12. Sexe
1 - Masculin 2 - Féminin

Informations prélevement

IDENTIFIANT LAB 1. Quelle PCR ?
1 - 1^{re} PCR 2 - 2^e PCR

IDENTIFIANT LAB 2. Raison pour une seconde PCR
1 - PCR en confirmation de la 1^{re} PCR positive
2 - PCR à nouveau après arrêt d'allaitement
3 - PCR après résultat indécis
4 - Non applicable pour une 1^{re} PCR

IDENTIFIANT LAB 3. Nom du demandeur

IDENTIFIANT LAB 4. Nom du préleveur

☐ ☐ ☐
Intervention

☐ ☐ ☐
Vérification

☐ ☐ ☐
Lettre

☐ ☐ ☐
Délivrée

Informations de l'Enfant (suite)

IDENTIFIANT DEM 13. Allaitement maternel
1 - Allaitement exclusif 2 - Allaitement mixte 3 - Allaitement non exclusif 4 - Allaitement non mixte 5 - Allaitement non exclusif non mixte 6 - Allaitement non exclusif non mixte

IDENTIFIANT DEM 14. L'enfant est-il symptomatique ?
1 - Oui 2 - Non

Antécédents de traitements, PTME et Autres

IDENTIFIANT DEM 15. ARV reçu par la mère
1 - Oui 2 - Non 3 - Oui 4 - Non 5 - Oui 6 - Non

IDENTIFIANT DEM 16. Si OAT, spécifier

IDENTIFIANT DEM 17. La mère est-elle sous cotrimoxazole ?
1 - Oui 2 - Non

IDENTIFIANT DEM 18. Prophylaxie ARV de l'enfant
1 - AZT-NVP 2 - NVP seule unique 3 - Autres 4 - Inconnu

IDENTIFIANT DEM 19. Si autres, spécifier

IDENTIFIANT DEM 20. L'enfant est-il sous cotrimox ?
1 - Oui 2 - Non

☐ ☐ ☐
Intervention

☐ ☐ ☐
Vérification

☐ ☐ ☐
Lettre

☐ ☐ ☐
Délivrée

Fiche d'Identification et de demande d'examen

2. Registre PTME de suivi mère-enfant

Il devra contenir toutes les informations concernant :

- ✓ la date,
- ✓ le numéro DBS de l'enfant,
- ✓ le nom de l'enfant,
- ✓ la date de naissance de l'enfant,
- ✓ la date de collecte,
- ✓ les différents résultats de PCR et des tests rapides,
- ✓ les informations sur le suivi de l'enfant.

Ce registre doit rester sur le site..

Les informations recueillies dans le registre PTME de suivi mère-enfant sont collectées de façon linéaire par enfant et doivent faire l'objet d'une grande confidentialité. L'archivage doit être sécurisé.

3. Liste de transmission et de non-conformité

La liste de transmission et de non-conformité est utilisée par le personnel de site de collecte qui expédie les prélèvements DBS et le laboratoire qui les reçoit.

- ✓ Elle permet de vérifier que tous les DBS et les fiches (identification et prélèvement) ont été acheminés
- ✓ Elle sert à notifier aux sites les prélèvements sur lesquels il est impossible de réaliser le test de laboratoire.
- ✓ Elle doit être visée par l'expéditeur sur le site de la collecte, le transporteur et le technicien de laboratoire.

4. Fiche de résultat

La fiche de résultat sert au retour des résultats sur le site.

La fiche de résultat est imprimée par le secrétariat du laboratoire, ensuite elle est vérifiée et signée par le responsable du laboratoire avant la transmission sur le site.

Après la réception des échantillons, le laboratoire dispose, normalement, d'un délai de deux semaines pour analyser et rendre les résultats aux sites.

Les fiches de résultat sont récupérées par la personne chargée d'acheminer les échantillons au laboratoire.

Annexe 4 : Documents consultés

1. Directives 2015 de prise en charge des personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, PNLS 2015

2. Directives 2015 de mise sous antirétroviraux a vie des femmes enceintes infectées par le VIH/SIDA dans le cadre de la prévention de la transmission Mère-Enfant du VIH en Côte d'Ivoire, PNLS 2015
3. Document National de Normes, Politique et Procédures des Services de dépistage du VIH en Côte d'Ivoire. Edition 2016.
4. Framework For National Certification Program For HIV And Other Point Of Care Testing Ensuring the Reliability and Accuracy of Point of Care Test Results, WHO 2016
5. Loi No 2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et Sida, journal officiel de Côte d'Ivoire Numero spécial 15 juillet 2014.
6. Manuel de référence Prévention et traitement de l'infection à VIH. Edition 2017
7. Manuel de référence co-infection TB-VIH 2008
8. Manuel de référence en formation Soins Palliatifs pour les professionnels de la santé
9. Manuel de référence en CDV
10. Manuel de référence en CDIP
11. Manuel de référence en Santé Positive, Dignité et Prévention pour les communautaires
12. Manuel de Normes et Procédures Techniques pour prévention de la transmission Mère-Enfant du VIH, PNLS 2015
13. Memento thérapeutique du VIH/Sida en Afrique 2009
14. Guide de PEC de l'infection VIH pédiatrique
15. Recommendations to assure HIV testing quality, WHO 2015.